

HumsYar

H U M S Y A R

آموزش پزشکی

جزوه جامع امتحانی

جزوه جامع فیزیک پزشکی

تلفیق جزوه‌ها، پاورپوینت‌ها و ویدیوهای اساتید

دکتر افضلی‌پور · دکتر لیلی درویش · دکتر حق‌پرست

۸۸

شکل

۹

فصل / جلسه

۱۳۰

صفحه

جزوه‌ای برای مرور دو روزه پیش از امتحان – همه مطالب با ذکر منبع، مطابق جزوه، اسلاید و ویدیوی همان جلسه

فهرست مباحث

صفحه ۵ تا ۱۱	مبانی فیزیک پزشکی و طبقه‌بندی پرتوها دکتر رضا افضلی‌پور	۱
صفحه ۱۳ تا ۲۲	تولید پرتو ایکس و ساختمان لامپ دکتر رضا افضلی‌پور	۲
صفحه ۲۴ تا ۳۹	تشکیل تصویر رادیوگرافی، فلوروسکوپی و سی‌تی‌اسکن دکتر رضا افضلی‌پور	۳
صفحه ۴۱ تا ۵۴	رادیواکتیویته، واپاشی‌ها و پزشکی هسته‌ای دکتر حق‌پرست	۴
صفحه ۵۶ تا ۵۹	واحدهای سنجش پرتو و دزیمتری دکتر حق‌پرست	۵
صفحه ۶۱ تا ۷۴	حفاظت در برابر پرتو دکتر حق‌پرست	۶
صفحه ۷۶ تا ۹۱	فیزیک سونوگرافی و اولتراسوند دکتر حق‌پرست	۷
صفحه ۹۳ تا ۱۱۲	رادیوبیولوژی و اثرات زیستی پرتوها دکتر لیلی درویش	۸
صفحه ۱۱۴ تا ۱۳۰	تصویربرداری تشدید مغناطیسی (MRI) دکتر لیلی درویش	۹

راهنمای مطالعه: دکتر درویش

استاد اعلام کرده‌اند فقط مباحث زیر در امتحان می‌آید؛ بقیه مطالب ایشان در این جزوه به صورت کامل آمده است ولی در امتحان نیست. در سرتیتر بخش‌های امتحانی، نشان «در امتحان می‌آید» و در بخش‌های دیگر مطالب ایشان نشان خاکستری «خارج از حذفیات امتحان – برای مطالعه تکمیلی» درج شده است.

مبحث امتحانی	فصل / جلسه	صفحه‌های همین PDF	منبع اصلی (فایل، اسلاید/ صفحه، زمان ویدیو)
اثرات تصادفی و غیرتصادفی (Stochastic and non-stochastic effect)	فصل ۸ – بخش‌های ۳ تا ۵ (اثرات احتمالی/قطعی، پاسخ خطی بدون آستانه، سندروم‌های حاد)	صفحه ۹۳	اسلایدهای درویش ص ۵ تا ۱۳؛ ویدیو رادیوبیولوژی ۱ و ۲ (زمان‌ها پس از ترنسکرپت)
برهم‌کنش مستقیم و غیرمستقیم، آسیب بیولوژیک در کروموزوم (Direct and indirect action, Biological damage in chromosome)	فصل ۸ – بخش‌های ۸ تا ۱۲	صفحه ۹۷	اسلایدهای درویش ص ۱۵ تا ۳۰ و ص ۷۴؛ ویدیو رادیوبیولوژی ۱ تا ۳ (زمان‌ها پس از ترنسکرپت)
کنتراست بافت‌های مختلف در تصاویر MRI	فصل ۹ – بخش‌های ۹ تا ۱۱	صفحه ۱۲۱	اسلایدهای MRI درویش ص ۳۴ تا ۵۱؛ ویدیوهای ۱ MRI تا ۳ (زمان‌ها پس از ترنسکرپت)

ترتیب پیشنهادی مرور دو روزه: ابتدا سه مبحث امتحانی بالا را از فصل‌های ۸ و ۹ بخوانید، سپس «مرور سریع» پایان هر فصل و در آخر جدول‌های جمع‌بندی و فرمول‌های کلیدی را دوره کنید.



فصل ۱

مبانی فیزیک پزشکی و طبقه‌بندی پرتوها

دکتر رضا افضلی‌پور

صفحه‌های ۵ تا ۱۱

۴

جدول

۴

شکل

۴۱

بخش

۱. تعریف تشعشع

«رادییشن» یا تشعشع به طور کلی به انتشار انرژی از خلاء و ماده گفته می‌شود. این انرژی به دو صورت اصلی منتقل می‌شود: به صورت ذرات (Particles) و به صورت امواج الکترومغناطیس (Electromagnetic Waves).

منبع: جزوه فیزیک تشعشع و پزشکی هسته‌ای – دکتر حق‌پرست ص ۴؛ اسلایدهای M.Ph.D – دکتر حق‌پرست اسلاید ۲

تعریف اسلاید: «انتقال انرژی به صورت ذرات یا امواج الکترومغناطیس» (Transmission of energy as particles or as electromagnetic waves).

منبع: اسلایدهای M.Ph.D – دکتر حق‌پرست اسلاید ۲

- برخی پرتوها دارای جرم اند (ذره‌ای) و برخی فاقد جرم (الکترومغناطیس).
- بر پایه میزان انرژی، پرتوها دارای قدرت نفوذ در ماده هستند.

منبع: جزوه دکتر افضل‌پور ص ۲۲

۲. طبقه‌بندی پرتوها: یونیزان و غیر یونیزان

پرتوها به دو دسته پرتوهای یونیزان (یون‌ساز) و پرتوهای غیر یونیزان (غیر یون‌ساز) طبقه‌بندی می‌شوند. معمولاً وقتی همراه با واژه «پرتو» کلمه دیگری به کار نرود، منظور پرتوهای یونیزان است.

منبع: جزوه دکتر افضل‌پور ص ۲۲



شکل – اثرات بیولوژیکی پرتوهای یونیزان

اسلایدهای رادیوبیولوژی – دکتر درویش – ص ۲

- پرتوهای یونیزان: پرتوهایی که موجب یونیزه شدن اتم می‌شوند.
- پرتوهای غیر یونیزان: پرتوهایی که قادر به یونیزه کردن اتم نیستند؛ مانند نور مرئی، پرتوهای فروسرخ و فرابنفش و لیزر.

منبع: جزوه دکتر افضل‌پور ص ۲۲



شکل – طیف الکترومغناطیس و جایگاه پرتوهای یونیزان: اشعه ایکس و گاما در ناحیه پرنرژی طیفاند و پرتوهای غیر یونیزان (فرابنفش، نور مرئی، مادون قرمز، میکروویو و رادیوفروکونسی) در ناحیه کم انرژی قرار دارند.

اسلایدهای دکتر افصلی پور – ص ۲۰ «طیف الکترومغناطیس»

Types of Ionizing Radiation

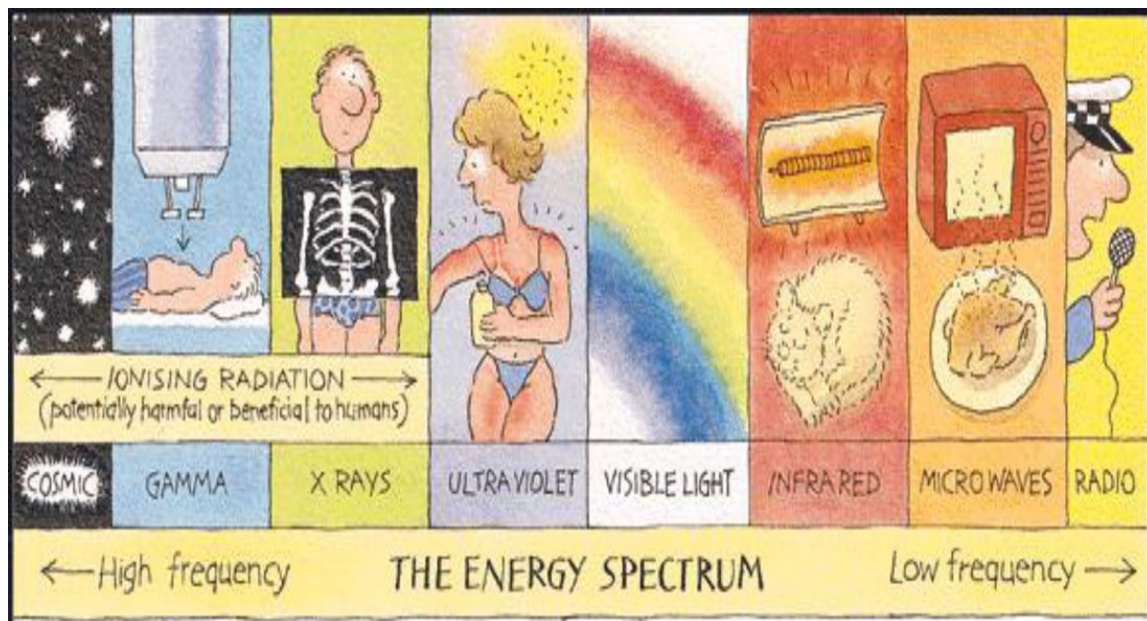
شکل – انواع پرتوهای یونیزان: ذرات آلفا، بتا و نوترون در کنار پرتوهای الکترومغناطیس (ایکس و گاما) با جرم، بار و قدرت نفوذ متفاوت.

اسلایدهای M.Ph.D – ص ۱۹

دسته	زیرگروه	نمونه‌ها
یونیزان	غیرذره‌ای	X و γ
یونیزان	ذره‌ای	p, e, n, β, α
غیریونیزان	—	فروسرخ، نور مرئی، فرابنفش، لیزر

منبع: جزوه دکتر افصلی پور ص ۲۳

- پرتوهای یونیزان با عبور از محیط، ذرات باردار منفی و مثبت تولید می‌کنند.
- منابع مولد پرتوهای یونیزان: پرتو ایکس، انرژی هسته‌ای و زباله‌های ساخت بشر، یا پرتوهای کیهانی حاصل از خورشید و مواد رادیواکتیو پسته زمین (به صورت ذره یا انرژی خالص بدون جرم و بار الکتریکی).
- برخی از این پرتوها: آلفا، بتا، X، γ و
- پرتوهای یونیزان مستقیم از لحظه برخورد با ماده به آن انرژی منتقل می‌کنند و باعث تولید یون می‌شوند.
- پرتوهای یونیزان غیرمستقیم باید حتماً مستقیماً به الکترون‌ها برخورد کنند تا انرژی‌شان را از طریق الکترون به ماده منتقل کنند.



شکل - نمای طیف انرژی از امواج رادیویی تا پرتوهای گاما همراه با طول موج هر ناحیه (THE ENERGY SPECTRUM).

اسلایدهای M.Ph.D - ص ۵

۳. پرتوهای ذره‌ای: آلفا، بتا و نوترون

پرتو	جرم (amu)	بار	برد در هوا
آلفا (Alpha)	4.0000	+2	چند سانتی‌متر
بتای مثبت (Beta Plus)	0.0005	+1	چند متر
بتای منفی (Beta Minus)	0.0005	-1	چند متر
گاما (Gamma)	0.0000	0	چندین متر
اشعه ایکس (X-Ray)	0.0000	0	چندین متر
نوترون (Neutron)	1.0000	0	چندین متر

منبع: اسلایدهای M.Ph.D - دکتر حق‌پرست اسلاید «Types of Ionizing Radiation»؛ جزوه فیزیک تشعشع و پزشکی هسته‌ای - دکتر حق‌پرست ص ۶

الف) ذرات آلفا (α)

- این ذرات به راحتی از ماده عبور نمی‌کنند؛ ذره آلفا دارای دو بار الکتریکی مثبت است و جرم آن ۴ برابر هیدروژن است.
- در واقع ذره آلفا یک اتم هلیوم دو بار یونیزه شده است.
- ذرات آلفا به وسیله عناصر رادیواکتیو سنگین منتشر می‌شوند.
- قدرت یون‌سازی زیادی دارند ولی قدرت نفوذ آن‌ها در بافت‌ها بسیار کم است و به آسانی به وسیله ضخامت ناچیزی از چند صفحه کاغذ، یک لایه رطوبت یا ضخامت خارجی پوست متوقف می‌شوند.

- برد ذرات آلفا در بافت بدن بسیار کم و نزدیک به 0.03 mm است؛ این ذرات را می‌توان با یک برگه کاغذ یا چند سانتی‌متر هوا متوقف کرد.

- این ذرات تنها وقتی خطرناک‌اند که از طریق تنفسی یا گوارشی وارد بدن شوند.

منبع: جزوه دکتر افضل‌پور ص ۲۴ و ص ۲۵

(ب) ذرات بتا (β)

- قدرت نفوذ بیشتری نسبت به ذرات آلفا دارند و برای متوقف کردن آن‌ها به چند میلی‌متر آلومینیوم نیاز است.
- ذرات بتا الکترون‌هایی با بار مثبت و منفی هستند که نگاترون (الکترون منفی) و پوزیترون (الکترون مثبت) نامیده می‌شوند.
- شباهت‌ها و تفاوت‌های ذره β با الکترون: بار الکتریکی و جرم ذره β همانند الکترون است و تنها تفاوت آن‌ها با یکدیگر منشأ تولیدشان است؛ ذره β از هسته‌اتم سرچشمه می‌گیرد، اما الکترون از مدارهای الکترونی خارج هسته‌ای منشأ می‌گیرد.

منبع: جزوه دکتر افضل‌پور ص ۲۵ و ص ۲۶

(ج) نوترون (n)

- نوترون ذره‌ای با جرمی برابر یک‌دوازدهم جرم اتم کربن-12 و فاقد بار الکتریکی است.
- یکی از منابع این ذرات، راکتورهای هسته‌ای هستند که در آن‌ها اورانیوم شکافته شده و نوترون با انرژی حرارتی آزاد می‌کند.

منبع: جزوه دکتر افضل‌پور ص ۲۶ و ص ۲۷

۴. پرتوهای ایکس و گاما

- پرتوهای X و گاما مانند نور مرئی، امواج رادیویی و میکروویو، امواج الکترومغناطیس‌اند و بخشی از طیف الکترومغناطیس را تشکیل می‌دهند.
- با این وجود، در میان موارد ذکرشده فقط پرتوهای X و گاما پرتو یونیزان محسوب می‌شوند.
- پرتو ایکس و گاما از بیشترین فرکانس در بین همه امواج الکترومغناطیس برخوردارند و بنابراین دارای کوتاه‌ترین طول موج هستند؛ از این‌رو بیشترین مقدار انرژی را حمل می‌کنند.
- پرتو ایکس با شتاب الکترون‌ها در ولتاژ بالا و برخورد به یک هدف فلزی با عدد اتمی بالا تولید می‌شود.
- پرتوهای گاما از فعل‌وانفعالات درون هسته‌اتم و پرتوهای X از فعل‌وانفعالات خارج هسته‌اتم منشأ می‌گیرند.

منبع: جزوه دکتر افضل‌پور ص ۲۷ و ص ۲۸

- بار الکتریکی ندارد.

- دارای جرم نمی‌باشد.

- در خلأ با سرعت نور حرکت می‌کند.

- رابطه بین بسامد و طول موج: $\lambda f = C$ که λ طول موج، f بسامد و C سرعت نور است.

منبع: جزوه دکتر افضل‌پور ص ۲۸ (ویژگی‌های پرتو γ)

۵. قدرت نفوذ و مقایسه انواع تشعشع

قدرت نفوذ (برد) پرتوهای ذره‌ای به سه عامل بستگی دارد: جرم، بار و سرعت ذره. قاعده کلی: هرچه جرم و بار ذره بیشتر و سرعت آن کمتر باشد، قدرت نفوذ (برد) آن کمتر است. برای مثال، ذره آلفا به‌دلیل جرم زیاد (4 واحد جرم اتمی) و بار مثبت دوگانه، برد بسیار

کمی دارد (حد سانتی‌متر در هوا و میکرون در بافت)، اما به همین دلیل قدرت یونیزاسیون و خطر بیولوژیکی بسیار بالایی دارد. در مقابل، ذره بتا جرم و بار کمتری دارد و سرعتش بیشتر است؛ بنابراین بردش در هوا تا چند متر و در بافت در حد میلی‌متر تا سانتی‌متر می‌رسد.

منبع: جزوه فیزیک تشعشع و پزشکی هسته‌ای – دکتر حق‌پرست ص ۶؛ جزوه دکتر افضل‌پور ص ۲۴ تا ۲۶

- قدرت نفوذ (برد) پرتوهای ذره‌ای به جرم، بار و سرعت آن‌ها بستگی دارد: هرچه بار ذره بیشتر و جرم آن سنگین‌تر باشد، برد آن کمتر می‌شود.
- به همین دلیل ذره آلفا با بار 2+ و جرم سنگین، کوتاه‌ترین برد را دارد (در هوا در حد سانتی‌متر و در بافت در حد میکرون) و یک برگ کاغذ آن را جذب می‌کند.
- مسیر حرکت ذره آلفا مستقیم است و در میدان‌های الکتریکی و مغناطیسی منحرف می‌شود.

منبع: منبع: ویدیو – دکتر حق‌پرست، فیزیک پزشکی تشعشع – جلسه ۲ (فایل ۱۲) – ۰۲:۵۷ تا ۰۳:۳۸

- قدرت نفوذ پرتوهای ذره‌ای به سه عامل بستگی دارد: جرم، بار و سرعت ذره؛ هرچه جرم و بار بیشتر و سرعت کمتر باشد، برد کوتاه‌تر و یونیزاسیون متراکم‌تر است.
- ذره آلفا: در هوا در حد سانتی‌متر و در بافت در حد میکرون؛ ذره بتا: در هوا از سانتی‌متر تا حدود متر و در بافت از میلی‌متر تا سانتی‌متر برد دارد.
- بنابراین در پرتوگیری خارجی، بتا نسبت به آلفا «خطرناک‌تر» است؛ اما در پرتوگیری داخلی (استنشاق/بلع)، آلفا به دلیل یونیزاسیون متراکم بسیار آسیب‌زننده‌تر است.

منبع: منبع: ویدیو – دکتر حق‌پرست، فیزیک پزشکی تشعشع – جلسه ۱ (فایل ۱۱) – ۰۵:۱۶ تا ۰۶:۰۷

پرتو	محافظ مناسب
آلفا	یک برگ کاغذ معمولی
بتا	آلومینیوم (ورقه‌ای چند میلی‌متری)
گاما و اشعه ایکس	سرب / بتون
نوترون	پارافین (مواد سبک هیدروژن‌دار)

منبع: جزوه فیزیک تشعشع و پزشکی هسته‌ای – دکتر حق‌پرست ص ۷؛ اسلایدهای M.Ph.D – دکتر حق‌پرست اسلاید «Penetrating Power»

۶. آلودگی داخلی بدن

اگرچه ذرات آلفا و بتا از بیرون بدن قدرت نفوذ کمی دارند، در صورت ورود به داخل بدن (بلعیدن، تزریق یا تنفس) به دلیل تخلیه کامل انرژی در بافت، بیشترین دز جذبی را ایجاد می‌کنند. اندام‌هایی مانند تیروئید، ریه، کبد و استخوان در معرض این آلودگی داخلی قرار دارند.

منبع: جزوه فیزیک تشعشع و پزشکی هسته‌ای – دکتر حق‌پرست ص ۷ و ۸؛ اسلایدهای M.Ph.D – دکتر حق‌پرست اسلاید «Internal Contamination»

۷. کشف پرتو ایکس

ویلهلم کنراد رونتگن، فیزیکدان آلمانی، در هشتم نوامبر 1895 پرتو X را کشف کرد. او در حال بررسی رفتار پرتوهای کاتدی (الکترون‌ها) در لامپ پرتو کاتدی بود که در هر دو سر آن یک الکتروود پلاتینی کار گذاشته بود.

منبع: جزوه دکتر افضل‌پور ص ۳۰

- او لامپ پرتو کاتدی را در مقوای سیاه‌رنگی پیچید تا از فرار نور که ممکن بود روی آزمایش‌هایش اثر بگذارد جلوگیری کند، و آزمایشگاه را تاریک کرد.
- او دریافت که نور از فلورسانس پرده‌ای پوشیده از سیانید پلاتین-باریوم سرچشمه می‌گیرد.
- از آن‌جا که الکترون‌ها نمی‌توانستند از دیواره شیشه‌ای لامپ بیرون بروند، نتیجه گرفت که هنگام گذر جریان در لوله، گونه‌ای پرتو ناشناخته پدید آمده است.

منبع: جزوه دکتر افضل‌پور ص ۳۰ و ص ۳۱

- رونتگن اجسام گوناگونی را میان لامپ و پرده فلورسانت قرار داد؛ روشنایی لامپ با گذاشتن هر یک از این اجسام تغییر می‌کرد و این نشان می‌داد پرتو از میان برخی اجسام آسان‌تر از دیگران می‌گذرد.
- او دستش را میان لامپ و پرده قرار داد و دید طرح استخوان‌بندی دستش روی پرده پدیدار شد.
- رونتگن مطالعاتش را درباره این پرتوهای ناشناخته ادامه داد و در سال 1901 موفق به دریافت نخستین جایزه نوبل فیزیک گردید.

منبع: جزوه دکتر افضل‌پور ص ۳۱

۸. اصول فیزیکی تصویر در پزشکی

تفاوت بنیادین روش‌های تصویربرداری: در رادیولوژی منبع پرتو (دستگاه ایکس) خارج از بدن است و تصویر بر پایه عبور و جذب پرتو ساخته می‌شود؛ در پزشکی هسته‌ای، خود بدن پس از تزریق رادیودارو منبع پرتو محسوب می‌شود؛ و در سونوگرافی، تصویر بر اساس ثبت و مطالعه امواج فراصوت با بازتابش از بافت‌های مختلف بدن بنا شده است.

منبع: جزوه فیزیک تشعشع و پزشکی هسته‌ای – دکتر حق‌پرست ص ۳۹؛ جزوه دکتر افضل‌پور ص ۵۳

روش تصویربرداری	اساس فیزیکی
رادیوگرافی ساده (Plane Radiography)	عبور و جذب پرتو ایکس از بدن و ثبت روی فیلم/آشکارساز
فلوروسکوپی	مشاهده پیوسته تصویر روی صفحه فلورسنت/مانیتور با ماده کنتراست
سی‌تی‌اسکن	تابش پرتو ایکس از زوایای مختلف به یک برش و آشکارسازی پرتوهای عبورکرده
پزشکی هسته‌ای	گسیل پرتو از رادیوداروی درون بدن و آشکارسازی با گاماکمر/PET/SPECT
سونوگرافی	بازتابش امواج فراصوت از مرزهای بافتی
MRI	میدان مغناطیسی و امواج رادیویی (غیریونیزان)

- دسته‌بندی دیگری از پرتوهای یونیزان که در ویدیو تأکید شد (بر پایه‌ی شیوه‌ی یونیزاسیون): «مستقیم» و «غیرمستقیم».
- پرتوهای یونیزان مستقیم، خودشان باردارند و از لحظه‌ی برخورد با ماده انرژی منتقل می‌کنند: ذره آلفا، بتا، الکترون و پروتون.
- پرتوهای یونیزان غیرمستقیم خودشان باردار نیستند و کار یونیزاسیون را از راه الکترون‌های ثانویه انجام می‌دهند: نوترون (جرم‌دار) و پرتو ایکس و گاما (بدون جرم).
- در سمت غیر یونیزان طیف هم پرتوهای فرابنفش، نور مرئی، فرسرخ، ریزموج و رادیوفرکوئنسی و لیزر قرار می‌گیرند.

منبع: منبع: ویدیو - دکتر افصلی پور، فیزیک پزشکی - جلسه ۲ (فایل ۱۷) - ۰۱:۵۸ تا ۰۳:۵۶

- تعریف ساده‌ی ذره آلفا در ویدیو: ذره آلفا در حقیقت یک اتم هلیوم دو بار یونیزه شده است؛ ۲ بار مثبت و جرمی معادل ۴ برابر اتم هیدروژن دارد.
- نکته‌ی حفاظتی مهم: ذره آلفا قدرت یونیزاسیون بالا ولی قدرت نفوذ بسیار کم دارد؛ با چند صفحه کاغذ یا لایه‌ی شاخی پوست متوقف می‌شود و در سطح پوست خطری برای فرد ایجاد نمی‌کند - خطر اصلی آن «پرتوگیری داخلی» است.

منبع: منبع: ویدیو - دکتر افصلی پور، فیزیک پزشکی - جلسه ۲ (فایل ۱۷) - ۰۵:۰۵ تا ۰۶:۲۷

مرور سریع

- تشعشع = انتشار انرژی از خلاء و ماده؛ دو صورت: ذره‌ای و الکترومغناطیس.
- پرتوهای باردار: α ، پروتون، نگاترون (بتای منفی)، پوزیترون (بتای مثبت) - پرتو بدون بار: نوترون.
- یونیزان: α ، β ، γ ، نوترون، ایکس / غیر یونیزان: رادیویی، میکروویو، مادون قرمز، مرئی، فرابنفش، لیزر.
- قدرت نفوذ با جرم و بار رابطه معکوس و با سرعت رابطه مستقیم دارد.
- جرم و بار: آلفا 4.0000 amu و +2؛ بتا 0.0005 amu و ± 1 ؛ گاما و ایکس 0 و 0؛ نوترون 1.0000 amu و 0.
- محافظ مناسب: آلفا ← کاغذ؛ بتا ← آلومینیوم؛ گاما/ایکس ← سرب یا بتون؛ نوترون ← پارافین.
- خطر اصلی آلفا و بتا: آلودگی داخلی (تنفس، بلع، تزریق) - بیشترین دز جذبی در بافت.
- کشف پرتو ایکس: رونتگن، ۸ نوامبر ۱۸۹۵، جایزه نوبل 1901.
- پرتو ایکس از خارج هسته و گاما از درون هسته منشأ می‌گیرد؛ هر دو موج الکترومغناطیس بدون بار و جرم‌اند.



فصل ۲

تولید پرتو ایکس و ساختمان لامپ

دکتر رضا افضلی پور

صفحه‌های ۱۳ تا ۲۲

۱

جدول

۸

شکل

۴۲

بخش

۱. مکانیسم کلی تولید پرتو ایکس

وقتی الکترون‌های پرسرعت به یک هدف فلزی (تارگت) برخورد می‌کنند، اشعه ایکس تولید می‌شود. در این فرایند، انرژی جنبشی الکترون به انرژی الکترومغناطیس تبدیل می‌شود. کار دستگاه اشعه ایکس فراهم کردن جریانی کنترل‌شده و با شدت کافی از الکترون از کاتد به سمت آند است.

منبع: اسلایدهای M.Ph.D – دکتر حق‌پرست اسلاید ۳ «X-Rays»؛ جزوه فیزیک تشعشع و پزشکی هسته‌ای – دکتر حق‌پرست ص ۹

پرتوهای X در فرایند تبدیل انرژی پدید می‌آیند و این پدیده هنگامی است که یک جریان از الکترون‌های پرسرعت ناگهان به هدف تنگستنی (آند) یک لامپ پرتو رونتگن برخورد کرده و انرژی و سرعت آن به‌تندی کاهش می‌یابد.

منبع: جزوه دکتر افضلی‌پور ص ۳۵

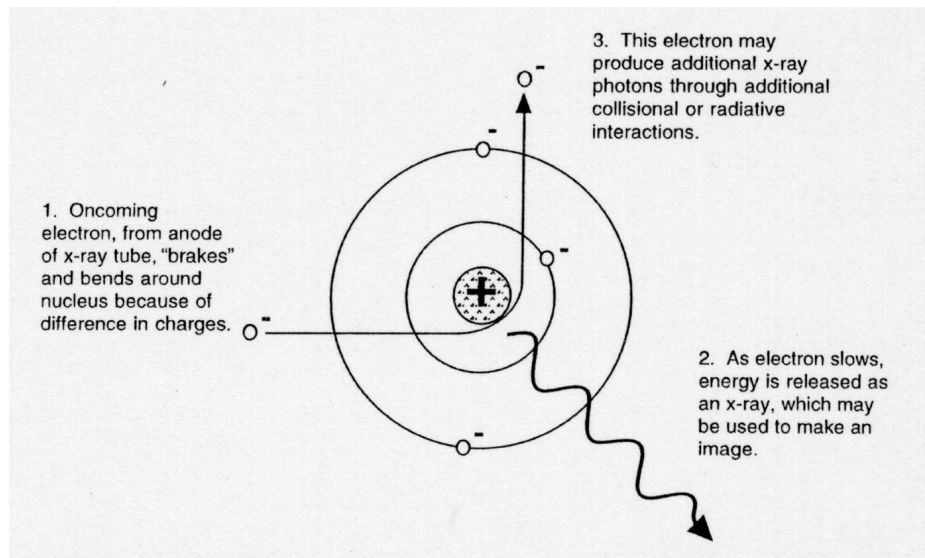
به‌طور کلی پرتو X در اثر دو فرایند تولید می‌شود: (۱) پدیده ترمزی (برمشتراونگ) و (۲) پدیده تابش اختصاصی.

منبع: جزوه دکتر افضلی‌پور ص ۳۱



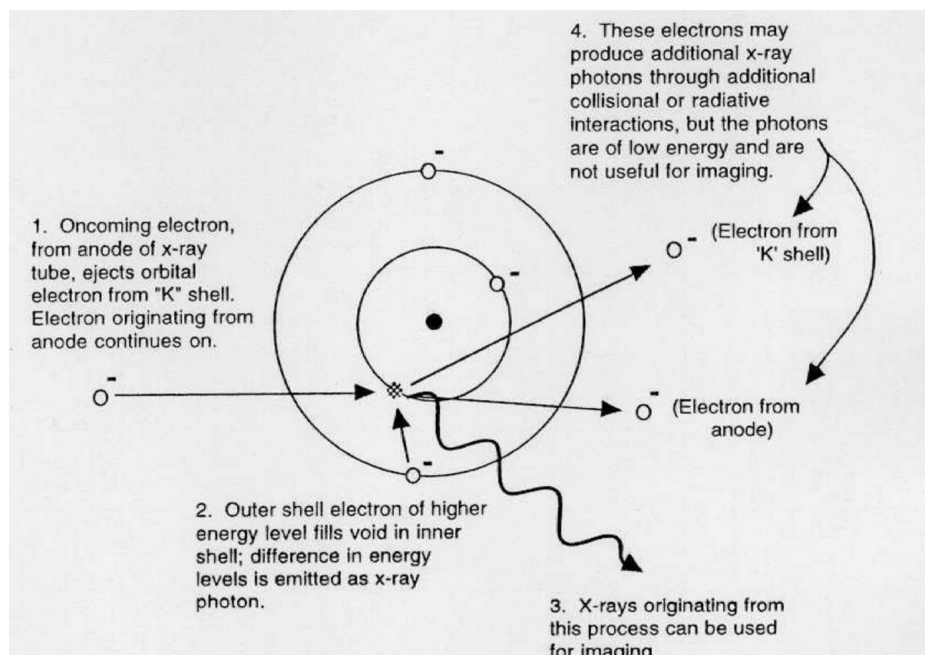
شکل – دو مکانیسم تولید پرتو ایکس: پدیده ترمزی (Bremsstrahlung) و پدیده مشخصه (Characteristic).

اسلایدهای M.Ph.D – ص ۹



شکل - برهم‌کنش الکترون فرودی با اتم هدف: الکترون در میدان هسته می‌پیچد و کند می‌شود؛ انرژی آزادشده به صورت فوتون اشعه ایکس (ترمزی) بیرون می‌آید.

اسلایدهای M.Ph.P.D - دکتر حق پرست - ص ۱۳



شکل - دو سازوکار تولید اشعه ایکس در هدف: ترمزی (کاهش سرعت الکترون در میدان هسته) و مشخصه (خروج الکترون لایه K و پر شدن جای آن).

اسلایدهای M.Ph.P.D - دکتر حق پرست - ص ۱۴

۲. پدیده ترمزی (برمشتراونگ)

در این پدیده الکترون‌ها به دلیل انرژی جنبشی که دارند به داخل اتم‌های آن وارد می‌شوند و تحت تأثیر میدان اتم‌های سنگین هدف از مسیر اولیه‌ی خود منحرف شده و دارای تغییر سرعت و کاهش انرژی می‌شوند. این انرژی به صورت پرتو تابیده می‌شود.

منبع: جزوه دکتر افصلی‌پور ص ۳۱ و ص ۳۲

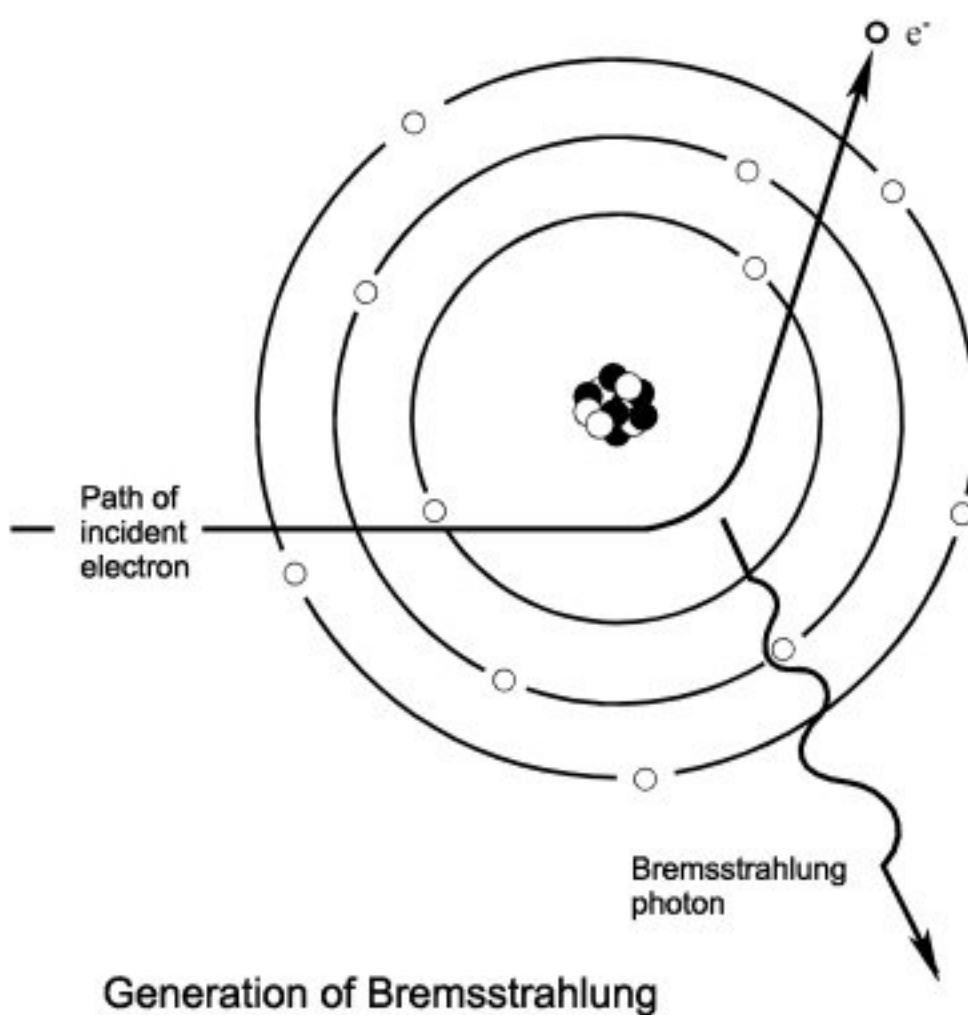
• در این فرایند، راندمان تولید اشعه بسیار کم می‌باشد.

- در این طیف، ماکزیمم انرژی مربوط به الکترونی است که بیشترین انحراف را توسط هسته داشته و هیچ‌گونه اتلافی در انرژی آن صورت نپذیرفته است.
- مینیمم انرژی نیز مربوط به مواد جاذب سر راه فوتون‌ها است که چه کسری از انرژی آن‌ها را جذب کرده‌اند.
- قله انرژی نیز مربوط به بالاترین انرژی اعمالی به تیوب است.

منبع: جزوه دکتر افصلی‌پور ص ۳۲

- در این مکانیسم، الکترون پرسرعتی که از فیلامان وارد اتم تنگستن (Tungsten) می‌شود، بر اثر جاذبه بار مثبت هسته، منحرف و کند می‌شود و انرژی ازدست‌رفته به صورت یک فوتون اشعه ایکس آزاد می‌شود.
- الکترون پس از این برخورد، در جهتی دیگر مسیر خود را ادامه می‌دهد و می‌تواند با سایر اتم‌ها نیز برخورد کند تا زمانی که پیوسته‌ای از انرژی داشته باشد.

منبع: جزوه فیزیک تشعشع و پزشکی هسته‌ای – دکتر حق‌پرست ص ۹ و ص ۱۰؛ اسلایدهای M.Ph.D – دکتر حق‌پرست اسلاید «Bremsstrahlung X-ray Production»



شکل – تولید تابش ترمزی (Bremsstrahlung): الکترون پرسرعت در میدان هسته منحرف و کند می‌شود و انرژی ازدست‌رفته به صورت فوتون اشعه ایکس آزاد می‌شود.

جزوه دکتر افصلی‌پور – ص ۳۲، ۳۶ (ص ۳۲)

اگر الکترون پرسرعت تمام انرژی خود را در یک برخورد از دست بدهد و به طور کامل متوقف شود، اشعه ایکس تولیدشده برابر با کل انرژی الکترون خواهد بود؛ این حالت، بیشینه انرژی ممکن اشعه ترمزی است.

نکته کلیدی: بیشینه انرژی اشعه ترمزی = کل انرژی الکترون فرودی؛ پس طیف ترمزی پیوسته است و مرز بالای آن با انرژی الکترون‌ها (و در نتیجه با kVp) تعیین می‌شود.

۳. اشعه ایکس مشخصه (اختصاصی)

در این پدیده، الکترون‌های تابیده شده از فیلامان به الکترون‌های مدارهای داخلی اتم‌های هدف نظیر لایه K برخورد می‌کنند و باعث کنده شدن این الکترون‌ها از مدار مربوطه می‌شوند و لذا در این لایه یک حفره به وجود می‌آید. با پرشدن این حفره توسط الکترون‌های لایه‌های بالاتر، اختلاف انرژی دو لایه به صورت فوتون از ماده هدف خارج می‌شود.

منبع: جزوه دکتر افصلی پور ص ۳۳ و ص ۳۴

- یک الکترون پرسرعت با انرژی کافی (باید بیشتر از انرژی بستگی الکترون لایه K باشد) به یک الکترون در لایه K برخورد کرده و آن را از مدارش خارج می‌کند.
- سپس الکترونی از لایه بالاتر (L یا M) برای پرکردن این جای خالی سقوط می‌کند و تفاوت انرژی این دو لایه به صورت فوتون ایکس مشخصه تولید می‌شود.
- انرژی بستگی لایه K تنگستن = 70 keV و انرژی بستگی L = 11 keV؛ بنابراین انرژی فوتون ایکس مشخصه تولیدشده: $70 - 11 = 59 \text{ keV}$
- الکترونی که از لایه K بیرون رانده می‌شود «الکترون برانگیخته» نام دارد و ممکن است الکترون بازگشتی (Recoil electron) با انرژی بسیار کم نیز از اتم خارج شود.

منبع: جزوه فیزیک تشعشع و پزشکی هسته‌ای – دکتر حق‌پرست ص ۱۱ و ص ۱۲؛ اسلایدهای M.Ph.P.D – دکتر حق‌پرست اسلاید «Characteristic X-ray Production»

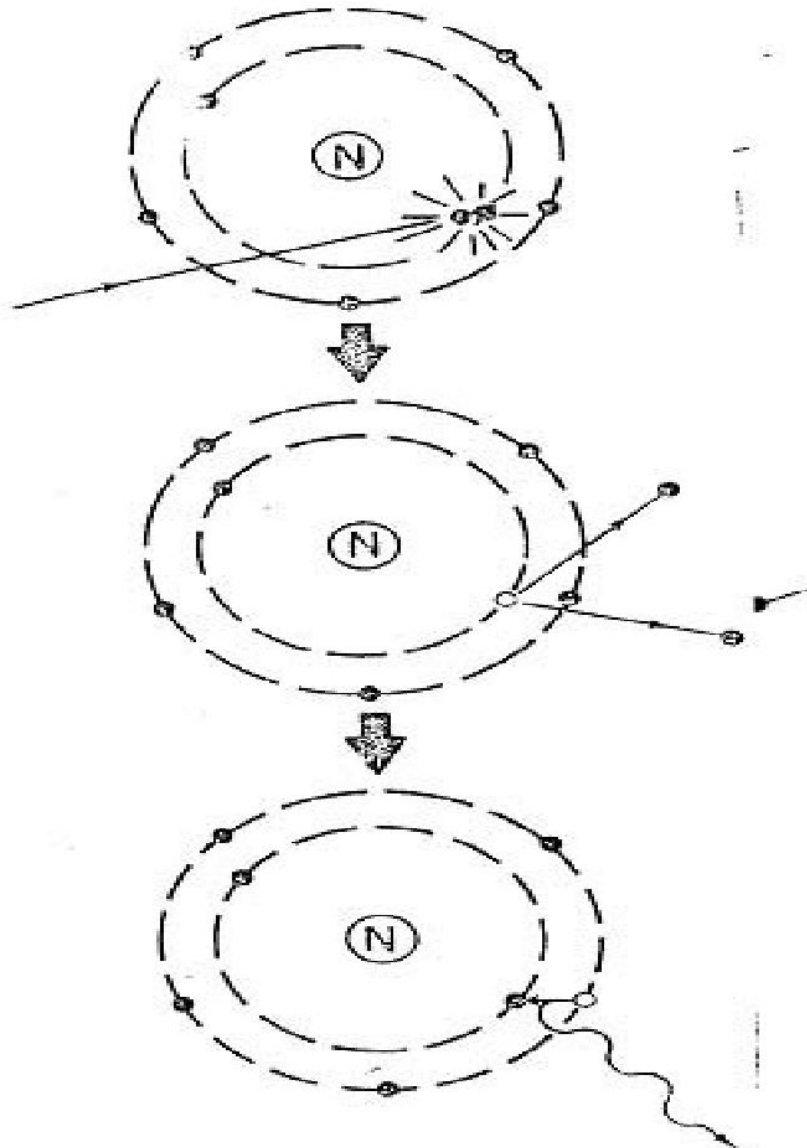


Figure 2-13 The production of characteristic radiation

شکل - اشعه ایکس مشخصه: با خروج الکترون لایه K، الکترون لایه بالاتر جای خالی را پر می‌کند و فوتون ایکس با انرژی برابر اختلاف انرژی دو لایه گسیل می‌شود.

اسلایدهای دکتر افضلی‌پور - ص ۳۴ «پدیده تابش اختصاصی»

$$E_{K\alpha} = E_{\text{binding},K} - E_{\text{binding},L} = 70 - 11 = 59 \text{ keV}$$

انرژی فوتون مشخصه تنگستن

$E_{\text{binding},K} = 70 \text{ keV}$: انرژی بستگی الکترون لایه K تنگستن

$E_{\text{binding},L} = 11 \text{ keV}$: انرژی بستگی الکترون لایه L

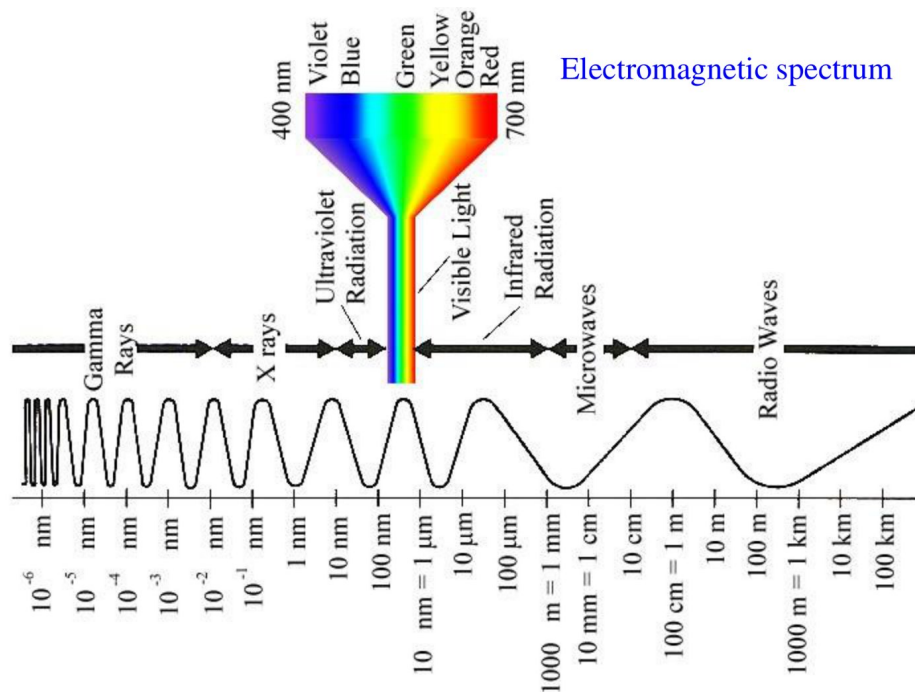
خروجی: فوتون ایکس مشخصه با انرژی 59 keV

منبع: جزوه فیزیک تشعشع و پزشکی هسته‌ای - دکتر حق‌پرست ص ۱۲؛ اسلایدهای M.Ph.D - دکتر حق‌پرست اسلاید «Characteristic X-ray Production»

۴. طیف انرژی اشعه ایکس

باریکه اشعه ایکس خروجی از لوله، ترکیبی از دو نوع تابش است: طیف پیوسته اشعه‌های ترمزی که زمینه اصلی نمودار را می‌سازد، به‌همراه چند قله مشخص و جداگانه که مربوط به اشعه‌های ایکس مشخصه است (در تنگستن: 59 keV و 67 keV).

منبع: جزوه فیزیک تشعشع و پزشکی هسته‌ای – دکتر حق‌پرست ص ۱۲ و ۱۳؛ اسلایدهای M.Ph.D – دکتر حق‌پرست اسلاید «X-ray Spectrum»



شکل – طیف الکترومغناطیس: جایگاه امواج رادیویی، مادون قرمز، نور مرئی، فرابنفش، اشعه ایکس و گاما برحسب فرکانس و طول موج.

اسلایدهای M.Ph.D – دکتر حق‌پرست ص ۶

- اشعه ایکس از برخورد الکترون پرسرعت با تارگت فلزی (معمولاً تنگستن) تولید می‌شود.
- ترمزی: کندشدن الکترون در میدان هسته → طیف پیوسته؛ بیشینه انرژی = انرژی کامل الکترون.
- مشخصه: پرشدن جای خالی لایه K توسط الکترون‌های لایه بالاتر → فوتون با انرژی معین (مثال: 59 keV).
- طیف نهایی اشعه ایکس، ترکیبی از هر دو مکانیسم است.

منبع: جزوه فیزیک تشعشع و پزشکی هسته‌ای – دکتر حق‌پرست ص ۱۳

۵. ساختمان لامپ پرتو ایکس

لامپ پرتو رونتگن از یک پوشش شیشه‌ای تهی از هوا که دارای دو الکتروست ساخته شده است. الکترودها به‌گونه‌ای طراحی شده‌اند که الکترون‌های تولیدشده در کاتد (الکتروست منفی) به‌وسیله اختلاف پتانسیل بالا به سوی آنود (الکتروست مثبت با هدف) شتاب بگیرند.

منبع: جزوه دکتر افضل‌پور ص ۳۵

- به رشته (فیلامان) تنگستنی کاتد جریانی در حدود ۳ تا ۵ آمپر داده می‌شود تا گداخته شود؛ جوش الکترون‌ها (Thermionic Emission) نتیجه همین گرم شدن است.

- فاصله فیلامان تا آند به گونه‌ای تنظیم شده که الکترون‌ها با سرعت مناسب و یکنواخت به هدف برسند و انرژی خود را در طول مسیر از دست ندهند.

منبع: منبع: ویدیو - دکتر افصلی‌پور، فیزیک پزشکی - جلسه ۲ (فایل ۱۷) - ۲۳:۵۱ تا ۲۶:۲۷

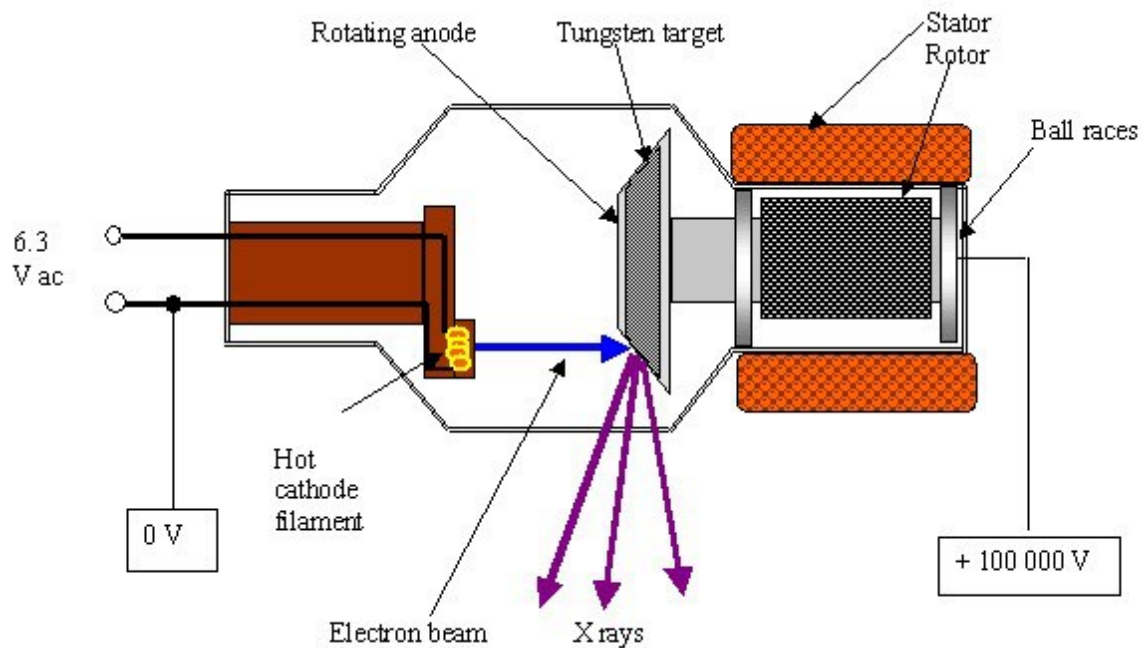
- درون لامپ، الکترون‌ها از رشته تنگستنی گداخته تولید می‌شوند و در طول لامپ شتاب می‌گیرند تا به هدف (آند) تنگستنی - یعنی جایی که پرتوهای رونتگن تولید می‌شوند - برخورد کنند.

منبع: جزوه دکتر افصلی‌پور ص ۳۵



شکل - نمای واقعی لامپ اشعه ایکس (پوشش شیشه‌ای با روغن خنک‌کننده و پنجره خروجی پرتو).

جزوه دکتر افصلی‌پور - ص ۳۲، ۳۶ (ص ۳۶)



شکل - برش لامپ اشعه ایکس با آند چرخان: فیلامان (Hot Filament/کاتد)، هدف تنگستنی (Tungsten Target)، آند چرخان (Rotating Anode)، استاتور (Stator) و پنجره (Beryllium Window).

جزوه دکتر افصلی پور - ص ۳۲، ۳۶ (ص ۳۶)

نکته کلیدی: اثر فضای بار (Space Charge): الکترون‌های گسیل‌شده از فیلامان همگی بار منفی دارند و یکدیگر را می‌رانند؛ این ابر بار منفی، خروج الکترون‌های بعدی را محدود می‌کند. کاسه کانونی (Focusing Cup) اطراف فیلامان، این ابر را به شکل باریکه‌ای متمرکز می‌کند تا الکترون‌ها روی نقطه کانونی هدف متمرکز شوند.

آند چرخان (Rotating anode)

- به دلیل این‌که در سیستم‌های قدرتمند امروزی گرمای زیادی در سطح هدف ایجاد می‌گردد، نیاز به روشی است که تحمل گرما را برای هدف آسان‌تر سازد؛ لذا آندهای ثابت جای خود را به آندهای چرخان دادند.
- این آندها مقاومت لامپ را در برابر گرمای زیاد ناشی از اکسپوژن‌های طولانی افزایش می‌دهند.
- این آندها با سرعتی حداقل ۳۰۰۰ دور در دقیقه می‌چرخند. هدف از آند چرخان، پخش حرارت ایجادشده در خلال یک اکسپوژر در سطح بزرگی از هدف است.
- به دلیل تابش الکترون‌ها به سطح آند، پس از مدتی در سطح هدف ناهمواری و فرورفتگی‌هایی مشاهده می‌شود که این تغییرات فیزیکی ناشی از فشارهای حرارتی بوده و باعث کاهش خروجی لامپ اشعه می‌شوند؛ به همین دلیل در ساخت هدف مقداری رنیوم به تنگستن اضافه می‌کنند تا مقاومت سطحی هدف افزایش یابد.

منبع: جزوه دکتر افصلی پور ص ۴۴

- هدف (آند) از تنگستن با ضخامت حدود ۲ میلی‌متر ساخته می‌شود؛ عدد اتمی تنگستن حدود ۷۴ و نقطه ذوب آن حدود ۳۳۷۰ درجه سانتی‌گراد است - همین دو ویژگی، آن را برای تحمل گرمای لامپ مناسب می‌کند.
- سطح هدف با زاویه حدود ۱۵ تا ۲۰ درجه نسبت به مسیر الکترون‌ها شیب داده می‌شود؛ این شیب، اندازه نقطه کانونی (Focal Spot) را کوچک و در نتیجه تصویر را واضح‌تر می‌کند، در حالی که مساحت دفع حرارت بزرگ می‌ماند.

منبع: منبع: ویدیو - دکتر افصلی پور، فیزیک پزشکی - جلسه ۲ (فایل ۱۷) - ۲۶:۰۷ تا ۲۹:۴۱

۶. شدت دسته پرتو ایکس

ولتاژ (kVp) اعمال شده: انرژی فوتون‌های تابشی از لامپ پرتو X به انرژی الکترون‌هایی که آند را بمباران می‌کنند بستگی دارد. انرژی الکترون‌ها به نوبه خود به وسیله بیشینه ولتاژ اعمالی مشخص می‌شود. میزان بیشینه انرژی (کیفیت) پرتو X تولیدی را بیشینه ولتاژ و هم‌چنین kVp بالاتر، کمیت پرتوهای X تولیدی را افزایش می‌دهد. مقدار تشعشع تولیدشده با مربع کیلوولتاژ افزایش می‌یابد؛ یعنی شدت پرتو متناسب با $(kVp)^2$ می‌باشد.

منبع: جزوه دکتر افصلی‌پور ص ۴۶

$$I \propto (kVp)^2$$

رابطه شدت پرتو ایکس با کیلوولتاژ

ا: شدت دسته پرتو ایکس

kVp: بیشینه ولتاژ اعمالی به لامپ

نتیجه منبع: kVp بالاتر، هم بیشینه انرژی (کیفیت) و هم کمیت پرتوهای تولیدی را افزایش می‌دهد

منبع: جزوه دکتر افصلی‌پور ص ۴۶

- به زبان ساده: kVp → کیفیت پرتو (قدرت نفوذ و انرژی فوتون‌ها) و mA → کمیت پرتو (تعداد فوتون‌های تولیدی).
- افزایش mA جریان الکترون‌ها به سمت آند را زیاد می‌کند؛ الکترون‌های بیشتر = فوتون‌های بیشتر = شدت بیشتر، بدون آن که انرژی تک‌تک فوتون‌ها تغییر کند.

منبع: منبع: ویدیو - دکتر افصلی‌پور، فیزیک پزشکی - جلسه ۲ (فایل ۱۷) - ۲۹:۴۱ تا ۳۱:۵۸

- تعداد فوتون‌های پرتو X تولیدشده به روشنی به تعداد الکترون‌هایی که از کاتد به آند می‌روند بستگی دارد؛ این تعداد مستقیماً به جریان لامپ (mA) مربوط است.
- هر میزان که mA زیادتر باشد، الکترون‌های بیشتری تولید می‌شوند و در نتیجه پرتو X بیشتری نیز تولید خواهد شد.
- mA (milliamperage): تعداد الکترون‌های سفرکننده از کاتد به آند؛ mA جریان لامپ اشعه ایکس را توصیف می‌کند.

منبع: جزوه دکتر افصلی‌پور ص ۴۷ و ص ۵۰

پارامتر	اثر بر پرتو ایکس	کمیت متأثر
kVp (بیشینه ولتاژ)	انرژی فوتون‌ها و بیشینه انرژی (کیفیت) و نیز کمیت را افزایش می‌دهد؛ شدت متناسب با $(kVp)^2$	کیفیت و کمیت
mA (جریان لامپ)	تعداد الکترون‌ها و لذا تعداد فوتون‌های تولیدشده را افزایش می‌دهد	کمیت
زمان اکسپوزر	بر تعداد فوتون‌های کل خروجی اثر می‌گذارد	کمیت

منبع: جزوه دکتر افصلی‌پور ص ۴۶ و ص ۴۷ و ص ۵۰

۷. راندمان و اتلاف در لامپ

در این فرایند، راندمان تولید اشعه بسیار کم می‌باشد؛ بیشتر انرژی الکترون‌ها به گرما تبدیل می‌شود و همین امر، مسئله تحمل گرمای هدف را مهم می‌کند (به همین دلیل آندهای چرخان و افزودن رنیوم به تنگستن به کار می‌رود).

مرور سریع

- تولید پرتو ایکس: برخورد الکترون‌های پرسرعت با هدف فلزی → تبدیل انرژی جنبشی به انرژی الکترومغناطیس.
- دو مکانیسم: ترمزی (Bremsstrahlung؛ طیف پیوسته) و مشخصه (Characteristic؛ قله‌های مجزا).
- بیشینه انرژی ترمزی = کل انرژی الکترون (وقتی الکترون در یک برخورد کامل متوقف شود).
- مشخصه تنگستن: $11 \text{ keV} - 70 \text{ keV} = 59 \text{ keV}$ ؛ قله‌های مشخصه در طیف: 59 و 67 keV.
- لامپ: پوشش شیشه‌ای تهی از هوا، کاتد (رشته تنگستنی) و آند (هدف تنگستنی)؛ شتاب الکترون‌ها با اختلاف پتانسیل بالا.
- آند چرخان: حداقل 3000 rpm برای پخش حرارت؛ افزودن رنیوم به تنگستن برای افزایش مقاومت سطحی هدف.
- kVp → کیفیت (انرژی) و کمیت؛ شدت متناسب با $(\text{kVp})^2$.
- mA → تعداد الکترون‌ها و در نتیجه تعداد فوتون‌های پرتو ایکس (کمیت).
- راندمان تولید اشعه در لامپ بسیار کم است و بیشتر انرژی به گرما تبدیل می‌شود.



فصل ۳

تشکیل تصویر رادیوگرافی، فلوروسکوپی و سی‌تی‌اسکن

دکتر رضا افضلی‌پور

صفحه‌های ۲۴ تا ۳۹

۳

جدول

۲۱

شکل

۵۵

بخش

۱. رادیوگرافی ساده و جایگاه آن

رادیوگرافی ساده بدون کاربرد ماده خارجی به بدن تهیه می‌شود. این روش در مواردی به کار می‌رود که بافت‌های مورد رادیوگرافی دارای اختلاف ضرایب تضعیف یا اختلاف ضخامت باشند؛ یعنی «کنتراست جسم» وجود داشته باشد.

منبع: جزوه دکتر افضل‌پور ص ۵۷



شکل – نمونه رادیوگرافی ساده قفسه سینه: تصویر از تفاوت تضعیف پرتو در بافت‌های مختلف (استخوان، ریه پر از هوا و قلب) ساخته می‌شود.

اسلایدهای دکتر افضل‌پور – ص ۱۱

روش	تعریف	نمونه کاربرد
رادیوگرافی ساده (Plane)	بدون کاربرد ماده خارجی؛ نیازمند کنتراست طبیعی جسم	تصویر قفسه سینه، استخوان
رادیوگرافی با ماده کنتراست	همراه با کاربرد ماده خارجی به بدن	بررسی دستگاه گوارش، آنژیوگرافی
فلوروسکوپي	مشاهده پیوسته عملکرد (حرکت) روی صفحه فلورسنت/مانیتور با ماده کنتراست	معه و دوازدهه، آنژیوگرافی، کاتتریزاسیون قلبی
سی‌تی‌اسکن	تصویربرداری از اعضای داخل بدن در مقاطع یا برش‌های عرضی	مغز و اعصاب، شکم، اورژانس‌های مغزی

منبع: جزوه دکتر افضل‌پور ص ۵۳ و ص ۵۷ و ص ۵۹ و ص ۶۲

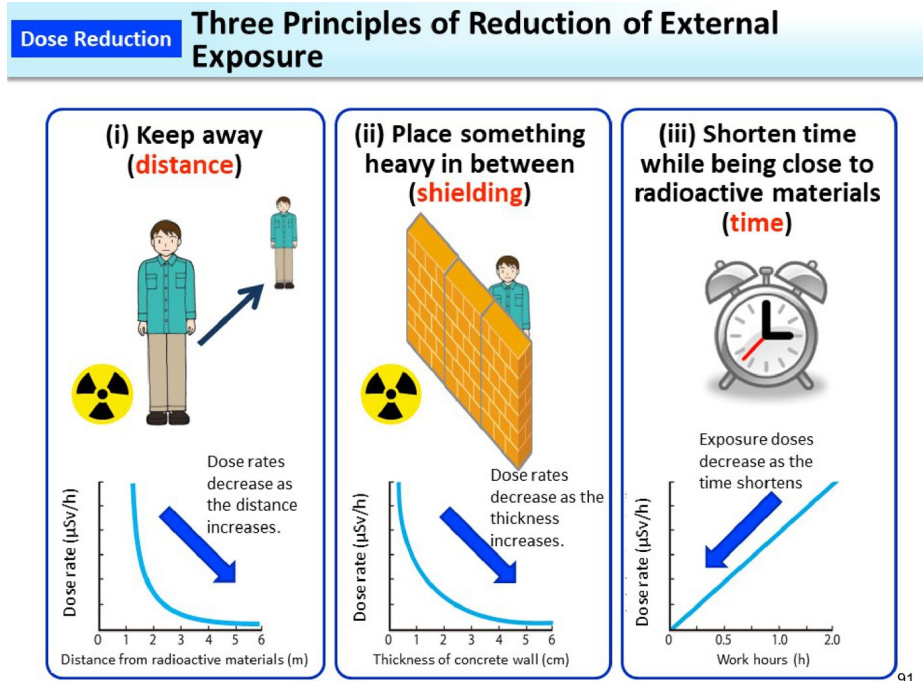
- جریان لامپ در فلوروسکوپي معمولاً بین حدود ۰.۵ تا ۵ میلی‌آمپر است، در حالی که در رادیوگرافی معمولی برای تشکیل یک تصویر، جریانی در حدود ۵۰۰ تا ۱۰۰۰ میلی‌آمپر به کار می‌رود.
- این تفاوت بزرگ جریان، دلیل اصلی پایین بودن دوز هر تصویر فلوروسکوپي در مقایسه با یک رادیوگرافی است؛ در عوض فلوروسکوپي زمان طولانی‌تری ادامه دارد.

منبع: منبع: ویدیو – دکتر افضل‌پور، فیزیک پزشکی – جلسه ۳ (فایل ۱۸) – ۸:۱۴ تا ۸:۴۶

۲. پایه‌های فیزیکی تشکیل تصویر رادیوگرافی

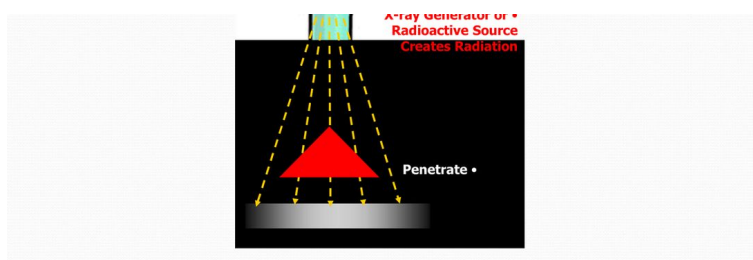
وضعیت پرتوها قبل از برخورد به بافت: یک دسته پرتو ایکس قبل از ورود به بدن بیمار دارای توزیع تقریباً یکنواختی از فوتون‌ها است که حاوی هیچ‌گونه اطلاعات تشخیصی مفیدی نمی‌باشد. تضعیف پرتو پس از عبور از بافت‌های مختلف به میزان متفاوت است و توزیع پرتو پس از خروج از بدن بیمار کاملاً تغییر می‌کند.

منبع: جزوه دکتر افضل‌پور ص ۵۴



شکل – چه چیزی در تصویر رادیوگرافی دیده می‌شود؟ میزان تضعیف پرتو به عدد اتمی، چگالی و ضخامت بافت بستگی دارد؛ همین تفاوت‌ها تصویر را می‌سازند.

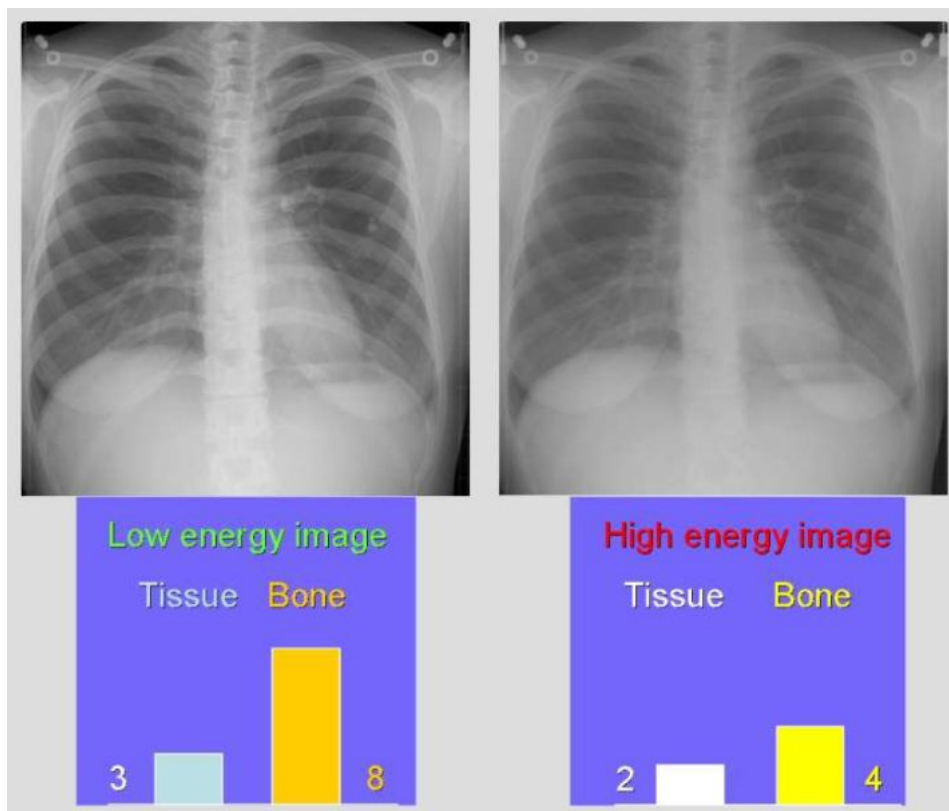
اسلایدهای دکتر افضل‌پور – ص ۹۱



شکل – شمای کلی تصویربرداری با پرتو ایکس: مولد پرتو ایکس (یا چشمه رادیواکتیو) پرتو را می‌تاباند و پرتو پس از نفوذ در جسم به گیرنده تصویر می‌رسد.

اسلایدهای دکتر افضل‌پور – ص ۱۹ «تصویربرداری با پرتو ایکس»

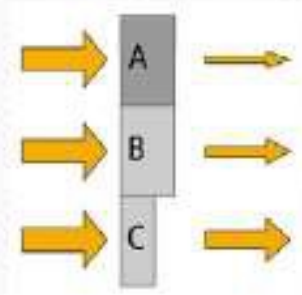
یک تصویر رادیوگرافی، تفاوت‌های عدد اتمی و چگالی بین بخش‌های مختلف جسم را نشان می‌دهد. بخش‌های مختلف جسم، پرتو ایکس را متفاوت جذب می‌کنند و این تفاوت به ترکیب، ضخامت، چگالی و عدد اتمی ماده بستگی دارد. هرچه عدد اتمی ماده بالاتر باشد، پرتو ایکس بیشتری جذب می‌کند؛ طلا با عدد اتمی ۷۹ بسیار بیشتر از موادی مانند آلومینیوم با عدد اتمی ۱۳ پرتو ایکس جذب می‌کند.



شکل – اثر انرژی پرتو بر کنتراست: در انرژی پایین (چپ) تفاوت بافت نرم و استخوان بهتر دیده می شود؛ در انرژی بالا (راست) پرتو از استخوان هم عبور می کند و کنتراست کاهش می یابد.

اسلایدهای دکتر افصلی پور – ص ۷۷

What does an X-ray image show?



An X-ray image, or radiograph, shows differences in **atomic number** and **density** between different parts of the object.

Different parts of the object absorb X-rays differently depending upon composition, thickness, density, and atomic number of the material.

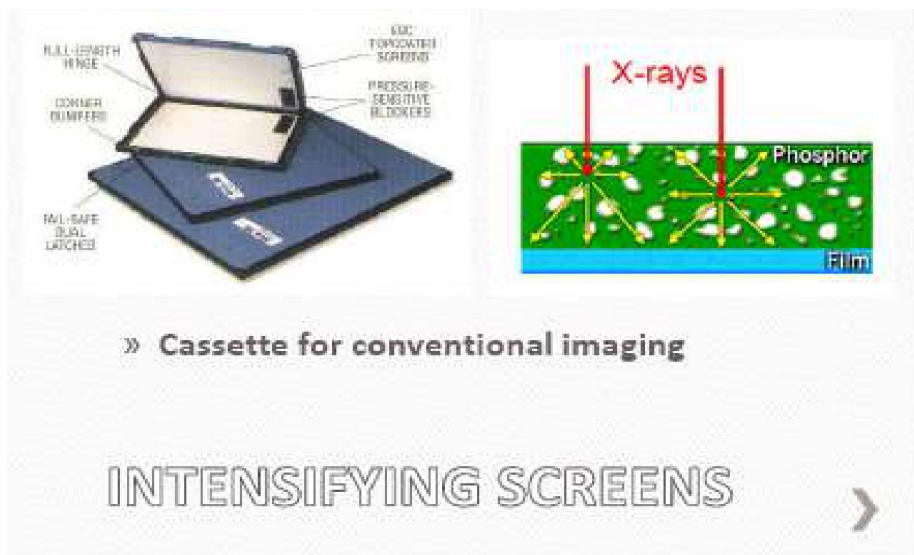
The higher the atomic number of a material, the more X-rays it will absorb; gold, with its atomic number of 79, absorbs much more X-rays than materials with lower atomic numbers, such as aluminum ($Z=13$).

شکل — چه چیزی در تصویر رادیوگرافی دیده می‌شود؟ تفاوت عدد اتمی و چگالی بخش‌های مختلف جسم، میزان جذب پرتو ایکس را تعیین می‌کند (طلا با $Z=79$ بیشتر از آلومینیوم با $Z=13$).

منبع: جزوه دکتر افصلی‌پور — ص ۵۴، ۵۸، ۶۲، ۶۴، ۶۶، ۶۷ (ص ۵۴)

- جذب فوتون‌ها در بدن: فوتون‌هایی که در بافت‌های گوناگون بدن جذب و به فیلم نمی‌رسند.
 - عبور فوتون‌ها: فوتون‌هایی که بدون برخورد در سر راهشان از بدن گذر کرده و به فیلم می‌رسند.
 - پرتوهای پراکنده: فوتون‌هایی که راستای حرکتشان کج شده و به فیلم تابش می‌کنند (اثر مخرب).
- منبع: جزوه دکتر افصلی‌پور ص ۵۵
- فیلم فتوگرافی، مهم‌ترین وسیله جهت ثبت و مشاهده اطلاعات است.
 - تصویر پنهان (Latent image) پیش از ظهور فیلم شکل می‌گیرد؛ شدت باریکه در سطح آشکارساز، حاصل پرتو اولیه پس از تضعیف و پرتوهای پراکنده است.
 - برای کاهش پرتوهای پراکنده از گرید ضدپراکندگی (Antiscatter Grid) و کولیماسیون اولیه (Primary collimation) استفاده می‌شود.

منبع: جزوه دکتر افصلی‌پور ص ۵۴ و ص ۵۶



» Cassette for conventional imaging

INTENSIFYING SCREENS

شکل — صفحه تشدیدکننده (Intensifying Screen) و کاست فیلم: صفحه فسفری فوتون‌های اشعه ایکس را به نور مرئی تبدیل می‌کند تا فیلم با دوز کمتر سیاه شود.

اسلایدهای دکتر افصلی‌پور — ص ۵۳

۳. ماده کنتراست

اگر کنتراست جسم وجود نداشته باشد، ممکن است با وارد کردن یک ماده با چگالی یا عدد اتمی متفاوت با دیگر بافت‌ها در یکی از بافت‌ها، به‌طور مصنوعی بین این بافت و دیگر بافت‌ها کنتراست ایجاد کرد.

منبع: جزوه دکتر افصلی‌پور ص ۵۷



شکل — سولفات باریم (Barium Sulfate) به‌عنوان ماده حاجب (Opaque): عدد اتمی و چگالی بالا، جذب زیاد پرتو ایکس و ایجاد کنتراست در بررسی دستگاه گوارش.

جزوه دکتر افصلی‌پور — ص ۵۴، ۵۸، ۶۲، ۶۴، ۶۶، ۶۷ (ص ۵۸)



شکل – ترکیبات یددار (Gastrografin و مانند آن) به عنوان ماده حاجب؛ ید با عدد اتمی بالا پرتو ایکس را به شدت جذب می‌کند.

منبع: دکتر افصلی‌پور – ص ۵۴، ۵۸، ۶۲، ۶۴، ۶۶، ۶۷ (ص ۵۸)

نوع ماده کنتراست	ویژگی	نمونه
مواد روشن (شفاف) Transparent	ایجاد یا پر کردن حفره‌ها با ماده‌ای شفاف	گازهایی مانند هوا، اکسیژن و CO ₂
ماده حاجب (Opaque)	ماده‌ای با عدد اتمی و چگالی بسیار بالا	ترکیبات ید و ترکیبات باریوم (Barium Sulfate)

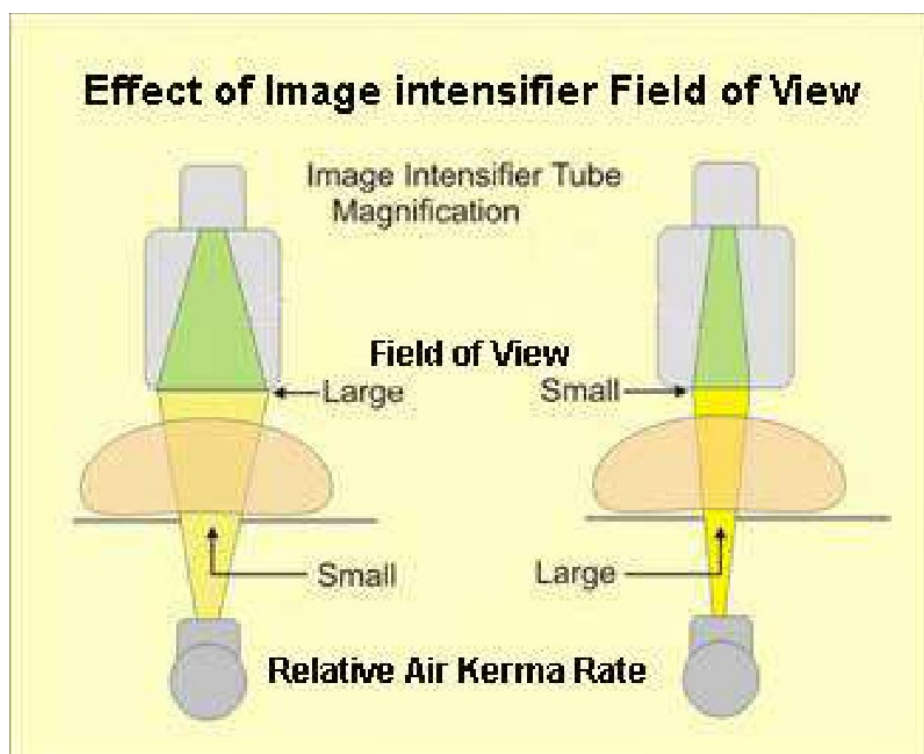
منبع: جزوه دکتر افصلی‌پور ص ۵۸

- اگر بافت مورد بررسی کاملاً یکنواخت باشد (مثل ریه پر از هوا یا بخش‌های نرم بدون تفاوت چگالی)، «کنتراست طبیعی» به وجود نمی‌آید؛ در این حالت با وارد کردن ماده حاجب، بین بافت و اطراف آن کنتراست مصنوعی ایجاد می‌کنیم.
- Barium Sulfate در سیستم گوارش (خوراکی یا تنقیه) و ترکیبات ید در آنژیوگرافی (تزریقی) کاربرد دارند.

منبع: منبع: ویدیو – دکتر افصلی‌پور، فیزیک پزشکی – جلسه ۳ (فایل ۱۸) – ۰۲:۵۹ تا ۰۵:۴۹

۴. فلوروسکوپی

تفاوت رادیوگرافی و فلوروسکوپی: در رادیولوژی ثبت لحظه‌ای انجام می‌شود، در فلوروسکوپی مشاهده عملکرد. در فلوروسکوپی، تصویر با مشاهده حرکت در بدن روی صفحه فلورسنت (مانیتور) و با استفاده از مواد کنتراست‌زا ایجاد می‌شود.

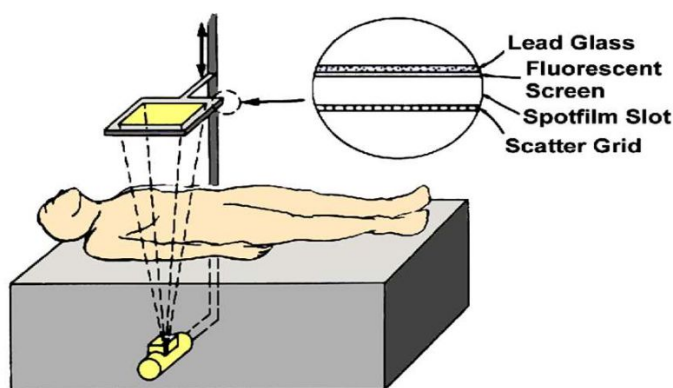


شکل – میدان دید در تقویت کننده تصویر (Image Intensifier): با بزرگ تر شدن میدان دید، سطح پرتوگیری و آهنگ کرمای هوا بیشتر می شود.

اسلایدهای دکتر افصلی پور – ص ۱۲۳

- کاربرد فلوروسکوپی: بررسی های معده و دوازدهه، مشاهده حرکت ماده حاجب در مسیر گوارشی (روده باریک و بزرگ با استفاده از باریم و هوا)، آنژیوگرافی، کاتتریزاسیون قلبی و
- در فلوروسکوپی از kVp بسیار پایین تر نسبت به رادیوگرافی معمولی استفاده می شود (زیرا هدف، مشاهده پیوسته با کمترین دز است).
- اجزای زنجیره تصویر: لامپ فلوروسکوپی، صفحه فلورسنت، Spotfilm، گرید پراکندگی و شیشه سربی (Lead Glass) برای حفاظت.

منبع: جزوه دکتر افصلی پور ص ۵۹



شکل – زنجیره تصویربرداری فلوروسکوپی: شیشه سربی (Lead Glass)، صفحه فلورسنت، Spotfilm، Slot Scatter Grid و لامپ اشعه ایکس.

اسلایدهای دکتر افصلی پور – ص ۵۹ «فلوروسکوپی»

۵. آنژیوگرافی

آنژیوگرافی از دو کلمه آنژیو به معنای رگ و گرافی به معنای ثبت کردن است. به فرایندی گفته می‌شود که با تزریق ماده حاجب از طریق کاتتر به جریان خون، آن را به صورت رادیوگرافی مشاهده می‌کنند.

منبع: جزوه دکتر افصلی پور ص ۶۰



شکل - پرتونگاری در اتاق آنژیوگرافی: کارکنان با روپوش سربی و پشت حفاظ، بیمار روی میز زیر دستگاه سی‌آر‌ام.

اسلایدهای دکتر افصلی پور - ص ۹۴



شکل - تیم پزشکی پشت حفاظ سربی در حین آنژیوگرافی: رعایت فاصله، زمان و حفاظت در عمل.

اسلایدهای دکتر افصلی پور - ص ۹۴

- مرگومیر ناشی از بیماری‌های عروق قلبی و مغزی رو به افزایش است؛ تجهیزاتی که بتوانند وضعیت قلبی را به صورت تصویر واضح روی فیلم یا مانیتور گزارش کنند، نقش مهمی در تشخیص و درمان دارند.

- موارد استفاده: مشاهده گرفتگی عروق، تومورهای عروقی (در قلب، مغز)، بیماری‌های لوزالمعده، انسداد موضعی عروق در ناحیه شکمی و سیستم سياهرگی.
- اصل کار: پرتوهای ایکس از قسمت بالایی دستگاه سی‌آرم به سمت ناحیه هدف تابانده می‌شود و رسپتورهایی در قسمت پایین دستگاه قرار دارند که این پرتوها را جذب می‌کنند.

منبع: جزوه دکتر افصلی‌پور ص ۶۰ و ص ۶۱



شکل – اصول عملکرد دستگاه سی‌آرم در آنژیوگرافی: پرتوهای ایکس از قسمت بالایی دستگاه (بالای تخت بیمار) به سمت آشکارساز زیر تخت می‌روند و پرتو پراکنده به سمت کارکنان می‌رسد؛ به همین دلیل رعایت فاصله، زمان و حفاظ، ستون‌های اصلی حفاظت در آنژیوگرافی است.

اسلایدهای دکتر افصلی‌پور – ص ۶۱

- تجهیزات اصلی دستگاه آنژیوگرافی: تیوب اشعه X، تقویت‌کننده‌های تصویر، گرید، کولیماتور، دوربین و لنزهای مربوطه، انژکتور اتوماتیک مواد حاجب، تخت آنژیوگراف و پایه سی‌آرم (C-Arm stand).

منبع: جزوه دکتر افصلی‌پور ص ۶۱



شکل - اتاق آنژیوگرافی: دستگاه سی‌آرم با تیوب اشعه ایکس در بالا و آشکارساز در پایین، در حال تصویربرداری از بیمار روی تخت.

اسلایدهای دکتر افصلی‌پور - ص ۱۲

۶. توموگرافی کامپیوتری (سی‌تی‌اسکن)

سی‌تی‌اسکن، تصویربرداری از اعضای داخل بدن در مقاطع یا برش‌های عرضی است؛ سیستمی که یک سری تصاویر مربوط به مقاطع نازک از بدن انسان را تهیه و با هدف تشخیصی در اختیار پزشک قرار می‌دهد. اطلاعات در طول یک اسکن از زوایای مختلف به دست می‌آید و حاصل هر اسکن، یک دسته تصویر از مقاطع بدن بیمار است. توموگرافی کامپیوتری نخستین بار در سال ۱۹۷۰ توسط هانسفیلد شکل گرفت.

منبع: جزوه دکتر افصلی‌پور ص ۶۲

- صفحه‌های تصویربرداری سی‌تی (Plane examples): برش‌ها در سه صفحه تهیه می‌شوند - محوری (Axial، مقطع عرضی)، کروئال (Coronal، مقطع پیشانی‌پشتی) و ساژیتال (Sagittal، مقطع جانبی).

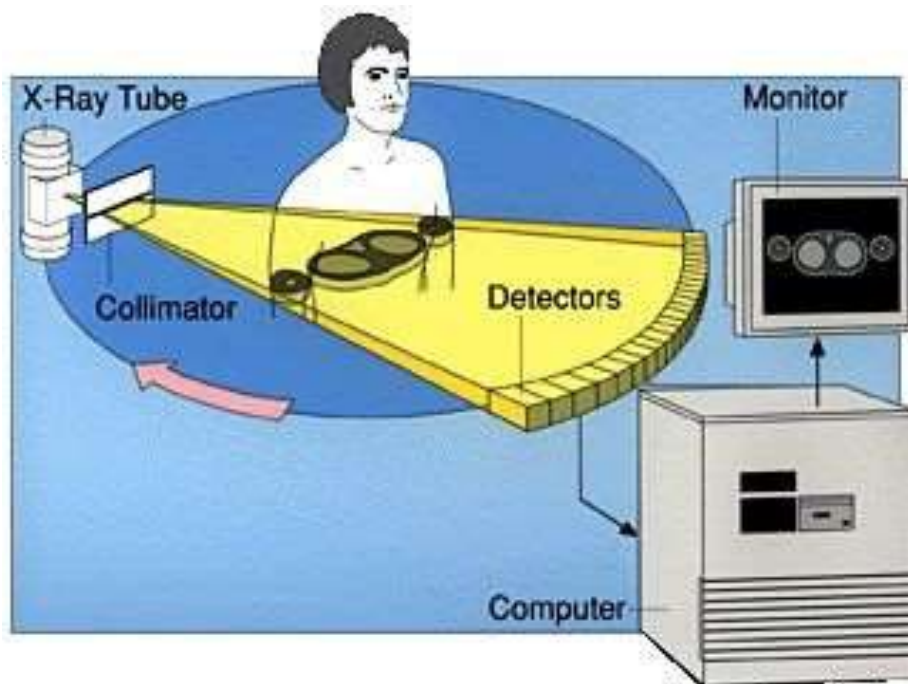
منبع: جزوه دکتر افصلی‌پور ص ۱۴

- تابش پرتو ایکس در زوایای مختلف به یک برش مقطعی از بدن.
- رسیدن پرتوهای عبورکرده به آشکارساز.
- تبدیل پرتوها به جریان الکتریکی توسط آشکارساز.
- ارسال اطلاعات یک نما به کامپیوتر.
- پردازش اطلاعات هر نما و شکل‌گیری تصویر یک مقطع.

منبع: جزوه دکتر افصلی‌پور ص ۶۲



شکل – دستگاه سی‌تی‌اسکن و میز کاربر (Operator Console): تعیین پارامترهای اسکن، نمایش، ذخیره‌سازی و بازیابی تصاویر.
جزوه دکتر افصلی‌پور – ص ۵۴، ۵۸، ۶۲، ۶۴، ۶۶، ۶۷ (ص ۶۴)



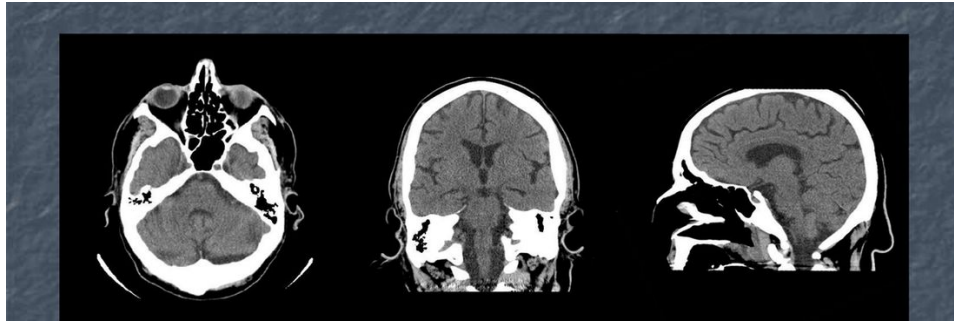
شکل - شمای سیستم سی‌تی‌اسکن: تیوب اشعه ایکس، کولیماتور، آشکارسازها، کامپیوتر و مانیتور؛ پرتوهای عبورکرده به آشکارساز می‌رسند و پس از تبدیل به جریان الکتریکی به کامپیوتر می‌روند.
جزوه دکتر افصلی‌پور - ص ۵۴، ۵۸، ۶۲، ۶۴، ۶۶، ۶۷ (ص ۶۲)

جزء اصلی	اجزا و نقش
گانتري (Gantry)	شامل تیوب اشعه X، آشکارساز، واحدهایی برای چرخش تیوب و آشکارساز و تونلی برای وارد شدن بیمار به وسط گانتري
تخت (Table)	قرار دادن بیمار در موقعیت اسکن
کامپیوتر (Console)	ارتباط با واحدهای مختلف، نظارت و کنترل عملکرد آن‌ها در مدت اسکن، پردازش داده‌ها و انتقال و نمایش تصاویر
واحدهای پردازشی	واحد بازسازی و پردازش تصویر، واحد نمایش تصویر، واحد کنترل حرکت گانتري و تخت
میز کاربر (Operator Console)	رابط دستگاه با کاربر: تعیین پارامترهای اسکن، تعیین شیوه نمایش تصاویر، ذخیره‌سازی و بازیابی تصاویر

منبع: جزوه دکتر افصلی‌پور ص ۶۴

- کاربردهای سی‌تی‌اسکن: تشخیص بیماری‌های مغز و اعصاب، نشان دادن موارد اورژانسی بیماری‌های مغزی (قادر به تشخیص خون تازه و کهنه)، تشخیص بیماری‌های مادرزادی مانند بزرگی یا کوچکی جمجمه، تشخیص تومورهای داخل جمجمه‌ای و خارج مغزی، تشخیص خونریزی در قسمت‌های مختلف مغز و سکتة مغزی، تشخیص بیماری‌های اعضای داخل شکم مانند کبد، لوزالمعده و غدد فوق کلیه و بررسی بیماری‌های ریه.

منبع: جزوه دکتر افصلی‌پور ص ۶۳



شکل - برش‌های سی‌تی مغز: توانایی سی‌تی‌اسکن در نشان دادن خون تازه و کهنه، تومورها و ضایعات داخل جمجمه.

اسلایدهای دکتر افضلی‌پور - ص ۱۴



شکل - دستگاه سی‌تی‌اسکن: گانتری (تیوب و آشکارساز چرخان) و تخت بیمار.

اسلایدهای دکتر افضلی‌پور - ص ۱۳

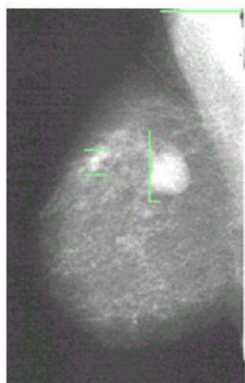
۷. ماموگرافی

- ماموگرافی برای آسیب‌شناسی و تشخیص سرطان سینه به‌کار می‌رود.
- در آمریکا، از هر ۸ نفر زن، یک نفر در طول عمر دچار بیماری سرطان سینه می‌شود.
- سرطان سینه ۳۲٪ کل سرطان‌ها می‌باشد و ۱۸٪ سرطان‌های سینه موجب مرگ می‌شوند.
- با ماموگرافی می‌توان با هزینه و دز نسبتاً کم، سرطان سینه را در مراحل اولیه تشخیص و درمان کرد.
- در آمریکا در سال ۱۹۹۳ قانون کیفیت ماموگرافی تصویب شده است.

منبع: جزوه دکتر افضلی‌پور ص ۶۵

- غربالگری ماموگرافی: برای تشخیص به‌موقع سرطان سینه در برخی کشورها برنامه غربالگری پیشنهاد شده است؛ خانم‌ها در سنین بین ۴۰ تا ۵۰ سال هر دو سال یک‌بار و ۵۰ سال به بالا هر سال یک‌بار تحت آزمایشات ماموگرافی قرار گیرند.
- نماهای استاندارد: Cranio-Caudal (CC) و Medio-Lateral Oblique (MLO)؛ آزمایشات باید روی هر دو سینه انجام شود.

مقدمه



- ماموگرافی برای آسیب شناسی و تشخیص سرطان سینه بکار می رود.
- در آمریکا ، از هر ۸ نفر زن ، یک نفر سرطان دچار بیماری سرطان سینه می شود.
- سرطان سینه 32% کل سرطان ها می باشد.
- 18% سرطان های سینه موجب مرگ شده است.
- با ماموگرافی میتوان با هزینه و دز نسبتاً کم، سرطان سینه را در مراحل اولیه تشخیص و درمان کرد.
- در آمریکا در سال ۱۹۹۲ قانون کیفی ماموگرافی تصویب شده است.



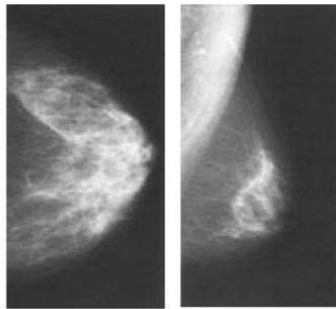
شکل – ماموگرافی برای تشخیص سرطان سینه: در آمریکا از هر ۸ زن یک نفر در طول عمر دچار سرطان سینه می شود؛ سرطان سینه 32% کل سرطان ها و 18% مرگ های ناشی از سرطان است؛ با ماموگرافی می توان با هزینه و دز نسبتاً کم، سرطان را در مراحل اولیه تشخیص داد و درمان کرد (قانون کیفیت ماموگرافی، سال 1992 در آمریکا).

اسلایدهای دکتر افصلی پور – ص ۶۵

غربال گری ماموگرافی Mammography Screening

برای تشخیص بموقع سرطان سینه در برخی از کشور ها برنامه ای غربال گری ماموگرافی پیشنهاد شده است.

در برنامه غربال گری باید خانمها در سنین بین ۴۰ تا ۵۰ سال هر دو سال یکبار و ۵۰ سال به بالا هر سال یکبار تخت آزمایشات ماموگرافی زیر قرار گیرند:



CC

MLO

1. Cranio-Caudal (CC),
2. Medio-Lateral Oblique (MLO)

آزمایشات باید روی هر دو سینه انجام شود.

شکل — نماهای استاندارد ماموگرافی غربالگری: Cranio-Caudal (CC) و Medio-Lateral Oblique (MLO); آزمایش باید روی هر دو سینه انجام شود.

جزوه دکتر افصلی پور — ص ۵۴، ۵۸، ۶۲، ۶۴، ۶۶، ۶۷ (ص ۶۶)

• اجزای زنجیره تصویربرداری ماموگرافی: تیوب ایکس، کمپرسور، گرید، فیلم و AEC (کنترل خودکار اکسپوژر).

منبع: جزوه دکتر افصلی پور ص ۶۷

۲- تجهیزات اصلی



۱. ژنراتور
۲. تیوب ایکس
۳. کمپرسور
۴. گرید
۵. فیلم
۶. AEC

شکل — تجهیزات ماموگرافی و اجزای آن: تیوب اشعه ایکس، کمپرسور، گرید، فیلم و AEC (کنترل خودکار اکسپوژر).

اسلایدهای دکتر افصلی پور — ص ۶۷

۸. کنترل خودکار اکسپوژر و عوامل تکنیکی

در بیشتر تجهیزات جدید اشعه ایکس از یک سیستم زمان سنج نوری (AEC – کنترل خودکار تابش) استفاده می‌شود. این سیستم مقدار تشعشع خروجی از بدن بیمار را اندازه‌گیری و میزان تابش مناسب فیلم برای کیفیت تشخیص خوب را تعیین می‌کند؛ استفاده از زمان سنج نوری مقدار تابش‌گیری بیمار را کاهش می‌دهد.

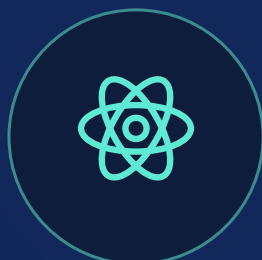
منبع: جزوه دکتر افصلی پور ص ۷۸

- گاهی زمان‌سنج‌های نوری از کار می‌افتند و هنوز این احتمال وجود دارد که پرتونگار با توجه به اندازه آناتومیکی بیمار، kVp یا mA نامناسبی را انتخاب کند؛ در چنین مواردی استفاده از نمودار شرایط می‌تواند با ارزش باشد.
- اسمیت و همکارانش (۱۹۸۹) و پلات (۱۹۹۳) نشان دادند وجود زمان‌سنج‌ها برای پرتونگاران کم‌تجربه با ارزش است؛ تفاوتی در میزان تابش‌گیری به‌وسیله پرتونگاران با تجربه که زمان‌سنج را به‌کار برده‌اند، مشاهده نشد.

منبع: جزوه دکتر افصلی پور ص ۷۹ و ص ۸۰

مرور سریع

- پیش از ورود به بدن، توزیع فوتون‌ها یکنواخت و بی‌اطلاعات است؛ تصویر از تفاوت تضعیف در بافت‌ها ساخته می‌شود.
- جذب، عبور و پراکندگی: سه سرنوشت فوتون؛ گرید ضدپراکندگی و کولیماسیون برای کاهش پرتو پراکنده.
- جذب پرتو ایکس با عدد اتمی، چگالی، ضخامت و ترکیب ماده رابطه دارد (طلا $Z=79$ در برابر آلومینیوم $Z=13$).
- مواد کنتراست: شفاف/روشن (هوا، CO_2) و حاجب (ترکیبات ید و باریم).
- فلوروسکوپی = مشاهده عملکرد؛ رادیوگرافی = ثبت لحظه‌ای.
- آنژیوگرافی: تزریق ماده حاجب با کاتتر و تصویربرداری با سی‌آرم.
- سی‌تی‌اسکن: برش‌های عرضی؛ ۱۹۷۰ هانسفیلد؛ پنج مرحله از تابش تا پردازش؛ گانتری، تخت، کنسول.
- ماموگرافی: نماهای CC و MLO؛ غربالگری ۴۰-۵۰ سال هر دو سال و بالای ۵۰ سال هر سال.



فصل ۴

رادیواکتیویته، واپاشی‌ها و پزشکی هسته‌ای

دکتر حق پرست

صفحه‌های ۴۱ تا ۵۴

۶

جدول

۳

شکل

۹۲

بخش

۱. مواد رادیواکتیو

مواد رادیواکتیو موادی هستند که به طور خودبه خودی از خود پرتوهای یون ساز نشر می کنند. موادی که قادر به نشر این پرتوهای یون ساز هستند، مواد رادیواکتیو نامیده می شوند که دو دسته اند: (۱) مواد رادیواکتیو طبیعی: موادی که به طور طبیعی ناپایداری هسته دارند. (۲) مواد رادیواکتیو مصنوعی: موادی که به طور طبیعی پایدار بوده و به صورت مصنوعی در یک فرآیند هسته ای، آن ها را ناپایدار می سازند.

منبع: اسلایدهای M.Ph.D – دکتر حق پرست اسلاید «مواد رادیواکتیو»؛ جزوه فیزیک تشعشع و پزشکی هسته ای – دکتر حق پرست ص ۱۴

- مواد رادیواکتیو طبیعی: موادی که به طور طبیعی ناپایداری هسته دارند؛ مانند اورانیوم-235، اورانیوم-238 و توریوم که طی میلیاردها سال به مواد پایدار مانند سرب تبدیل می شوند.
- مواد رادیواکتیو مصنوعی در آزمایشگاه، راکتورها (از طریق واکنش شکاف) یا شتاب دهنده ها تولید می شوند؛ برای این کار یا نسبت پروتون به نوترون را به هم می زنیم یا نوترون را به یک ماده پایدار اضافه می کنیم. نمونه هایی از این مواد مصنوعی: سزیوم، تکنسیوم و کبالت.

منبع: جزوه فیزیک تشعشع و پزشکی هسته ای – دکتر حق پرست ص ۱۴

۲. رادیواکتیویته و اصطلاحات هسته ای

- تابش خودبه خودی اشعه از یک ماده را رادیواکتیویته می نامند؛ به ساطع کردن پرتو، تجزیه، استحاله یا دیکی (Decay) می گویند.
- هسته اصلی در هر استحاله را اصطلاحاً «هسته مادر» و هسته به وجود آمده پس از استحاله را «هسته دختر» می نامند.
- استحاله هسته ها اغلب با تابش آلفا، بتا و گاما صورت می گیرد.

منبع: جزوه فیزیک تشعشع و پزشکی هسته ای – دکتر حق پرست ص ۱۵؛ اسلایدهای M.Ph.D – دکتر حق پرست اسلاید «رادیواکتیویته»

نوع استحاله	شرط	تغییر A و Z
آلفا (α)	عدد اتمی بزرگتر از 83	$A - 4$ و $Z - 2$
بتای منفی (β^-)	نسبت N/P بیشتر از حد تعادل	A ثابت و $Z + 1$
بتای مثبت (β^+)	N/P کمتر از حد تعادل + اختلاف انرژی بیشتر از 1.022 MeV	A ثابت و $Z - 1$
گیراندازی الکترون (EC)	فقط N/P کمتر از حد تعادل	A ثابت و $Z - 1$
واپاشی گاما (γ)	هسته دختر در حالت برانگیخته	بدون تغییر در A و Z

منبع: جزوه فیزیک تشعشع و پزشکی هسته ای – دکتر حق پرست ص ۱۵ و ص ۲۸ تا ص ۳۴

۳. واپاشی آلفا

- ذره آلفا ذره ای با بار مثبت دوگانه و جرم زیاد (معادل 4 واحد جرم اتمی؛ شامل 2 پروتون و 2 نوترون) است.
- قدرت نفوذ آن بسیار کم است – در هوا در حد سانتی متر و در بافت بدن در حد میکرون؛ حتی یک برگ کاغذ معمولی می تواند آن را متوقف کند.

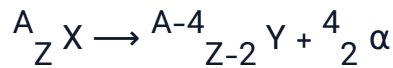
• طیف انرژی آن خطی و تک‌انرژی (Mono-energy) است (برخلاف بتا که طیف پیوسته دارد).

• در میدان‌های الکتریکی و مغناطیسی منحرف می‌شود.

منبع: جزوه فیزیک تشعشع و پزشکی هسته‌ای – دکتر حق‌پرست ص ۱۷؛ جزوه دکتر افضل‌پور ص ۲۴ و ص ۲۵

شرط وقوع: عدد اتمی عنصر باید بیشتر از 83 (عنصر سنگین) باشد. در این حالت، نیروی دافعه کولنی میان پروتون‌های زیاد هسته بر نیروی جاذبه هسته‌ای غلبه کرده و ذره آلفا (2 پروتون + 2 نوترون) از هسته پرتاب می‌شود.

منبع: جزوه فیزیک تشعشع و پزشکی هسته‌ای – دکتر حق‌پرست ص ۱۷



معادله واپاشی آلفا

در اثر واپاشی آلفا، عدد اتمی هسته دختر 2 واحد و عدد جرمی آن 4 واحد نسبت به هسته مادر کاهش می‌یابد

منبع: جزوه فیزیک تشعشع و پزشکی هسته‌ای – دکتر حق‌پرست ص ۱۷ و ص ۱۸؛ اسلایدهای M.Ph.D – دکتر حق‌پرست اسلاید «Alpha Decay»

مثال: اورانیوم-238 با نیمه‌عمر 4.49×10^9 سال، با تابش آلفا (انرژی 4.19 MeV) به توریم-234 تبدیل می‌شود.

منبع: جزوه فیزیک تشعشع و پزشکی هسته‌ای – دکتر حق‌پرست ص ۱۸؛ اسلایدهای M.Ph.D – دکتر حق‌پرست اسلاید «Alpha Decay»

• جمع‌بندی مثال اورانیوم-238 از زبان استاد: 92 پروتون و 146 نوترون هسته مادر، پس از واپاشی آلفا به هسته‌ای با 90 پروتون و 144 نوترون (توریم-234) تبدیل می‌شود؛ یعنی عدد اتمی 2 واحد و عدد جرمی 4 واحد کم می‌شود.

• انرژی ذره آلفای گسیلی در این واپاشی 4.19 MeV و «تک‌انرژی» است – برخلاف بتا که طیف پیوسته دارد.

منبع: منبع: ویدیو – دکتر حق‌پرست، فیزیک پزشکی تشعشع – جلسه ۲ (فایل ۱۲) – ۵:۰۰ تا ۵:۰۹

نکته کلیدی: خطر اصلی آلفا «پرتوگیری داخلی» است، نه خارجی: اگرچه ذره آلفا با لایه شاخی پوست جذب می‌شود، در صورت تزریق یا تنفس (مثلاً گاز رادون) به دلیل قدرت یونیزاسیون بالای آن از بتا و اشعه ایکس خطرناک‌تر است و می‌تواند آسیب‌های جبران‌ناپذیری به تیروئید، کبد و استخوان وارد کند.

۴. واپاشی بتای منفی (نگاترون)

• ذره‌ای با بار منفی و سرعت زیاد است؛ شدیداً در میدان الکتریکی منحرف می‌شود و با یک ورقه آلومینیومی با ضخامت چند میلی‌متر متوقف می‌شود.

• قدرت یونیزاسیون کم، بار $Z = -1$ و قابلیت نفوذ متوسط دارد.

• برخلاف آلفا، طیف انرژی آن پیوسته (Poly-energy) است.

• ذره بتا دارای بار کولن و جرم ایستای مشخص (برابر الکترون) است؛ بیناب یک تابش‌کننده خالص بتا دارای پیوستگی است و از صفر تا یک اندازه بیشینه E_{max} تغییر می‌کند.

منبع: جزوه فیزیک تشعشع و پزشکی هسته‌ای – دکتر حق‌پرست ص ۲۰ و ص ۲۲؛ اسلایدهای M.Ph.D – دکتر حق‌پرست اسلاید «اشعه نگاترون»

شرط وقوع: این واکنش زمانی رخ می‌دهد که نسبت نوترون به پروتون (N/P) در هسته بیشتر از حد تعادل (نسبت عنصر پایدار در جدول تناوبی) باشد – یعنی هسته دچار مازاد نوترون است. این فرایند ایزوباریک می‌باشد؛ یعنی عدد جرمی A ثابت می‌ماند اما عدد اتمی Z یک واحد افزایش می‌یابد.



معادله واپاشی بتای منفی

در این فرایند یک نوترون در داخل هسته به یک پروتون تبدیل شده و یک ذره بتا به همراه یک آنتی‌نوترینو ساطع می‌شود
A ثابت و 1 + Z

منبع: جزوه فیزیک تشعشع و پزشکی هسته‌ای - دکتر حق‌پرست ص ۲۱؛ اسلایدهای M.Ph.D - دکتر حق‌پرست اسلاید «Beta Decay»

مثال	محصول	نیمه‌عمر	انرژی بتا
کربن-14	نیتروژن-14	5730 yr	0.156 MeV
فسفر-32	گوگرد-32	—	—

منبع: جزوه فیزیک تشعشع و پزشکی هسته‌ای - دکتر حق‌پرست ص ۲۱

- مثال کربن-14: هسته مادر 6 پروتون و 8 نوترون دارد و پس از واپاشی بتای منفی به نیتروژن-14 با 7 پروتون و 7 نوترون تبدیل می‌شود؛ عدد جرمی 14 ثابت می‌ماند (فرایند ایزوباریک).
- طیف بتا از انرژی کم تا بیشینه (Emax) ادامه دارد و «انرژی متوسط» حدود 156 keV است؛ در محاسبات عملی معمولاً همین انرژی متوسط در نظر گرفته می‌شود.
- دلیل پیوستگی طیف: انرژی حاصل، به صورت آماری بین ذره بتا و آنتی‌نوترینو تقسیم می‌شود؛ سهم بتا از صفر تا بیشینه تغییر می‌کند.

منبع: منبع: ویدیو - دکتر حق‌پرست، فیزیک پزشکی تشعشع - جلسه ۲ (فایل ۱۲) - ۱۲:۴۱ تا ۱۶:۳۷

ذره ۷ «آنتی‌نوترینو» نام دارد. نوترینو و آنتی‌نوترینو دارای جرم صفر و بدون بار هستند و با سرعت نور حرکت می‌کنند؛ تفاوت میان این دو ذره تنها در «اسپین» آن‌هاست.

منبع: جزوه فیزیک تشعشع و پزشکی هسته‌ای - دکتر حق‌پرست ص ۲۲

نکته کلیدی: علت پیوسته‌بودن طیف بتا: در واپاشی بتا، انرژی حاصل به صورت شانسی و آماری میان ذره بتا و ذره همراه (آنتی‌نوترینو یا نوترینو) تقسیم می‌شود؛ به همین دلیل انرژی بتا از صفر تا یک مقدار بیشینه (Emax) متغیر است.

۵. واپاشی بتای مثبت (پوزیترون) و پدیده فنا

- پوزیترون ذره‌ای مشابه الکترون با بار مثبت و بسیار ناپایدار است؛ عمر آن حدود 10^{-7} ثانیه است.
- پس از تولید، با الکترون ترکیب می‌شود و دو فوتون با انرژی 0.511 مگا‌الکترون‌ولت تولید می‌کند؛ این پدیده را «محو ذرات» یا فنا (Annihilation) می‌گویند.
- کاربرد آن در دستگاه PET (پزشکی هسته‌ای) است.
- از نظر جرم، قدرت نفوذ، مسیر حرکت و برد، کاملاً مشابه ذرات بتای منفی است؛ اما با بار مثبت و بسیار ناپایدار.

- برخلاف بتای منفی که پس از اتمام انرژی به صورت یک الکترون آزاد باقی می ماند، پوزیترون پس از ازدست دادن انرژی با یک الکترون محیط ترکیب می شود.

منبع: جزوه فیزیک تشعشع و پزشکی هسته ای – دکتر حق پرست ص ۲۴؛ اسلایدهای M.Ph.P.D – دکتر حق پرست اسلاید «اشعه پوزیترون»

شرط وقوع (دو شرط همزمان): ۱) نسبت نوترون به پروتون (N/P) از حد تعادل کمتر باشد (هسته دچار کمبود نوترون است). ۲) اختلاف انرژی بین هسته مادر و دختر باید بیشتر از 1.022 مگا الکترون ولت باشد (معادل جرم دو الکترون).

منبع: جزوه فیزیک تشعشع و پزشکی هسته ای – دکتر حق پرست ص ۲۴ و ص ۲۵



معادله واپاشی بتای مثبت

یک پروتون به یک نوترون تبدیل شده و یک بتای مثبت، یک نوترینو و انرژی ساطع می شود
برای واپاشی پوزیترون، انرژی لازم باید توسط هسته مادر در دسترس باشد: انرژی مورد نیاز = جرم ذره پوزیترون به اضافه جرم ماده (الکترون)؛
بنابراین انرژی $2m_e c^2$ است

منبع: جزوه فیزیک تشعشع و پزشکی هسته ای – دکتر حق پرست ص ۲۵؛ اسلایدهای M.Ph.P.D – دکتر حق پرست اسلاید «Beta+ Decay»

مثال: مس-64 با نیمه عمر 12.71 ساعت به نیکل-64 تبدیل می شود.

منبع: جزوه فیزیک تشعشع و پزشکی هسته ای – دکتر حق پرست ص ۲۵؛ اسلایدهای M.Ph.P.D – دکتر حق پرست اسلاید «Beta+ Decay»

- مثال واپاشی بتای مثبت: گالیوم-68 (Ga-68، عدد اتمی 31) به روی-68 (Zn-68، عدد اتمی 30) تبدیل می شود؛ عدد جرمی ثابت می ماند اما عدد اتمی یک واحد کم می شود (30 → 31). در ویدیو نام عنصر به اشتباه «گادولینیوم» گفته می شود؛ عدد اتمی 31 در جدول تناوبی به گالیوم (Ga) تعلق دارد.
- کاربرد بالینی: Ga-68 امروزه در رادیوداروهای PET (مثلاً Ga-68-DOTATATE برای تومورهای نورواندوکراین) به کار می رود.

منبع: منبع: ویدیو – دکتر حق پرست، فیزیک پزشکی تشعشع – جلسه ۴ (فایل ۱۶) – ۸:۳۲؛ اسلایدهای M.Ph.P.D – «Beta+ Decay»

- مثال مس-64: هسته مادر 29 پروتون و 35 نوترون دارد و با واپاشی بتای مثبت به نیکل-64 با 28 پروتون و 36 نوترون می رسد؛ انرژی متوسط بتای مثبت حدود 0.656 MeV و نیمه عمر ۱۲.۷۱ ساعت است.
- نکته محاسباتی استاد: در واپاشی بتای مثبت، باید انرژی معادل جرم «پروتون به علاوه الکترون» (یعنی $2m_e c^2 = 1.022 \text{ MeV}$) از انرژی مادر-دختر کنار گذاشته شود؛ باقی مانده به صورت انرژی جنبشی بین بتای مثبت و نوترینو تقسیم می شود – همین موضوع دلیل شرط 1.022 MeV است.

منبع: منبع: ویدیو – دکتر حق پرست، فیزیک پزشکی تشعشع – جلسه ۳ (فایل ۱۳) – ۹:۳۶ تا ۱۳:۱۲

پدیده فنا: هنگامی که پوزیترون پس از توقف با یک الکترون محیط برخورد می کند، جرم هر دو ذره به انرژی تبدیل می شود. طبق رابطه انیشتین ($E = mc^2$)، انرژی معادل جرم یک الکترون (یا پوزیترون) برابر با 511 keV است؛ فای دو ذره جرم دار به تولید دو فوتون با همین مقدار انرژی می انجامد؛ بنابراین انرژی کل لازم برای این پدیده $2m_e c^2$ (معادل 1.022 MeV) است – همان شرط دوم واپاشی بتای مثبت.

منبع: جزوه فیزیک تشعشع و پزشکی هسته ای – دکتر حق پرست ص ۲۶؛ اسلایدهای M.Ph.P.D – دکتر حق پرست اسلاید «پدیده محو ذرات (فنا)»

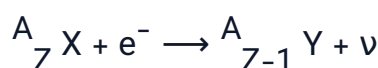
۶. گیراندازی الکترون (Electron Capture)

شرط وقوع: برخلاف بتای مثبت که به دو شرط نیاز داشت، در گیراندازی الکترون تنها یک شرط کافی است: نسبت نوترون به پروتون کمتر از حد تعادل باشد. نیازی به برقراری اختلاف انرژی 1.022 MeV نیست.

منبع: جزوه فیزیک تشعشع و پزشکی هسته‌ای - دکتر حق‌پرست ص ۲۸

فرایند: الکترون یکی از مدارهای داخلی (معمولاً لایه K) توسط هسته جذب می‌شود و با یک پروتون ترکیب می‌شود تا یک نوترون و یک نوترینو بسازد. مانند بتای مثبت، در این فرایند عدد اتمی Z یک واحد کاهش می‌یابد اما عدد جرمی A ثابت می‌ماند.

منبع: جزوه فیزیک تشعشع و پزشکی هسته‌ای - دکتر حق‌پرست ص ۲۸



معادله گیراندازی الکترون

نمونه: $40K + e^- \rightarrow 40Ar + \nu$ (پتاسیم-40 به آرگون-40)

A ثابت و Z - 1

منبع: جزوه فیزیک تشعشع و پزشکی هسته‌ای - دکتر حق‌پرست ص ۲۸؛ اسلایدهای M.Ph.D - دکتر حق‌پرست اسلاید «Electron Capture»

رقابت میان بتای مثبت و گیراندازی الکترون: اگر هر دو شرط بتای مثبت (کمبود نوترون + اختلاف انرژی بیش از 1.022 MeV) هم‌زمان برقرار باشند، هسته می‌تواند از هر دو مسیر واپاشی کند؛ در این حالت، بر پایه آماری که استاد ذکر کرده، حدود 90% از واپاشی‌ها به روش بتای مثبت و حدود 10% به روش گیراندازی الکترون رخ می‌دهد. اگر تنها شرط اول برقرار باشد ولی اختلاف انرژی کافی نباشد، تنها گیراندازی الکترون ممکن است.

منبع: جزوه فیزیک تشعشع و پزشکی هسته‌ای - دکتر حق‌پرست ص ۲۸

- تابش فوتون گاما: اگر هسته دختر در حالت برانگیخته باشد، با تابش گاما به پایداری می‌رسد.
- اشعه ایکس اختصاصی (Characteristic X-ray): به دلیل جدا شدن الکترون از لایه K و پر شدن جای خالی آن توسط الکترون‌های لایه‌های بالاتر، فوتون ایکس اختصاصی تولید می‌شود.
- الکترون اوژه (Auger Electron): گاهی فوتون ایکس اختصاصی تولید شده، به جای خروج از اتم، به یک الکترون مداری دیگر برخورد کرده و آن را پرتاب می‌کند؛ به این پدیده «فوتوالکتریک داخلی» نیز می‌گویند.

منبع: جزوه فیزیک تشعشع و پزشکی هسته‌ای - دکتر حق‌پرست ص ۲۹

نکته کلیدی: پتاسیم-40 نمونه جالبی است که می‌تواند از دو مسیر مختلف واپاشی کند: از یک مسیر به کلسیم-40 (بتای منفی) و از مسیر دیگر با گیراندازی الکترون به آرگون-40.

۷. تابش گاما و تبدیل داخلی

- پرتو گاما از جنس امواج الکترومغناطیسی است؛ بار الکتریکی و جرم ندارد و با سرعت نور حرکت می‌کند.
- هیچ رادیوایزوتوپ طبیعی صرفاً تابش گاما ندارد؛ تابش گاما معمولاً پس از واپاشی آلفا، بتا یا گیراندازی الکترون رخ می‌دهد. یعنی هسته دختر ابتدا در حالت برانگیخته (متاستابل) قرار می‌گیرد و سپس با گسیل فوتون گاما به حالت پایه می‌رسد.

• تابش گاما هیچ تغییری در عدد جرمی A و عدد اتمی Z هسته ایجاد نمی‌کند.

• نمونه معادله: $^{87}\text{Sr} \rightarrow ^{87}\text{Sr} + \gamma$ با نیمه‌عمر 2.806 hr و انرژی گاما 0.388 MeV.

منبع: جزوه فیزیک تشعشع و پزشکی هسته‌ای – دکتر حق‌پرست ص ۳۲ و ص ۳۳؛ اسلایدهای M.Ph.D – دکتر حق‌پرست اسلاید «Gamma Ray Emission»

تفاوت پرتو ایکس و گاما تنها در منشأ تولید است، نه در ماهیت فیزیکی: پرتو ایکس از مدارهای الکترونی اتم (دستگاه رادیولوژی) و پرتو گاما از داخل هسته (رادیواکتیو) تولید می‌شود؛ هر دو موج الکترومغناطیس و بدون بار و جرم‌اند.

منبع: جزوه فیزیک تشعشع و پزشکی هسته‌ای – دکتر حق‌پرست ص ۳۳

تبدیل داخلی (Internal Conversion - IC): در برخی موارد، فوتون گامای تولیدشده در هسته فرصت خروج پیدا نمی‌کند؛ گاهی این فوتون پیش از خروج با یکی از الکترون‌های لایه‌های داخلی (مداری، معمولاً K یا L) برخورد کرده و تمام انرژی خود را به آن الکترون منتقل می‌کند. در نتیجه به جای گسیل فوتون گاما، یک «الکترون تبدیل» (Conversion Electron) از اتم پرتاب می‌شود.

منبع: جزوه فیزیک تشعشع و پزشکی هسته‌ای – دکتر حق‌پرست ص ۳۳ و ص ۳۴

نکته کلیدی: در تبدیل داخلی، پرتو گاما اصلاً از هسته خارج نمی‌شود؛ انرژی آن به‌طور کامل صرف پرتاب الکترون مداری همان اتم می‌شود. تبدیل داخلی را با فوتوالکتریک اشتباه نگیرید: تبدیل داخلی، برهم‌کنش انرژی هسته با الکترون مداری همان اتم است، نه برهم‌کنش یک پرتو خارجی با ماده.

۸. جمع‌بندی مقایسه‌ای انواع واپاشی

واپاشی	نمونه	تغییر Z	شرط
آلفا	$\text{U-238} \rightarrow \text{Th-234}$	$Z - 2$	عدد اتمی بیش از 83 ($2p + 2n$)
بتای منفی	$\text{C-14} \rightarrow \text{N-14}$	$Z + 1$	نسبت N/P بیشتر از حد تعادل (مازاد نوترون)
بتای مثبت	$\text{Cu-64} \rightarrow \text{Ni-64}$	$Z - 1$	N/P کمتر + اختلاف انرژی بیش از 1.022 MeV
گیراندازی الکترون	$\text{K-40} \rightarrow \text{Ar-40}$	$Z - 1$	N/P کمتر (اختلاف انرژی لازم نیست)
گاما	$\text{Sr-87m} \rightarrow \text{Sr-87}$	بدون تغییر	هسته دختر برانگیخته

منبع: جزوه فیزیک تشعشع و پزشکی هسته‌ای – دکتر حق‌پرست ص ۳۰ و ص ۳۱

نکته امتحانی: الگوریتم تشخیص نوع واپاشی (از نکات مرور منبع): آیا عدد اتمی عنصر بیشتر از 83 است؟ → احتمال واپاشی آلفا. آیا هسته نوترون اضافی دارد (N/P بالا)؟ → واپاشی بتای منفی. آیا هسته نوترون کم دارد (N/P پایین)؟ اگر اختلاف انرژی مادر/ دختر بیش از 1.022 MeV باشد → بتای مثبت (با رقابت جزئی EC)؛ در غیر این صورت → فقط گیراندازی الکترون. در هر مسیر، اگر هسته دختر برانگیخته بماند → تابش گاما تکمیلی رخ می‌دهد.

۹. اکتیویته و قوانین واپاشی

اکتیویته عبارت است از نسبت هسته‌هایی که در واحد زمان واپاشی می‌شوند. اگر N هسته رادیونوکلئید داشته باشیم: $A = -dN/dt$ و $A = \lambda N$ که λ (لاندا) ثابت واپاشی است: احتمال واپاشی یک هسته رادیونوکلئید در واحد زمان. واحد λ عکس زمان است (s^{-1}) یا $hour^{-1}$ ؛ هرچه λ بزرگ‌تر باشد، واپاشی سریع‌تر رخ می‌دهد.

منبع: جزوه فیزیک تشعشع و پزشکی هسته‌ای – دکتر حق‌پرست ص ۳۵

$$A = - \frac{dN}{dt} = \lambda N$$

اکتیویته

A : اکتیویته (تعداد واپاشی در واحد زمان)

N : تعداد هسته‌های رادیونوکلئید موجود

λ : ثابت واپاشی = احتمال واپاشی یک هسته در واحد زمان (واحد: عکس زمان)

منبع: جزوه فیزیک تشعشع و پزشکی هسته‌ای – دکتر حق‌پرست ص ۳۵

واحد اکتیویته	تعریف
بکرل (Bq) – واحد اصلی SI	1 واپاشی در ثانیه (1 dps)
کوری (Ci) – واحد قدیمی	3.7×10^{10} بکرل (واپاشی در ثانیه)

منبع: جزوه فیزیک تشعشع و پزشکی هسته‌ای – دکتر حق‌پرست ص ۳۵

در پزشکی هسته‌ای معمولاً مقادیر تزریقی دارو در حد میلی‌کوری (mCi) بیان می‌شود؛ همچنین مضرب‌های کیلوبکرل (kBq)، مگابکرل (MBq) و گیگابکرل (GBq) نیز رایج‌اند.

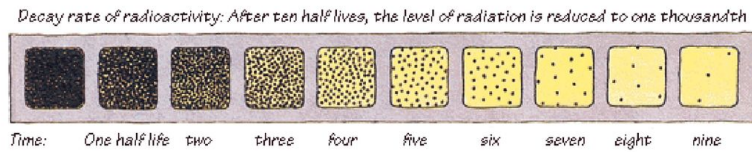
منبع: جزوه فیزیک تشعشع و پزشکی هسته‌ای – دکتر حق‌پرست ص ۳۵

۱۰. انواع نیمه‌عمر

الف) نیمه‌عمر فیزیکی (T_p)

مدت زمانی که طی آن نیمی از هسته‌های رادیواکتیو موجود، بر اثر واپاشی هسته‌ای، استحاله می‌شوند. نمونه‌ها: Ra-226 حدود 1600 سال، Tc-99m حدود 6 ساعت و ... پس از ده نیمه‌عمر، سطح فعالیت تقریباً به یک‌هزارم مقدار اولیه می‌رسد.

منبع: جزوه فیزیک تشعشع و پزشکی هسته‌ای – دکتر حق‌پرست ص ۳۵ و ص ۳۶



شکل - نمودار نیمه‌عمر: با گذشت هر نیمه‌عمر، انرژی/فعالیت پرتوزایی ماده به نصف کاهش می‌یابد.

اسلایدهای M.Ph.P.D - ص ۴۲

ب) نیمه‌عمر بیولوژیکی (Tb)

مدت زمانی که طی آن نیمی از هسته‌های واردشده به بدن، از طریق فرآیندهای دفعی بدن (تنفس، تعریق، ادرار و ...) دفع می‌شوند. این مقدار برای همه رادیوایزوتوپ‌های یک عنصر و ایزوتوپ پایدار آن یکسان است، اما در اندام‌های مختلف بدن متفاوت است. مثال: نیمه‌عمر بیولوژیکی I-131، I-125 و ایزوتوپ پایدار I-127 در تیروئید 140 روز، اما در کلیه و ... متفاوت است.

منبع: جزوه فیزیک تشعشع و پزشکی هسته‌ای - دکتر حق‌پرست ص ۳۷



شکل - مثال نیمه‌عمر بیولوژیکی: I-131 با نیمه‌عمر بیولوژیکی حدود ۷ روز در کلیه و کبد.

اسلایدهای M.Ph.P.D - دکتر حق‌پرست - ص ۴۴

ج) نیمه‌عمر مؤثر (Teff)

از آنجا که در بدن هم‌زمان واپاشی فیزیکی و دفع بیولوژیکی رخ می‌دهد، نیاز به یک شاخص ترکیبی داریم:

منبع: جزوه فیزیک تشعشع و پزشکی هسته‌ای - دکتر حق‌پرست ص ۳۷

$$\frac{1}{T_{\text{eff}}} = \frac{1}{T_p} + \frac{1}{T_b}$$

نیمه‌عمر مؤثر

Teff: نیمه‌عمر مؤثر (ترکیب واپاشی فیزیکی و دفع بیولوژیکی)

Tp: نیمه‌عمر فیزیکی

Tb: نیمه‌عمر بیولوژیکی

منبع: جزوه فیزیک تشعشع و پزشکی هسته‌ای - دکتر حق‌پرست ص ۳۷

(د) عمر متوسط (T یا Average Life)

- نمونه عددی نیمه عمر بیولوژیکی متفاوت در اندامها: ^{131}I در تیروئید حدود 140 روز ولی در کبد و کلیه حدود 7 روز. در عمل، اکتیویته هیچگاه دقیقاً به صفر نمی‌رسد (افت نمایی است).

منبع: منبع: ویدیو - دکتر حق‌پرست، فیزیک پزشکی تشعشع - جلسه ۴ (فایل ۱۶) - ۱۹:۲۳

$$T_{1/2} = \frac{0.693}{\lambda}$$

رابطه نیمه عمر با ثابت واپاشی

$T_{1/2}$: نیمه عمر فیزیکی

λ : ثابت واپاشی

$\ln 2 = 0.693$ - عدد ثابت این رابطه

منبع: منبع: ویدیو - دکتر حق‌پرست، فیزیک پزشکی تشعشع - جلسه ۴ (فایل ۱۶) - ۱۰:۴۳ و ۱۷:۵۱

مدت زمانی فرضی است که طی آن هسته‌ها، اگر با نرخ اکتیویته اولیه (ثابت، نه نمایی) واپاشی می‌کردند، به صفر می‌رسیدند:

منبع: جزوه فیزیک تشعشع و پزشکی هسته‌ای - دکتر حق‌پرست ص ۳۷

$$\bar{T} = \frac{1}{\lambda}$$

عمر متوسط

$\bar{T}$: عمر متوسط

λ : ثابت واپاشی

منبع: جزوه فیزیک تشعشع و پزشکی هسته‌ای - دکتر حق‌پرست ص ۳۷

نکته امتحانی: سه نوع نیمه عمر (فیزیکی، بیولوژیکی، مؤثر) و رابطه معکوس جمع‌شونده‌شان از سوالات پرتکرار امتحانی است؛
رابطه $1/T_{\text{eff}} = 1/T_p + 1/T_b$ را حفظ کنید.

۱۱. رادیوداروها و ژنراتور $^{99}\text{Mo}-^{99m}\text{Tc}$

نقشه استحال (Decay Scheme) نحوه استحال هر هسته رادیواکتیو را نشان می‌دهد. اطلاعات این نقشه دو کاربرد اصلی دارد: (۱) انتخاب ایزوتوپ مناسب برای کاربردهای تشخیصی. (۲) هنگام تجویز رادیودارو به بیمار، برای محاسبه دوز جذبی بیمار استفاده می‌شود.

منبع: جزوه فیزیک تشعشع و پزشکی هسته‌ای - دکتر حق‌پرست ص ۳۸

- نیمه عمر مناسب: نه خیلی طولانی (افزایش دوز جذبی بیمار و تابش به اطرافیان) و نه خیلی کوتاه (از بین رفتن فرصت تصویربرداری).

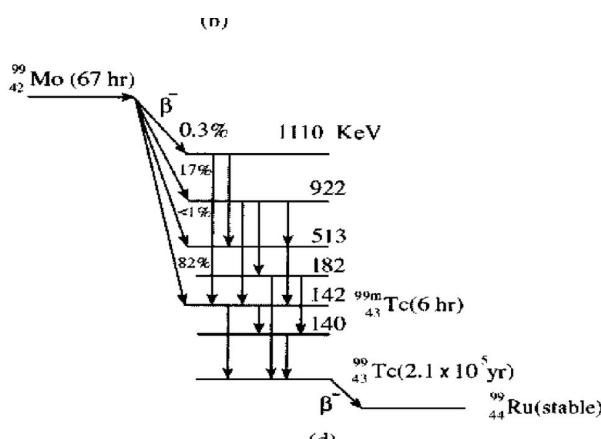
- انرژی مناسب: میزان انرژی گاما (بر حسب keV یا MeV) باید متناسب با کارایی دتکتورهای دستگاه باشد.

- نوع پرتو مناسب: نوع ذره گسیلی (آلفا، بتا یا گاما) باید متناسب با هدف تشخیصی یا درمانی باشد تا دوز اضافی غیرضروری به بیمار تحمیل نشود.

منبع: جزوه فیزیک تشعشع و پزشکی هسته‌ای - دکتر حقیرست ص ۳۸

ژنراتور Mo-99/Tc-99m: زنجیره واپاشی $\text{Ru-99} \rightarrow (2.1 \times 10^5 \text{ yr}) \text{ Tc-99} \rightarrow (6 \text{ hr}) \text{ Tc-99m} \rightarrow (67 \text{ hr}) \text{ Mo-99}$ (پایدار).
فرآیند «دوشیدن» (Milking) با عبور نرمال سالین از ژنراتور تحت خلاء، Tc-99m تولیدشده را استخراج می‌کند. هر ژنراتور معمولاً تا حدود یک هفته (در حدود دو نیمه‌عمر Mo-99) قابل استفاده است.

منبع: جزوه فیزیک تشعشع و پزشکی هسته‌ای - دکتر حقیرست ص ۳۹



شکل - نقشه استحاله ژئوتور: $\text{Ru-99} \rightarrow (2.1 \times 10^5 \text{ yr}) \text{Tc-99} \rightarrow (6 \text{ hr}) \text{Tc-99m} \rightarrow (67 \text{ hr}) \text{Mo-99}$ (پایدار).

اسلایدهای M.Ph.P.D – ص ۴۷

- ^{99m}Tc : نیمه عمر ۶ ساعت و انرژی پرتو گاما 140 keV – همین انرژی پایین باعث می شود دوز بیمار و حفاظت پذیری آن بهتر از ^{131}I باشد.
- پس از چهار نیمه عمر، فعالیت تقریباً به یک شانزدهم می رسد؛ برای ^{99m}Tc این زمان حدود ۲۴ ساعت است ($4 \times 6 \text{ hr} = 24 \text{ hr}$).
- مقدار تزریقی رایج در اسکن های تشخیصی در حد میلی کوری است: اسکن قلب معمولاً ۱۵ تا ۲۰ mCi و اسکن های دیگر حدود ۵ تا ۲۰ mCi.

منبع: منع: ویدیو - دکتر حق پرست، فیزیک پزشکی تشعشع - جلسه ۵ (فایل ۱۵) - ۵:۱۰ تا ۱۳:۴۰

۱۲. اصول تصویربرداری در پزشکی هسته‌ای

تفاوت بنیادین با رادیولوژی: در رادیولوژی منبع پرتو (دستگاه ایکس) خارج از بدن است؛ در پزشکی هسته‌ای، خود بدن بیمار پس از تزریق رادیودارو منبع پرتو محسوب می‌شود. رادیودارو پس از تزریق وریدی در بدن پخش و توسط بافت‌های هدف جذب می‌شود؛ پرتوهای گامای گسیلی توسط گاما‌کامرا (Gamma Camera) یا SPECT آشکارسازی و به سیگنال الکتریکی و سپس تصویر تبدیل می‌شوند.

منبع: جزوه فیزیک تشعشع و پزشکی هسته‌ای - دکتر حقیرست ص ۳۹

- نقاط داغ (Hot Spots): نواحی با متابولیسم بالا (مانند تومورها) رادیوداروی بیشتری جذب کرده و در تصویر به صورت نقاط تیره/داغ نمایان میشوند.

- PET یک روش تصویربرداری پیشرفته است که از رادیودارویی با واپاشی بتای مثبت استفاده می‌کند؛ پوزیترون در بدن با الکترون‌ها ترکیب (فنا) می‌شود و فوتون‌های گاما که از بدن گسیل می‌شوند توسط دستگاه آشکارسازی می‌شوند.
- اندیکاسیون بالینی: بیمار با سابقه سرطان که در تصویربرداری‌های معمول یافته‌ای نداشته و علائم بالینی نامشخص دارد؛ PET با نشان دادن تجمع مواد رادیواکتیو در نقاط پرمتابولیسم به تشخیص کمک می‌کند.

منبع: منبع: ویدیو - دکتر حق‌پرست، فیزیک پزشکی تشعشع - پزشکی هسته‌ای (فایل ۱۴) - ۱۹:۱۰ تا ۵۰:۰۷

اسکن	رادیودارو	کاربرد
اسکن استخوان (Bone Scan)	Tc-99m + MDP	تشخیص متاستاز استخوانی
اسکن کلیه - آناتومیک	Tc-99m	بررسی ساختار آناتومیک کلیه
اسکن کلیه - عملکردی	Tc-99m + DTPA	بررسی عملکرد فیزیولوژیک کلیه
اسکن قلب (Rest/Stress)	Tc-99m + MIBI	گرفتگی عروق کرونر؛ در فاز استرس هنگام اوج فعالیت قلب تزریق می‌شود

منبع: جزوه فیزیک تشعشع و پزشکی هسته‌ای - دکتر حق‌پرست ص ۴۰

- پروتکل دو مرحله‌ای اسکن قلب: تزریق رادیودارو در اوج فعالیت (تست ورزش) و تصویربرداری حدود ۴۵ دقیقه بعد از تزریق؛ سپس مرحله استراحت تکرار می‌شود.
- تفسیر مقایسه‌ای استرس/استراحت: ناحیه‌ای که در استرس نقص جذب دارد ولی در استراحت طبیعی می‌شود، نشانه ایسکمی و گرفتگی عروق است.
- آناتومی کلیه با Tc-99m و عملکرد کلیه با Tc-99m-DTPA بررسی می‌شود؛ این تفکیک آناتومی/فیزیولوژی نکته کلیدی این بخش است.

منبع: منبع: ویدیو - دکتر حق‌پرست، فیزیک پزشکی تشعشع - جلسه ۵ (فایل ۱۵) - ۲۲:۵۵ تا ۲۴:۵۰

- پیش از اسکن قلب، به بیمار غذای چرب داده می‌شود تا کیسه صفرا و کبد تخلیه شده و تصویر قلب با کیفیت بهتری دیده شود؛ نقص در جذب رادیودارو نشان‌دهنده گرفتگی عروق کرونر است.

منبع: جزوه فیزیک تشعشع و پزشکی هسته‌ای - دکتر حق‌پرست ص ۴۰

تصویربرداری PET: اساس کار، استفاده از رادیوداروهایی با واپاشی بتای مثبت است؛ رایج‌ترین آن‌ها FDG (فلور-18 متصل به گلوکز) است. پس از انتشار، پوزیترون با یک الکترون بدن برخورد کرده و «پدیده فنا» (Annihilation) رخ می‌دهد که به تولید دو فوتون گامای 511 keV (0.511 MeV) در دو جهت مخالف منجر می‌شود؛ این فوتون‌ها توسط دستگاه آشکارسازی شده و تصویر را می‌سازند.

منبع: جزوه فیزیک تشعشع و پزشکی هسته‌ای - دکتر حق‌پرست ص ۴۱ و ص ۴۲

نکته کلیدی: مزیت کلیدی PET: برخلاف CT و MRI که آناتومی را نشان می‌دهند، PET متابولیسم و سوخت‌وساز سلولی را ارزیابی می‌کند؛ چون سلول‌های سرطانی متابولیسم بسیار بالایی دارند، رادیوداروی بیشتری جذب کرده و به صورت نقطه داغ دیده می‌شوند - این ویژگی امکان تشخیص زودهنگام متاستازها را فراهم می‌کند.

۱۳. ایمنی پرتو در پزشکی هسته‌ای

نکات حفاظتی	نیمه‌عمر	رادیودارو
نکات حفاظتی (دوری از کودکان و خانم‌های باردار) تا 24 ساعت	6 ساعت	Tc-99m
دوری از کودکان و خانم‌های باردار؛ پرهیز از بارداری تا 6 ماه پس از درمان	8 روز	I-131

منبع: جزوه فیزیک تشعشع و پزشکی هسته‌ای – دکتر حق‌پرست ص ۴۳

• I-131 برای درمان سرطان یا پرکاری تیروئید استفاده می‌شود.

• به دلیل دفع ماده رادیواکتیو از طریق عرق، بزاق و ادرار، مصرف آب فراوان، هنگام استفاده از سرویس بهداشتی و شست‌وشوی مجزای لباس‌ها تأکید می‌شود.

منبع: جزوه فیزیک تشعشع و پزشکی هسته‌ای – دکتر حق‌پرست ص ۴۳

• درمان با I-131 به صورت خوراکی و بر حسب میلی‌کوری تجویز می‌شود؛ در منبع: بیماران زیر حدود ۳۰ میلی‌کوری سرپایی و بالای آن با بستری درمان می‌شوند.

• با توجه به نیمه‌عمر ۸ روزه، مراقبت‌ها و قرنطینه‌ی خانگی حدوداً تا یک تا دو هفته ادامه دارد.

• نکات حفاظتی خانگی که در ویدیو تأکید شد: مادر شیرده باید شیردهی را کاملاً قطع کند؛ لباس‌ها و ملافه‌های آلوده به عرق جدا شسته شوند؛ ظرف غذا و وسایل شخصی جدا باشد (دفع از طریق بزاق)؛ هنگام استفاده از سرویس بهداشتی آب فراوان ریخته شود (دفع از طریق ادرار)؛ و از تماس نزدیک با کودکان و خانم‌های باردار پرهیز شود.

• برای Tc-99m با نیمه‌عمر ۶ ساعت، رعایت فاصله و نکات حفاظتی در حدود ۲۴ ساعت کافی است.

منبع: منبع: ویدیو – دکتر حق‌پرست، فیزیک پزشکی تشعشع – جلسه ۶ (فایل ۱۴) – ۵۵:۵۵ تا ۸:۳۶

۱۴. رادیوتراپی و طرح‌ریزی درمان

رادیوتراپی، استفاده از پرتوهای یونیزان برای جلوگیری از رشد و تقسیم سلول‌های سرطانی و از بین بردن آن‌هاست. رادیوتراپی به دو شیوه اصلی انجام می‌شود.

منبع: جزوه فیزیک تشعشع و پزشکی هسته‌ای – دکتر حق‌پرست ص ۴۳

• در رادیوتراپی خارجی، دستگاه‌های شتاب‌دهنده با انرژی‌های 6 MV و 18 MV به کار می‌روند و دوز بالا به تومور داده می‌شود.

• اصل فراکشن‌بندی (از ویدیو): دوز کل در چند جلسه تقسیم می‌شود تا بافت سالم اطراف فرصت ترمیم داشته باشد – مثال منبع: ۶۰ گری در ۳۰ جلسه و در هر جلسه ۲ گری.

منبع: منبع: ویدیو – دکتر درویش، رادیوبیولوژی ۳ (فایل ۵۵) – ۲۸:۲۰ تا ۲۹:۰۶

• نکته بالینی ترخیص بیمار: بیمار پس از تزریق رادیودارو، پیش از ترخیص باید تا حد امکان ماده را دفع کرده باشد، چون با ترخیص او اطرافیان نیز در معرض تابش قرار می‌گیرند (نکته عملی مطرح شده در ویدیو).

• برای انتخاب یک رادیوداروی تشخیصی سه معیار باید هم‌زمان رعایت شود: نیمه‌عمر مناسب، انرژی مناسب و نوع پرتو مناسب.

• نقشه استحاله، هم نحوه واپاشی هسته رادیواکتیو و هم امکان انتخاب ایزوتوپ مناسب برای تشخیص و درمان را نشان می‌دهد.

- رادیوتراپی خارجی (External / تله‌تراپی): منبع پرتو (معمولاً شتاب‌دهنده خطی) در فاصله‌ای دور از بدن، مثلاً 100 سانتی‌متر قرار می‌گیرد. از پرتوهای ایکس برای تومورهای عمقی و از الکترون برای تومورهای سطحی (مانند پوست) استفاده می‌شود.
- رادیوتراپی داخلی (Internal / براکی‌تراپی): سورس رادیواکتیو (مانند Cs-137، I-125 یا Ir-192) مستقیماً داخل یا در مجاورت بافت تومور قرار می‌گیرد.

منبع: جزوه فیزیک تشعشع و پزشکی هسته‌ای - دکتر حق‌پرست ص ۴۳

- ابتدا از بیمار سی‌تی‌اسکن گرفته و تصاویر به نرم‌افزار طراحی درمان منتقل می‌شود.
- سپس پارامترهایی مانند تعداد فیلدها (میدان‌های تابش)، اندازه فیلد، نوع و انرژی پرتو (مثلاً 6 یا 18 مگاولت) و زاویه گانتری تعیین می‌گردد.
- شیلدینگ (حفاظت بافت سالم): با آلایژ سروبند (Cerrobend - ترکیب قلع، سرب و بیسموت) یا تیغه‌های سربی متحرک به نام MLC انجام می‌شود.
- دوزیمتری و DVH: نمودار Dose-Volume Histogram نشان می‌دهد چه درصدی از حجم تومور یا بافت حیاتی چه میزان دوز (بر حسب گری) دریافت کرده است.
- درمان معمولاً به صورت فراکشن‌بندی شده (تقسیم دوز کل در چندین جلسه) انجام می‌شود.

منبع: جزوه فیزیک تشعشع و پزشکی هسته‌ای - دکتر حق‌پرست ص ۴۴

نکته امتحانی: نکات مرور امتحانی منبع: رابطه فنا با دو فوتون 511 keV (نه 140 keV که مخصوص Tc-99m است)؛ شرط عددی هر واپاشی ($Z > 83$ برای آلفا و آستانه 1.022 MeV برای بتای مثبت)؛ تفاوت طیف تک‌انرژی آلفا با طیف پیوسته بتا و علت آن (سهم نوترینو/آنتی‌نوترینو)؛ و پدیده‌های ثانویه گیراندازی الکترون (گاما، اشعه ایکس اختصاصی، الکترون اوژه).

- مواد رادیواکتیو: طبیعی (ناپایداری ذاتی) یا مصنوعی (ناپیدار شده در آزمایشگاه/راکتور/شتاب‌دهنده).
- هسته مادر → (استحاله) → هسته دختر؛ استحاله اغلب با آلفا، بتا و گاما.
- آلفا: $2p + 2n$ ، بار +2، طیف تک‌انرژی، برد کوتاه، خطر اصلی پرتوگیری داخلی؛ شرط: $Z > 83$.
- بتای منفی: N/P بالا؛ A ثابت و $Z + 1$ ؛ طیف پیوسته به دلیل تقسیم آماری انرژی با آنتی‌نوترینو؛ مثال $C-14 \rightarrow N-14$ (5730 yr)، 0.156 MeV .
- بتای مثبت: N/P پایین + اختلاف انرژی بیش از 1.022 MeV ؛ مثال $Cu-64 \rightarrow Ni-64$ (12.71 hr).
- گیراندازی الکترون: فقط یک شرط (N/P پایین)؛ مثال $K-40 \rightarrow Ar-40$ ؛ پدیده‌های ثانویه: گاما، ایکس اختصاصی، الکترون اوزه.
- گاما: A و Z بدون تغییر؛ تبدیل داخلی = انتقال انرژی به الکترون مداری همان اتم.
- اکتیویته: $A = \lambda N$ ؛ 1 dps Bq و $3.7 \times 10^{10} \text{ Bq}$ Ci.
- نیمه‌عمرها: فیزیکی T_p ، بیولوژیکی T_b ، مؤثر $1/T_{\text{eff}} = 1/T_p + 1/T_b$ ، عمر متوسط $T = 1/\lambda$.
- ژنراتور: $Ru-99 \rightarrow Tc-99 \rightarrow (6 \text{ hr}) Tc-99m \rightarrow (67 \text{ hr}) Mo-99$ ؛ دوشیدن با سالین.
- PET: FDG (فلور-18)؛ فنا → دو فوتون 511 keV ؛ ارزیابی متابولیسم.
- رادیوتراپی: خارجی (شتاب‌دهنده، 100 cm ؛ ایکس برای عمقی و الکترون برای سطحی) و داخلی/براکی‌تراپی ($I-125$ ، $Cs-137$ ، $Ir-192$)؛ سروبند، MLC، DVH، فراکشن‌بندی.



فصل ۵

واحدهای سنجش پرتو و دزیمتری

دکتر حق پرست

صفحه‌های ۵۶ تا ۵۹

۳

جدول

۰

شکل

۲۵

بخش

۱. چهار خانواده واحد در سنجش پرتو

واحدهای سنجش پرتو در چهار خانواده دسته‌بندی می‌شوند: واحدهای پرتودهی، واحدهای دوز جذبی، واحدهای دوز معادل و واحدهای رادیواکتیویته (اکتیویته).

منبع: جزوه دکتر افضل‌پور (واحدهای سنجش پرتو) ص ۶۹

خانواده واحد	واحدها
واحدهای پرتودهی	رونتگن (R) و اکسپوژر (X)
واحدهای دوز جذبی	راد (Rad) و گری (Gy)
واحدهای دوز معادل	رم (Rem) و سیورت (Sv)
واحدهای رادیواکتیویته	کوری (Ci) و بکرل (Bq)

منبع: جزوه دکتر افضل‌پور (واحدهای سنجش پرتو) ص ۶۹

۲. پرتودهی (اکسپوژر)

رونتگن: یک رونتگن عبارت است از مقدار اشعه X یا γ که در هر سانتی‌متر مکعب هوا (صفر درجه سانتی‌گراد و 760 میلی‌متر جیوه) یک واحد الکترواستاتیک بار الکتریکی (1 esu) از هر دو علامت مثبت و منفی ایجاد کند.

منبع: جزوه دکتر افضل‌پور (واحدهای سنجش پرتو) ص ۷۰

$$1 R = 2.58 \times 10^{-4} \frac{C}{kg \text{ air}}$$

یکای رونتگن

$1 R = 1 \text{ esu/cm}^3 \text{ air}$ (در شرایط متعارفی)

$1 R = 2.58 \times 10^{-4}$ کولن بر کیلوگرم هوا

منبع: جزوه دکتر افضل‌پور (واحدهای سنجش پرتو) ص ۷۰

اکسپوژر (Exposure): مقدار تابش اشعه X یا γ که بتواند در هر کیلوگرم هوا یون‌های حامل یک کولن بار (با هر علامتی) ایجاد کند؛ خصوصیتی از پرتو که همان توانایی یونیزه‌نمودن هوا می‌باشد.

منبع: جزوه دکتر افضل‌پور (واحدهای سنجش پرتو) ص ۷۱

نکته کلیدی: پرتودهی (اکسپوژر و رونتگن) «توانایی یونیزه‌کردن هوا» را می‌سنجد؛ بنابراین یک کمیت مربوط به پرتو در هوا است، نه دوز جذب‌شده در بافت.

۳. دوز جذبی

واحد دوز جذبی (Absorbed Dose): انرژی جذب شده از پرتو در ماده مورد تابش.

منبع: جزوه دکتر افضل‌پور (واحدهای سنجش پرتو) ص ۷۲

$$1 \text{ Gy} = 1 \frac{\text{J}}{\text{kg}}$$

گری (Gray)

یک گری عبارت است از دوز تابشی جذب شده یک ژول بر کیلوگرم
گری را می‌توان در مورد پرتوهای ایکس، نوترون‌ها، ذرات باردار و نیز ایزوتوپ‌های پرتوزایی که در درون بدن جای‌گیر شده‌اند استفاده کرد

منبع: جزوه دکتر افضل‌پور (واحدهای سنجش پرتو) ص ۷۲

$$1 \text{ Gy} = 100 \text{ rad} ; 1 \text{ rad} = 100 \frac{\text{erg}}{\text{g}}$$

راد (rad)

راد: تابش جذب شده متناسب با انرژی ۱۰۰ ارگ بر گرم

$$1 \text{ Gy} = 100 \text{ rad}$$

منبع: جزوه دکتر افضل‌پور (واحدهای سنجش پرتو) ص ۷۲

۴. دوز معادل و ضریب کیفی

هرگاه در پرتوگیری بیش از یک نوع تشعشع دخالت داشته باشد، در آن صورت دوز معادل هر یک از پرتوها می‌بایست به‌طور جداگانه محاسبه گردد.

منبع: جزوه دکتر افضل‌پور (واحدهای سنجش پرتو) ص ۷۳

$$\text{DE (rem)} = D (\text{rad}) \times \text{QF}$$

دوز معادل (Dose Equivalent)

DE: دوز معادل (بر حسب rem)

D: دوز جذبی (بر حسب rad)

QF: ضریب کیفی (Quality Factor) – ضریب وزنی نوع پرتو

منبع: جزوه دکتر افضل‌پور (واحدهای سنجش پرتو) ص ۷۳

- ضریب کیفی از زبان استاد: برای پرتوهای ایکس، گاما و بتا ۱؛ برای نوترون و پروتون (تا حدود ۱۰ MeV) برابر ۱۰؛ برای ذرات سنگین‌تر (هسته‌های سنگین) تا حدود ۲۰ تعریف می‌شود – چون شدت یونیزاسیون آن‌ها به‌مراتب بیشتر است.
- در هر پرتوگیری که چند نوع پرتو دخیل باشد، برای هر پرتو جداگانه دوز معادل حساب می‌شود و سپس با هم جمع می‌گردد.

منبع: منبع: ویدیو – دکتر افضل‌پور، فیزیک پزشکی – جلسه ۳ (فایل ۱۸) – ۱۹:۴۳ تا ۲۱:۰۳

نوع پرتو	ضریب کیفی (QF)
اشعه ایکس (X)	1
گاما (γ)	1
بتا (β)	1
نوترون و پروتون (تا 10 MeV)	10

منبع: جزوه دکتر افصلی پور (واحدهای سنجش پرتو) ص ۷۳

نکته کلیدی: دوز معادل = دوز جذبی × ضریب کیفی؛ چون QF برای ایکس و گاما و بتا برابر 1 است، برای این پرتوها مقدار عددی دوز جذبی و دوز معادل یکسان می شود (تنها یکای آن ها تفاوت دارد).

۵. یکاهای حفاظتی و رابطه ها

کمیت	یکای بین المللی (SI)	یکای قدیمی	رابطه
اکتیویته	بکرل (Bq)	کوری (Ci)	$1 \text{ Ci} = 3.7 \times 10^{10} \text{ Bq}$
دوز جذبی	گری (Gy)	راد (rad)	$1 \text{ Gy} = 100 \text{ rad}$
دوز معادل	سیورت (Sv)	رم (rem)	$1 \text{ Sv} = 100 \text{ rem}$
پرتودهی	کولن بر کیلوگرم (C/kg)	روننگن (R)	$1 \text{ R} = 2.58 \times 10^{-4} \text{ C/kg}$

منبع: جزوه دکتر افصلی پور (واحدهای سنجش پرتو) ص ۶۹ تا ص ۷۳؛ جزوه فیزیک تشعشع و پزشکی هسته ای – دکتر حق پرست ص ۳۵

- تعریف روننگن در ویدیو: مقدار پرتوایکس یا گاما که در ۱ سانتی متر مکعب هوا در شرایط صفر درجه سانتی گراد و فشار ۷۶۰ میلی متر جیوه، یک واحد الکترواستاتیک بار (1 esu) با هر دو علامت مثبت و منفی تولید کند.
- هر دو یکای روننگن و اکسیپوژر، «توانایی یونیزه کردن هوا» را می سنجند؛ به همین دلیل واحد آن ها به جرم هوا (C/kg air) نوشته می شود، نه به بافت.

منبع: منبع: ویدیو – دکتر افصلی پور، فیزیک پزشکی – جلسه ۳ (فایل ۱۸) – ۱۸:۰۷ تا ۱۹:۰۱

در منبع فیزیک تشعشع نیز واحدهای دوز معرفی شده اند: دوز جذبی بر حسب گری (Gy) برابر 1 J/kg ، و دوز معادل بر حسب سیورت (Sv) که از ضرب دوز جذبی در ضریب وزن دهی پرتو (WR) به دست می آید؛ رابطه $1 \text{ Gy} = 1 \text{ J/kg}$ مبنای این خانواده از واحدهاست.

منبع: جزوه فیزیک تشعشع و پزشکی هسته ای – دکتر حق پرست ص ۳۸؛ اسلایدهای M.Ph.D – دکتر حق پرست اسلایدهای دوزیمتری

۶. کاربرد واحدها در عمل

- برای پرتوهای ایکس و گاما (که $QF = 1$ دارند) گزارش «دوز» به صورت گری یا سیورت، مقدار عددی یکسانی دارد؛ اما در پرتوهای با QF بالاتر (مانند نوترون ها) دوز معادل به مراتب بزرگ تر از دوز جذبی است.

- در رادیوتراپی، دوز تجویزی هدف بر حسب گری (Gy) بیان می‌شود و DVH نشان می‌دهد چه درصدی از حجم اندام چه دوزی دریافت کرده است.
- در پزشکی هسته‌ای، اکتیویته رادیودارو بر حسب mCi یا MBq تجویز می‌شود و دوز جذبی اندام‌ها بر پایه نقشه استحال و رفتار بیولوژیکی رادیودارو محاسبه می‌گردد.

منبع: جزوه دکتر افصلی‌پور (واحدهای سنجش پرتو) ص ۷۲ و ص ۷۳؛ جزوه فیزیک تشعشع و پزشکی هسته‌ای – دکتر حق‌پرست ص ۳۸ و ص ۴۴

مرور سریع

- پرتودهی: رونتگن و اکسپوژ – توانایی یونیزه کردن هوا؛ $1 \text{ R} = 2.58 \times 10^{-4} \text{ C/kg air}$.
- دوز جذبی: راد و گری؛ $1 \text{ Gy} = 1 \text{ J/kg}$ و $1 \text{ Gy} = 100 \text{ rad}$ ؛ $1 \text{ rad} = 100 \text{ erg/g}$.
- دوز معادل: رم و سیورت؛ $DE = D \times QF$ ؛ QF ایکس و گاما و بتا 1، نوترون و پروتون تا 10 MeV برابر 10.
- اکتیویته: بکرل و کوری؛ $1 \text{ Ci} = 3.7 \times 10^{10} \text{ Bq}$.
- اگر بیش از یک نوع پرتو دخیل باشد، دوز معادل هر پرتو جداگانه محاسبه و سپس جمع می‌شود.



فصل ۶

حفاظت در برابر پرتو

دکتر حق پرست

صفحه‌های ۶۱ تا ۷۴

۳

جدول

۱۵

شکل

۵۵

بخش

۱. چرا حفاظت پرتوی؟ و هدف آن

حفاظت در برابر تشعشع (RP) ابزاری برای مدیریت اقدامات حفاظت از سلامت در برابر خطرات (برای افراد و محیط زیست) ناشی از استفاده از پرتوهای یونیزان است. همیشه باید مزایا در مقابل خطرات در نظر گرفته شود.

منبع: اسلایدهای رادیوبیولوژی دکتر درویش ص ۱۲

- اثرات غیراحتمالی (قطعی): هدف حفاظت پرتوی، پیش‌گیری از آنهاست.
- اثرات احتمالی (تصادفی): هدف حفاظت پرتوی، کاهش آنهاست.

منبع: اسلایدهای رادیوبیولوژی دکتر درویش ص ۱۳

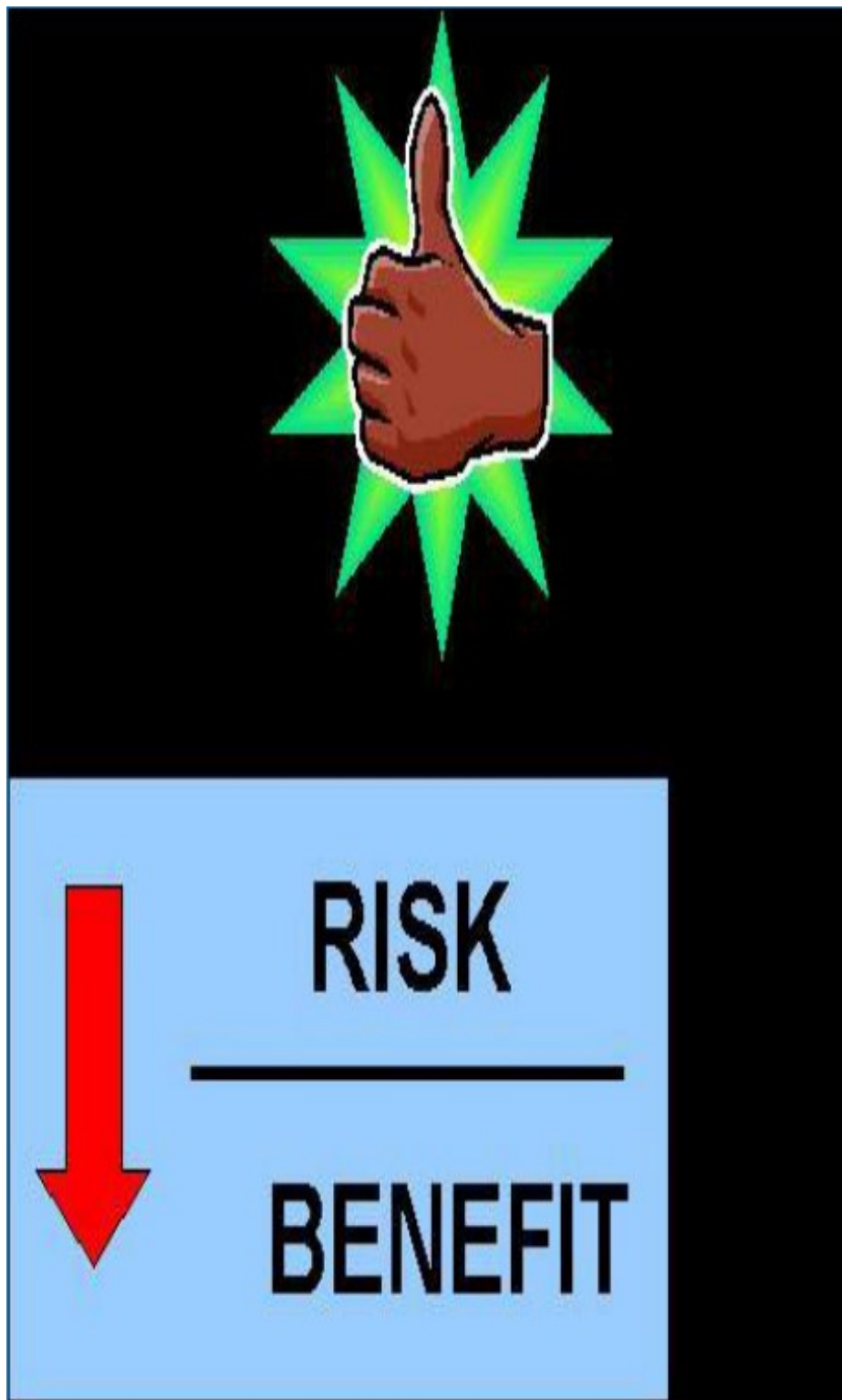
- ICRP: توصیه‌ها و پیشنهادهایی را ارائه می‌کند.
- IAEA: استانداردهای ایمنی را ایجاد می‌کند و اجرای استانداردها را فراهم می‌کند.
- UNSCEAR: اثرات تشعشعات اتمی را مطالعه می‌کند.

منبع: اسلایدهای رادیوبیولوژی دکتر درویش ص ۷۷

۲. سیستم حفاظت در برابر اشعه (سه اصل)

اصل	معنا
توجیه‌پذیری اقدام (Justification)	هرگونه قرار گرفتن در معرض پرتو باید فواید و سود کافی برای جبران آسیب پرتوی که ممکن است ایجاد کند داشته باشد؛ بنابراین اگر قرار گرفتن در معرض پرتو هیچ منفعتی نداشته باشد، موجه نیست.
بهینه‌سازی حفاظت (Optimization)	دوزها باید «تا حد امکان کم باشد» با در نظر گرفتن عوامل اقتصادی و اجتماعی – این همان اصل ALARA است؛ تا حدی که می‌کنیم که منطقی (کیفیت تصویر تخریب نشود) و در دسترس باشد.
محدودیت دوز (Limitation of doses)	حد دوز برای پرتوکار 50 mSv در سال؛ حد دوز برای افراد دیگر (حد دوز عمومی) 1 mSv در سال؛ حد دوز نباید برای مواجهه‌های پزشکی (بیماران) ناشی از اقدامات مجاز اعمال شود.

منبع: اسلایدهای رادیوبیولوژی دکتر درویش ص ۷۸ تا ص ۸۲



شکل - توازن خطر و فایده: اصل توجیه‌پذیری یعنی فایده تشخیصی هر پرتونگاری باید بیش از خطر آن باشد.

اسلایدهای رادیوبیولوژی - دکتر درویش - ص ۷۹

ALARA به معنای هر نوع تلاش معقول برای کاهش تابش‌گیری، کمتر از حد دز عملی و منطبق بر مقاصد مورد نظر می‌باشد.

منبع: جزوه دکتر افضلی‌پور ص ۷۵

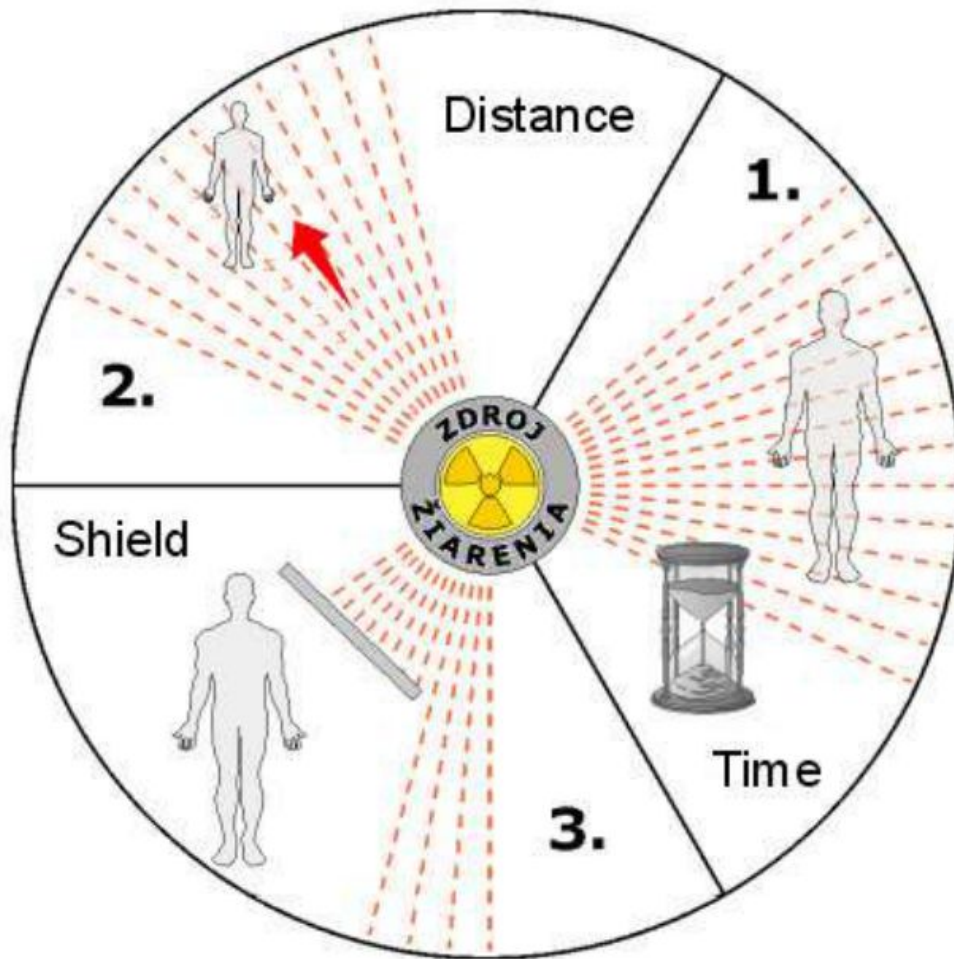
۳. سه اصل عملی کاهش پرتونگاری

- کاهش زمان در معرض قرارگیری پرتو.

• افزایش فاصله از منبع پرتوزا.

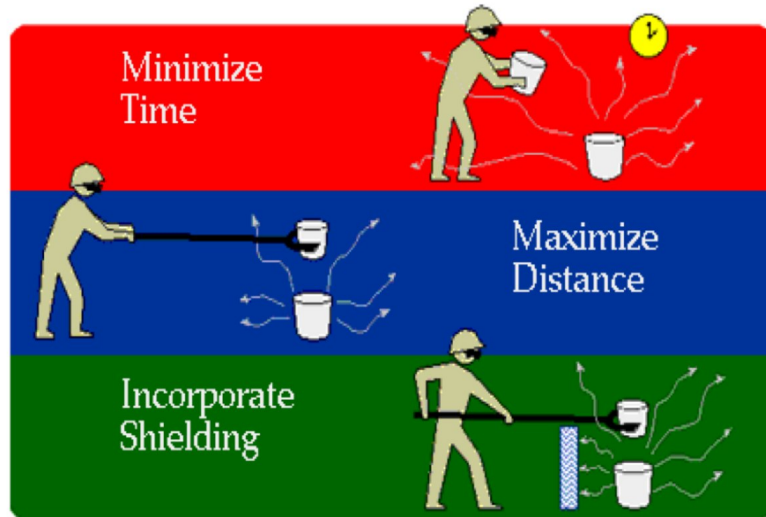
• استفاده از حفاظ پرتوی مانند سرب، بتون، آلومینیوم و ...

منبع: اسلایدهای رادیوبیولوژی دکتر درویش ص ۸۱؛ جزوه دکتر افضل‌پور ص ۸۹



شکل – سه اصل کاهش پرتوگیری خارجی: کاهش زمان، افزایش فاصله و استفاده از حفاظ (Time / Distance / Shielding).

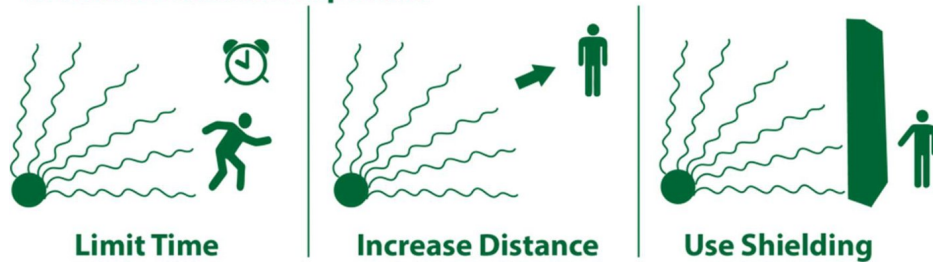
اسلایدهای دکتر افضل‌پور – ص ۸۹



شکل - سه اصل کاهش پرتوگیری: کمینه کردن زمان در برابر پرتو، بیشینه کردن فاصله از چشمه و استفاده از حفاظ سربی (Time / Distance / Shielding).

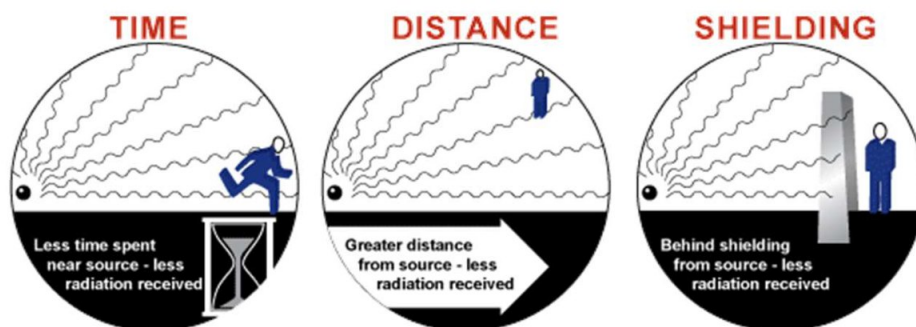
اسلایدهای رادیوبیولوژی - دکتر درویش - ص ۸۱

To reduce radiation exposure:



شکل - سه راهکار کاهش پرتوگیری خارجی: محدود کردن زمان، افزایش فاصله و استفاده از حفاظ.

اسلایدهای دکتر افصلی پور - ص ۹۰



شکل - سه اصل زمان، فاصله و حفاظت با منحنی کاهش دوز: هرچه زمان کمتر و فاصله بیشتر باشد، دوز دریافتی کمتر است.

اسلایدهای دکتر افصلی پور - ص ۹۲

- زمان: پرتوکار باید تا حد امکان مدت زمان صرف شده در محیط تشعشع را کاهش دهد؛ زمان و تابش گیری از تشعشع با یکدیگر رابطه مستقیم دارند - اگر زمان صرف شده در محیط دو برابر شود، پرتوگیری از اشعه نیز دو برابر خواهد شد.
- فاصله: دوز دریافتی با افزایش فاصله کاهش می یابد (دوز با عکس مجذور فاصله کم می شود).

- حفاظ: با افزایش ضخامت حفاظ (مانند دیوار بتونی)، آهنگ دوز کاهش می‌یابد.

منبع: جزوه دکتر افصلی‌پور ص ۹۰ و ص ۹۱

- چشمه نقطه‌ای و منابع گسترده: منبع اولیه تشعشع – دستگاه اشعه ایکس یا رادیونوکلیئید – «چشمه نقطه‌ای» است و پرتوگیری از آن با فاصله به سرعت کم می‌شود؛ در مقابل، منابع گسترده (مانند بیمار و هر جسمی که در محل کار وجود دارد) پرتو را پراکنده می‌کنند و پرتوگیری پراکنده در فاصله‌های دورتر کاهش کمتری دارد.
- نکته عملی همین صفحه: سیم دستگاه کنترل کوتاه انتخاب می‌شود تا پرتوکار پشت دستگاه (و دور از چشمه) قرار گیرد.

منبع: جزوه دکتر افصلی‌پور ص ۹۵

- مثال عددی استاد برای فاصله: شدت 100 mrad (یک میلی‌گری) در فاصله «یک اینچ» (۲.۵ سانتی‌متر) به حدود 25 mrad در فاصله «دو اینچ» (۵ سانتی‌متر) می‌رسد؛ یعنی با دو برابر شدن فاصله، دوز یک‌چهارم می‌شود.
- برای حفاظ: هرچه ضخامت سرب بیشتر باشد، معادل سربی (PBLE) بیشتر و آهنگ دوز کمتر می‌شود؛ روپوش‌های موجود می‌توانند معادل ۰.۲۵ میلی‌متر، ۰.۳۵ میلی‌متر و حتی ۱ میلی‌متر سرب باشند.
- اندازه میدان: بزرگ‌کردن میدان 11×11 به ۱۷×۱۷ سانتی‌متر، دوز پرتوی پراکنده را حدود ۶۰ درصد بالا می‌برد – بنابراین کولیماسیون فقط برای کیفیت تصویر نیست، برای حفاظت هم حیاتی است.
- در آنژیوگرافی، دوز در سمت تیوب (۴ تا ۸ mSv/h) بسیار بیشتر از سمت آشکارساز است؛ پرسنل باید سمت آشکارساز بایستند و در بیشترین فاصله منطقی از بیمار قرار بگیرند.

منبع: منبع: ویدیو – دکتر افصلی‌پور، فیزیک پزشکی – جلسه ۴ (فایل ۱۹) – ۱۹:۱۰ تا ۲۳:۳۳

۴. کنترل تابش‌گیری

- تابش‌گیری شغلی به هر گونه تابش‌گیری افراد در منطقه محدودشده در حین کار و انجام وظیفه اطلاق می‌شود.
- کنترل تابش‌گیری شغلی یک کار ساده است، اما باید به نکات آن توجه داشت.
- افرادی که در یک بخش رادیولوژی کار می‌کنند همیشه باید از موقعیت خود نسبت به شعاع اشعه ایکس اولیه و مدت زمانی که در اطراف اشعه سپری می‌کنند آگاه باشند.
- پرتوکاران در بخش‌های رادیولوژی علاوه بر مفاهیم فاصله، زمان و حفاظ باید با مفهوم ALARA نیز آشنا باشند.

منبع: جزوه دکتر افصلی‌پور ص ۷۴ و ص ۷۵

۵. تابش‌گیری بیمار

- بیشتر ایالت‌ها محدودیتی برای تابش‌گیری بیمار در حین انجام روش پرتونگاری تشخیصی قائل نیستند، اما پرتوکار باید از شرایط تکنیکی مناسب برای کمترین حد تابش‌گیری بیمار و رعایت ALARA آگاهی داشته باشد.
- انتخاب شرایط صحیح، از تعداد پرتونگاری‌های تکراری ناشی از تابش کم یا زیاد اشعه می‌کاهد.
- شرایط صحیح را می‌توان با استفاده از نمودارهای موجود در دستورالعمل‌ها یا انتخاب درست ولتاژ لامپ (kVp) و mA و زمان‌سنج انتخاب کرد.
- یک دستورالعمل، نمودار شرایط تکنیکی را برای هر روش و هر دستگاه اشعه ایکس مشخص می‌کند؛ این نمودار باید اندازه آناتومیکی بیمار، عوامل تکنیکی مورد استفاده، نوع و اندازه فیلم یا ترکیب فیلم/صفحه، فاصله کانون تا فیلم (SID) و نوع و محل حفاظ گونادی را نشان دهد.

- کسب تجربه و توجه دقیق به اندازه آناتومیکی بیمار، بهترین روش برای انتخاب شرایط است.

منبع: جزوه دکتر افضل‌پور ص ۷۶ و ص ۷۷ و ص ۷۸

۶. روپوش‌های محافظ، دستکش و حفاظ گنادها

پرسشی که اغلب مطرح می‌شود، لزوم و زمان استفاده از روپوش‌های محافظ و دستکش با حفاظ گونادال در حین تصویربرداری است. جز بیماران، فقط کارکنان و افرادی که حضورشان برای انجام روش پزشکی لازم است یا کارآموزان می‌توانند حین تابش اشعه و انجام پرتونگاری در داخل اتاق بمانند، مشروط بر آن که:

منبع: جزوه دکتر افضل‌پور ص ۸۱



شکل – روپوش محافظ، دستکش و حفاظ گناد: تجهیزات حفاظت فردی هنگام تصویربرداری.

اسلایدهای دکتر افضل‌پور – ص ۸۱

- وضعیت همه افراد حاضر طوری باشد که هیچ قسمتی از بدن آنان تحت تابش اشعه مفید واقع نشود؛ در غیر این صورت حفاظت با روپوش لازم است.
- کارکنان و پرتوکاران باید از تشعشع پراکنده مستقیم با روپوش‌های محافظ یا موانع محافظ کل بدن با حداقل ضخامت 0.25 mm معادل سرب حفاظت شوند.
- بیمارانی که نمی‌توانند از اتاق خارج شوند باید از تشعشع پراکنده مستقیم با حفاظ معادل 0.25 mm سرب حفاظت شوند و طوری قرار داده شوند که حداقل 2 m از لامپ اشعه ایکس و گیرنده تصویر فاصله داشته باشند.
- به منظور حفاظت از گنادها، استفاده از حفاظی با حداقل ضخامت 0.5 mm سرب توصیه می‌شود.

منبع: جزوه دکتر افضل‌پور ص ۸۱ تا ص ۸۳



شکل - روپوش و دستکش سربی: کارکنان و بیماران که باید در اتاق بمانند، با حداقل 0.25 mm معادل سرب حفاظت می‌شوند.

اسلایدهای دکتر افصلی‌پور - ص ۱۰۴



شکل - تجهیزات حفاظتی پرتوکار: روپوش سربی، دستکش و عینک حفاظتی.

جزوه دکتر افضلی پور - ص ۸۹، ۹۳، ۹۹، ۱۰۹، ۱۲۲ (ص ۱۲۲)



شکل - حفاظ تیروئید: کاهش دوز غده تیروئید در پرتونگاری‌های ناحیه گردن.

جزوه دکتر افضلی پور - ص ۸۹، ۹۳، ۹۹، ۱۰۹، ۱۲۲ (ص ۱۰۹)

- روپوش سربی استاندارد معادل ۰.۲۵ میلی‌متر سرب است (و در برخی بخش‌ها ۰.۳۵ میلی‌متر یا ۰.۵ میلی‌متر)؛ جنس آن $PBLE = \text{Protective Lead or Lead Equivalent}$ نامیده می‌شود.
- روپوش سربی حدود ۷۵ تا ۸۰ درصد مغز استخوان فعال بدن را می‌پوشاند؛ بقیه مغز استخوان فعال در جمجمه، بازوها و دنده‌ها بیرون از روپوش است.
- حفاظ تیروئید می‌تواند دوز تیروئید را تا حدود ۱۰ برابر کم کند (تا ۹۰٪).

- عینک سربی (Lead Glasses) دوز چشم را تا حدود ۹۸ درصد کاهش می‌دهد؛ در بخش آنژیوگرافی و فلوروسکوپی که پرسنل نزدیک میدان کار می‌کنند از این عینک‌ها و حفاظ‌های سیار استفاده می‌شود.

- روپوش‌ها باید مرتب بازرسی شوند: نباید ترک، پارگی یا شکستگی داشته باشند؛ نگهداری و حمل بی‌دقت، حفاظ را بی‌اثر می‌کند.

منبع: ویدیو - دکتر افصلی‌پور، فیزیک پزشکی - جلسه ۴ (فایل ۱۹) - ۰۹:۲۳ تا ۲۶:۲۵

- موارد استثنا: قرار گرفتن گنادها در میدان تشخیصی؛ مداخله حفاظ در روش تشخیص.

منبع: جزوه دکتر افصلی‌پور ص ۸۳



شکل - پرتوکار با روپوش سربی در اتاق فلوروسکوپی: روپوش‌ها بخش عمده بدن را از پرتو پراکنده حفاظت می‌کنند.

اسلایدهای دکتر افصلی‌پور - ص ۱۰۵

۷. نگهداشتن بیمار با فیلم

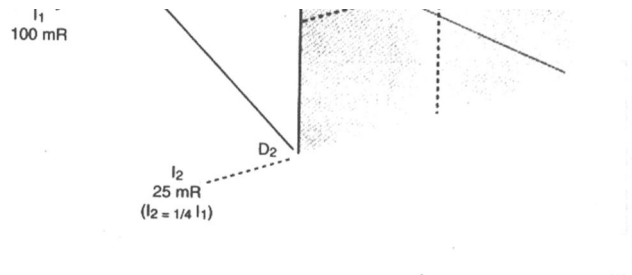
هنگامی که برای انجام یک روش، به نگهداری بیمار یا فیلم نیاز است، کارور باید با استفاده از دستورالعمل، بهترین روش را برای نگهداری و دستیابی به کیفیت تشخیص انتخاب کند.

منبع: جزوه دکتر افصلی‌پور ص ۸۴

- وسایل نگهدارنده می‌تواند شامل وسایل محدودکننده، اسفنج‌های نگهدارنده و بالنشهایی برای دادن وضعیت مناسب به بیمار و نگهدارنده متحرک فیلم باشد.

- اگر برای نگهداری یک بیمار یا فیلم کمک انسان لازم باشد، رعایت موارد زیر ضروری است: (۱) روش‌های ایمنی مدون برای نگهدارنده لازم است. (۲) فرد نگهدارنده ملزم به پوشیدن روپوش سربی مناسب و طبق مقررات ایالتی یا محلی، در صورت لزوم دستکش است. (۳) از یک فرد نباید به‌طور مداوم به‌عنوان نگهدارنده استفاده نمود. (۴) در مواردی که لازم باشد بیمار فیلم را (به‌جز در رادیوگرافی دندان) تحت تابش قرار می‌دهد، باید با مواد معادل 0.5 mm سرب پوشیده شود.

منبع: جزوه دکتر افصلی‌پور ص ۸۵ و ص ۸۶



شکل – پرتوهای پراکنده و موقعیت کارکنان (A و B): نگاه‌دارنده بیمار باید در زاویه 90 درجه نسبت به شعاع پرتو اولیه بایستد تا پرتوگیری به کمترین مقدار برسد.

اسلایدهای دکتر افصلی‌پور – ص ۹۳

۸. بیمار باردار

- از همه زنانی که تحت پرتونگاری به‌ویژه از ناحیه شکم قرار می‌گیرند، قبل از هر کاری باید در رابطه با وضعیت بارداری سؤال شود.
- طی دوران اول و دوم حاملگی از تابش‌گیری مستقیم شکم زنان باردار خودداری شود؛ در صورت امکان باید آزمایش تا بعد از وضع حمل به تعویق افتد یا حداقل در سه ماه آخر انجام شود.
- این گونه تصمیم‌گیری چندجانبه است؛ معمولاً فرض می‌شود که پزشک اول بیمار با تصمیم‌گیری بر مبنای منفعت و مخاطره به این نتیجه رسیده که انجام آزمایش ضروری است – اگرچه ممکن است همیشه فرض درستی نباشد.
- متخصص فیزیک، مسئول محاسبه دز دریافتی بیمار باردار است.

منبع: جزوه دکتر افصلی‌پور ص ۸۷ و ص ۸۸



شکل – پرسش از وضعیت بارداری پیش از پرتونگاری: در صورت امکان، آزمایش به بعد از وضع حمل یا به سه ماه آخر حاملگی موکول می‌شود.

اسلایدهای دکتر افصلی‌پور – ص ۸۷

۹. حفاظت پرتوکاران

- هیچ‌کس نباید به‌طور مداوم به نگهداری بیماران مبادرت کند.
- نگاه‌دارنده بیمار باید در زاویه 90 درجه نسبت به شعاع پرتو بایستد، روپوش سربی در بر کند و اگر ممکن باشد از دستکش سربی استفاده کند.
- سه اصل مهم حفاظت در برابر اشعه: زمان، فاصله و حفاظ.

- برای پرتوکار باردار، علاوه بر روپوش معمول، یک لایه اضافی سربی به ضخامت معادل ۰.۵ میلی‌متر سرب اضافه می‌کنند که باید تا حدود ۸ سانتی‌متر زیر سمفیز پوبیس را کاملاً بپوشاند.

منبع: منبع: ویدیو - دکتر افضل‌پور، فیزیک پزشکی - جلسه ۴ (فایل ۱۹) - ۲۴:۴۶ تا ۲۶:۲۵

- تکنیسین باردار نباید پرتونگاری پرتابل (دستگاه رادیولوژی سیار کنار تخت بیمار) انجام دهد؛ چون حین کار در معرض پرتو مستقیم قرار می‌گیرد.

- اصل فاصله در تصویربرداری پرتابل: فرد حاضر باید حداقل حدود ۲ متر از منبع پرتو و بیمار فاصله بگیرد؛ تشعشع بیمار پراکنده (Scatter) می‌شود و شدت پرتو پراکنده با افزایش فاصله کاهش می‌یابد.

- استفاده از دوزیمتر شخصی در این شرایط نیز توصیه شده است.

منبع: منبع: ویدیو - دکتر درویش، رادیوبیولوژی ۳ (فایل ۵۵) - ۲۰:۲۷ تا ۲۳:۰۰

- دوزیمتری پرتوکار (از ویدیو): برای هر پرتوکار - رادیولوژیست، تکنیسین رادیولوژی یا پزشکی هسته‌ای - وسیله‌ای مثل «فیلم بج» یا دوزیمتر گذاشته می‌شود تا دوز دریافتی اندازه‌گیری شود.

- این دوزیمترها به‌طور معمول هر دو ماه (یا هر ماه) یک‌بار خوانده می‌شوند و دوز تجمعی سالانه کنترل می‌گردد؛ اگر از مقدار معمول و حد مجاز بیشتر شود، فرد را از بخش پرتوی به بخش با تابش کمتر منتقل می‌کنند یا به او مرخصی داده می‌شود.

منبع: منبع: ویدیو - دکتر درویش، رادیوبیولوژی ۳ (فایل ۵۵) - ۱۹:۴۷ تا ۲۰:۱۵

۱۰. حدود دوز و مقایسه ریسک

- حد دوز برای پرتوکار: 50 mSv در سال.
- حد دوز برای افراد دیگر (حد دوز عمومی): 1 mSv در سال.
- حد دوز نباید برای مواجهه‌های پزشکی (بیماران) ناشی از اقدامات مجاز اعمال شود.

منبع: اسلایدهای رادیوبیولوژی دکتر درویش ص ۸۲

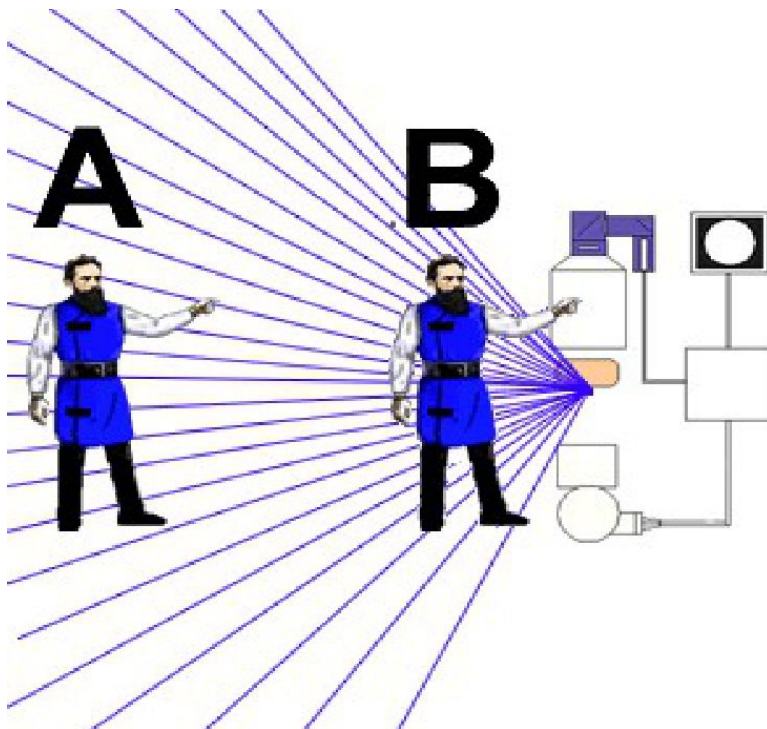
معادل	مقایسه ریسک: خطر مرگ 1 در هر 1,000,000 (10^{-6})
—	40 قاشق غذاخوری کره بادام‌زمینی
—	100 عدد استیک زغالی
—	2 روز در شهر نیویورک
—	1.5 پاکت سیگار در روز
—	10 mrem تابش
—	300 مایل با ماشین
—	1000 مایل با جت

منبع: اسلایدهای رادیوبیولوژی دکتر درویش ص ۲۴

۱۱. جمع‌بندی: اصول کاربردی حفاظت

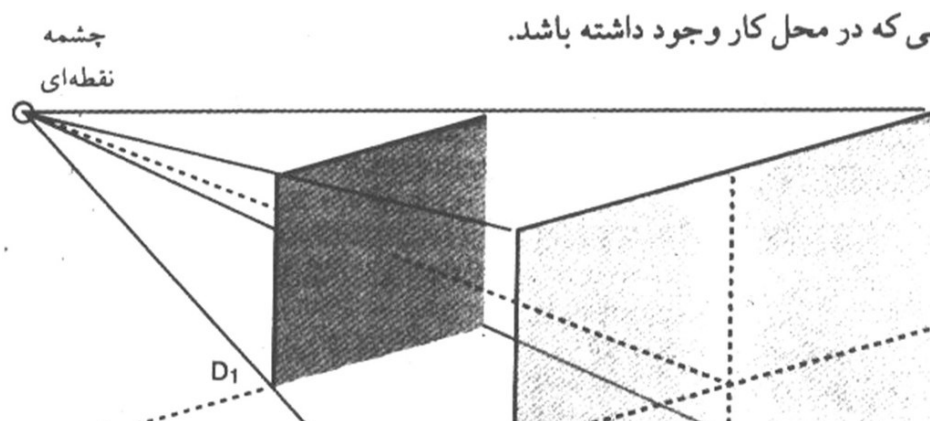
- کاهش زمان، افزایش فاصله و استفاده از حفاظ، سه راهکار عملی کاهش پرتوگیری خارجی‌اند.
- دوز ناشی از تابش با زمان رابطه مستقیم و با مجذور فاصله رابطه معکوس دارد.
- برای بیمار: کمترین تابش‌گیری با شرایط تکنیکی درست، توجه به اندازه آناتومیکی، استفاده از AEC و پرهیز از تکرار پرتونگاری.
- برای پرتوکار: روپوش و موانع معادل 0.25 mm سرب؛ برای گنادها 0.5 mm سرب.
- برای بارداری: پرسش از وضعیت بارداری، اجتناب از تابش مستقیم شکم در دوران اول و دوم، محاسبه دز توسط متخصص فیزیک.

منبع: جزوه دکتر افصلی‌پور ص ۷۶ تا ص ۹۰؛ اسلایدهای رادیوبیولوژی دکتر درویش ص ۸۱ و ص ۸۲



شکل – حفاظ‌های اتاق پرتونگاری: تفکیک موانع اولیه (دیوارها) و ثانویه (غرفه کنترل و شیشه سربی) برای کاهش پرتوگیری کارکنان مجاور.

اسلایدهای دکتر افصلی‌پور – ص ۹۶



شکل – کاهش آهنگ دوز با فاصله: مثال منبع، ۱۰۰ mR در فاصله ۱ متر و ۲۵ mR در فاصله ۲ متر (رابطه عکس مجذور فاصله).

جزوه دکتر افصلی‌پور – ص ۸۹، ۹۳، ۹۹، ۱۰۹، ۱۲۲ (ص ۹۳)



شکل - حفاظ‌های سربی متحرک (پرتابل) برای ایستادن پشت آن‌ها هنگام پرتونگاری پرتابل.

جزوه دکتر افضل‌پور - ص ۸۹، ۹۳، ۹۹، ۱۰۹، ۱۲۲ (ص ۹۹)

- در ماموگرافی نیازی به شیلد سربی در دیوارها نیست: چون انرژی پرتو کم است و جذب فوتوالکتریک بالا، بیشتر دوز در خود بیمار جذب می‌شود؛ در عوض فاصله‌گیری (حدود دو متر) و پشت شیشه‌ی سربی قرار گرفتن کافی است.
- در مقابل، در رادیولوژی عمومی و سی‌تی‌اسکن شیلد سربی در دیوارها به کار می‌رود.
- دوز سی‌تی‌اسکن به‌طور محسوس بیشتر از رادیوگرافی است: در یک بار چرخش گانتی چندین مقطع (نمونه منبع: حدود ۴۸ مقطع) تصویربرداری می‌شود و دوز هر مقطع به بیمار داده می‌شود.

منبع: ویدیو - دکتر درویش، رادیوبیولوژی ۳ (فایل ۵۵) - ۲۴:۵۱ تا ۲۷:۴۱

پرتو	ماده حفاظ مناسب	دلیل انتخاب
اشعه ایکس و گاما	سرب، بتون (و مواد با عدد اتمی بالا)	جذب فوتوالکتریک با عدد اتمی رابطه مستقیم دارد؛ عدد اتمی بالاتر (Z بالاتر) جذب فوتوالکتریک بیشتر - در منبع: توان سوم عدد اتمی
ذرات بتا	آلومینیوم یا پلاستیک	جذب ذره بتا در مواد سبک اتفاق می‌افتد (سرب به دلیل ترمز β و تولید Bremsstrahlung مناسب نیست)
نوترون	مواد هیدروژن‌دار (آب، پارافین)، بور و کادمیوم	کاهش انرژی نوترون با برخورد به هسته‌های سبک هیدروژن و جذب نوترون توسط بور/کادمیوم

منبع: ویدیو - دکتر درویش، رادیوبیولوژی ۳ (فایل ۵۵) - ۲۳:۳۳ تا ۲۶:۲۹

نکته امتحانی: مثال بالینی توجیه‌پذیری در ویدیو: مادر بارداری تصادف‌کرده – اگر تشخیص خونریزی داخلی با سونوگرافی ممکن نباشد، سی‌تی‌اسکن با وجود خطر برای جنین انجام می‌شود؛ چون در صورت تشخیص‌ندادن، هم مادر و هم جنین از بین می‌روند (سود بر ضرر مقدم است). توصیه‌ی استاد: اکسری و تصویربرداری را «سَرخود» ننویسید؛ همیشه توجیه‌پذیری و بهینه‌سازی را برای بیمار در نظر بگیرید.

مرور سریع

- سیستم حفاظت: توجیه‌پذیری، بهینه‌سازی (ALARA) و محدودیت دوز.
- حد دوز: پرتوکار 50 mSv در سال؛ عمومی 1 mSv در سال؛ بیماران از حد دوز مستثنا هستند.
- سه اصل عملی: زمان (رابطه مستقیم)، فاصله (عکس مجذور)، حفاظ (کاهش آهنگ دوز با ضخامت).
- حفاظ‌ها: روپوش پرتوکار 0.25 mm معادل سرب؛ حفاظ گناد 0.5 mm سرب؛ فاصله بیمار حداقل 2 m از لامپ و گیرنده تصویر.
- نمودار شرایط تکنیکی: اندازه آناتومیکی، عوامل تکنیکی، فیلم/صفحه، SID و محل حفاظ گونادی.
- AEC تابش‌گیری بیمار را کاهش می‌دهد؛ اگر خراب باشد باید از نمودار شرایط استفاده کرد.
- بیمار باردار: پرسش وضعیت بارداری، تعویق یا انجام در سه ماه آخر در صورت امکان، محاسبه دز با متخصص فیزیک.
- سازمان‌ها: ICRP (توصیه)، IAEA (استانداردهای ایمنی)، UNSCEAR (مطالعه اثرات).

فصل ۷ از ۹



فصل ۷

فیزیک سونوگرافی و اولتراسوند

دکتر حق پرست

صفحه‌های ۷۶ تا ۹۱

۵

جدول

۱۲

شکل

۶۹

بخش

۱. جایگاه صوت و طبقه‌بندی امواج

سونوگرافی، برخلاف رادیولوژی که بر پایه عبور و جذب پرتو کار می‌کند، بر اساس ثبت و مطالعه امواج فراصوت با بازتابش از بافت‌های مختلف بدن بنا شده است.

منبع: جزوه فیزیک سونوگرافی – دکتر حق‌پرست ص ۴

- صوت یک موج مکانیکی است؛ فقط در محیط مادی منتشر می‌شود و در خلاء منتشر نمی‌شود.
- نور (و دیگر امواج الکترومغناطیس) برخلاف صوت، در خلاء نیز منتشر می‌شود.

منبع: جزوه فیزیک سونوگرافی – دکتر حق‌پرست ص ۴

دسته	محدوده فرکانس	توضیح
مادون صوت (Infrasound)	کمتر از 16 هرتز	مانند امواج زلزله؛ گوش انسان نمی‌شنود ولی برخی حیوانات (سگ، گربه، اسب) درک می‌کنند
صوت قابل شنیدن	16 هرتز تا 20 کیلوهرتز	گوش انسان قادر به شنیدن و درک آن است
فراصوت (Ultrasound)	از 20 کیلوهرتز	امواجی که در سونوگرافی استفاده می‌شود

منبع: جزوه فیزیک سونوگرافی – دکتر حق‌پرست ص ۴

- در عمل، فرکانس‌های مورد استفاده در تصویربرداری پزشکی بسیار بالاتر و در حد مگاهرتز (MHz) است.
- در چشم‌پزشکی از فرکانس‌های حدود 15 تا 20 مگاهرتز استفاده می‌شود.

منبع: جزوه فیزیک سونوگرافی – دکتر حق‌پرست ص ۴

- آستانه ۲۰ کیلوهرتز تعریف اولتراسوند است، اما فرکانس‌های کاربردی در تصویربرداری پزشکی در محدوده مگاهرتز است: ۲ تا ۵ مگاهرتز برای شکم و قلب، ۱۰ تا ۲۰ مگاهرتز برای بافت‌های سطحی و چشم.
- مثال‌های کاربردی فرکانس: اسکن کل بدن و اسکن قلب با فرکانس‌های پایین‌تر (نفوذ بیشتر)، چشم و بافت‌های سطحی با فرکانس بالاتر (تفکیک بهتر).

- واحدهای کوچک طول موج: ۱ آنگستروم = 10^{-10} متر و ۱ نانومتر = 10^{-9} متر؛ در نمایش انرژی-فرکانس امواج الکترومغناطیس $E = h\nu$ با ثابت پلانک $h \approx 6.626 \times 10^{-34}$ J.s برقرار است.

منبع: منبع: ویدیو – دکتر حق‌پرست، سونوگرافی (فایل ۰۸) – ۱۲:۰۱ تا ۲۱:۰۷

- در چشم‌پزشکی برای بررسی مجاری و بافت‌های داخلی چشم، فرکانس‌های حدود ۱۰ تا ۲۰ مگاهرتز به کار می‌رود (نزدیک‌ترین کاربرد به ۱۵ تا ۲۰ مگاهرتز برای بافت‌های سطحی چشم).
- برای اندام‌های عمقی و بافت‌های نرم از فرکانس‌های پایین‌تر (حدود ۲.۵ تا ۵ مگاهرتز) استفاده می‌شود؛ زیرا فرکانس بالاتر → نفوذ کمتر.

منبع: منبع: ویدیو – دکتر حق‌پرست، سونوگرافی (فایل ۰۷) – ۳۵:۰۱ تا ۵۸:۰۲

ویژگی	پرتوهای الکترومغناطیس (مانند ایکس)	اولتراسوند
رابطه فرکانس و قدرت نفوذ	فرکانس بالاتر → قدرت نفوذ بیشتر	فرکانس بالاتر → قدرت نفوذ کمتر

منبع: جزوه فیزیک سونوگرافی - دکتر حق‌پرست ص ۵

نکته امتحانی: رابطه فرکانس و قدرت نفوذ در اولتراسوند، برعکس پرتوهای الکترومغناطیس (مانند ایکس) است - نکته‌ای که در امتحان اغلب به صورت مقایسه‌ای پرسیده می‌شود.

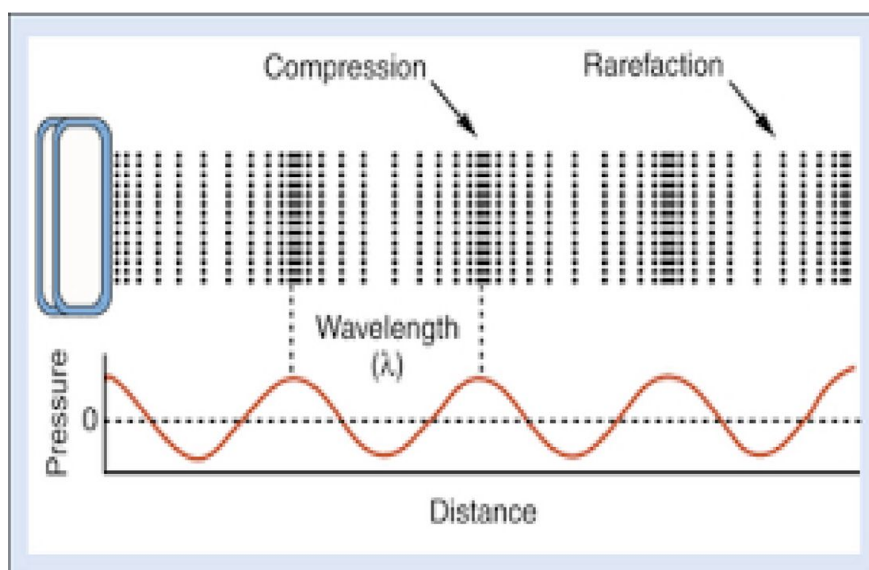
۲. خصوصیات فیزیکی امواج صوتی (پنج کمیت پایه)

پنج کمیت پایه‌ای رفتار هر موج صوتی را توصیف می‌کنند: طول موج، فرکانس، دوره تناوب، سرعت انتشار و شدت.

منبع: جزوه فیزیک سونوگرافی - دکتر حق‌پرست ص ۶

- طول موج (λ): حداقل فاصله بین دو نقطه با وضعیت ارتعاش یکسان، یا فاصله دو نقطه متراکم (قله) یا منبسط (دره) متوالی؛ در امواج صوتی زیر و بُم بودن صوت را تعیین می‌کند و در امواج الکترومغناطیس با انرژی و قدرت نفوذ متناسب است.
- فرکانس (f): تعداد تراکم‌ها یا انبساط‌ها (نوسانات) در واحد زمان.
- دوره تناوب (T): مدت زمان لازم برای ایجاد یک نوسان کامل.

منبع: جزوه فیزیک سونوگرافی - دکتر حق‌پرست ص ۶



شکل - موج صوتی: نواحی تراکم (Compression) و انبساط (Rarefaction) با طول موج λ ؛ نمودار پایین تغییر فشار را نسبت به فاصله و زمان نشان می‌دهد.

اسلایدهای M.Ph.D - ص ۶۳ و ص ۶۴

نکته کلیدی: فرکانس و دوره تناوب جزء خواص ذاتی موج‌اند و با تغییر شرایط محیط (مثلاً عبور از بافت نرم به استخوان) تغییر نمی‌کنند؛ در مقابل، سرعت انتشار، طول موج، شدت و امپدانس صوتی (حاصل ضرب چگالی در سرعت) خصوصیات فیزیکی محیط‌اند و با تغییر محیط تغییر می‌کنند.

$$C = f \times \lambda ; T = \frac{1}{f}$$

رابطه طول موج، فرکانس و دوره تناوب

C: سرعت انتشار صوت در محیط

f: فرکانس

λ : طول موج

T: دوره تناوب

منبع: جزوه فیزیک سونوگرافی – دکتر حق‌پرست ص ۶

سرعت صوت

سرعت صوت، مقدار مسافتی است که یک موج صوتی در واحد زمان در یک محیط طی می‌کند. در محیط هموژن (یکنواخت) امواج با یک سرعت ثابت حرکت می‌کنند، اما در محیط غیرهموژن سرعت صوت تغییر می‌کند. سه عامل این سرعت را تعیین می‌کنند:

منبع: جزوه فیزیک سونوگرافی – دکتر حق‌پرست ص ۷

- قابلیت تراکم‌پذیری: رابطه عکس با سرعت صوت دارد – گازها تراکم‌پذیری بالایی دارند، پس سرعت صوت در گازها کمترین مقدار را دارد.
- چگالی محیط: رابطه عکس با سرعت صوت دارد – محیط‌های چگال از مولکول‌های سنگین‌تر تشکیل شده‌اند که مقاومت بیشتری در برابر حرکت دارند.
- الاستیسیته (کشسانی) محیط: با افزایش آن سرعت صوت بیشتر می‌شود.

منبع: جزوه فیزیک سونوگرافی – دکتر حق‌پرست ص ۷

$$C_{\text{solid}} > C_{\text{liquid}} > C_{\text{gas}}$$

ترتیب سرعت صوت در محیط‌ها

سرعت صوت: جامدات < مایعات < گازها

بافت نرم بدن: 1540 m/s

منبع: جزوه فیزیک سونوگرافی – دکتر حق‌پرست ص ۸

شدت

پنجمین کمیت پایه‌ای موج صوتی، شدت (Intensity) است: مقدار انرژی صوتی که در واحد زمان از واحد سطح عبور می‌کند. واحد شدت: $\text{J/m}^2 \cdot \text{s}$ (معادل W/m^2).

منبع: جزوه فیزیک سونوگرافی – دکتر حق‌پرست ص ۸

نکته امتحانی: سرعت، طول موج، شدت و امپدانس صوتی (حاصل‌ضرب چگالی در سرعت) هر چهار کمیت تابع خصوصیات فیزیکی محیط‌اند؛ در حالی که فرکانس و دوره تناوب ذاتاً به خودِ موج تعلق دارند و در هر محیطی ثابت می‌مانند.

۳. تولید امواج اولتراسوند

روش	مبنا	کاربرد
سوتک گالتون (Galton Whistle)	دمیدن در لوله‌های صوتی؛ هرچه طول لوله کوتاه‌تر شود صوت زیرتر (فرکانس بالاتر) می‌شود	صرفاً نمایشی؛ کاربرد بالینی ندارد
مگنتواسترکسیون (Magnetostriction)	مواد فرومغناطیس (مانند نیکل) تحت میدان مغناطیسی تغییر طول داده و مرتعش می‌شوند؛ فرکانس تولیدی تا حدود 100 kHz	کاربرد اصلی در فیزیوتراپی برای گرم کردن بافت‌ها؛ برای تصویربرداری (نیازمند مگاهرتز) کافی نیست
پیزوالکتریک (Piezoelectric) – روش اصلی	مواد (کوارتز، سولفات لیتیوم، تیتانات زیرکونات سرب PZT و تیتانات باریم) تحت میدان الکتریکی متناوب دچار انقباض و انبساط پی‌درپی می‌شوند	روش اصلی تولید اولتراسوند در سونوگرافی تشخیصی

منبع: جزوه فیزیک سونوگرافی – دکتر حق‌پرست ص ۹

۴. ساختمان ترانس‌دیوسر (پروب)

در سونوگرافی، ترانس‌دیوسر یا همان «پروب»، وسیله‌ای است که انرژی الکتریکی (جریان برق) را به انرژی مکانیکی (امواج ماورای صوت) و برعکس تبدیل می‌کند. این فرایند بر پایه اصل پیزوالکتریک (فشار-الکتریسیته) استوار است؛ با تحریک الکتریکی، بلور منقبض و منبسط شده و امواج فراصوت تولید می‌کند.

منبع: جزوه فیزیک سونوگرافی – دکتر حق‌پرست ص ۱۰

- جعبه پلاستیکی (Casing): محفظه‌ای از جنس پلاستیک با کیفیت بالا (مانند کائوچو) که قطعات داخلی را نگه می‌دارد؛ سه وظیفه دارد: محافظت فیزیکی، عایق‌بندی صوت و عایق‌بندی الکتریکی.
- بلور پیزوالکتریک (Crystal): قلب و قسمت اصلی ترانس‌دیوسر؛ وظیفه تولید امواج اولتراسوند از جریان الکتریکی و تبدیل امواج بازگشتی از بافت‌ها به پالس‌های الکتریکی بر عهده همین بلور است. انواع بلور: طبیعی (کوارتز یا سولفات لیتیوم) یا مصنوعی (PZT و تیتانات باریم).
- الکترودها: دو صفحه نازک هادی در دو سطح بلور که میدان الکتریکی متناوب را اعمال می‌کنند (پیزوالکتریک معکوس) یا بار الکتریکی تولیدشده توسط بلور را جمع‌آوری می‌کنند (پیزوالکتریک مستقیم).
- لایه جفت‌کننده (Matching Layer): لایه‌ای است که بین بلور و بافت قرار می‌گیرد.

منبع: جزوه فیزیک سونوگرافی – دکتر حق‌پرست ص ۱۰ و ص ۱۱

چرا لایه جفت‌کننده لازم است؟ امپدانس صوتی بلور بسیار بالاست – حدود 20 تا 25 برابر امپدانس بافت نرم. اگر بلور مستقیماً روی پوست قرار گیرد، به دلیل این اختلاف امپدانس زیاد، امواج اجازه نفوذ نمی‌یابند و در همان مرز بازتاب می‌شوند. وظیفه لایه جفت‌کننده، ایجاد امپدانس صوتی بینابینی (میان بلور و بافت) است تا ورود امواج به داخل بدن را تسهیل کرده و از انعکاس در مرز بلور-بافت جلوگیری کند. این لایه معمولاً از رزین اپوکسی و پودر تنگستن ساخته می‌شود.

منبع: جزوه فیزیک سونوگرافی – دکتر حق‌پرست ص ۱۱

- عدد دقیق ویدیو برای اختلاف امپدانس بلور و بافت نرم: حدود ۲۰ تا ۳۰ برابر (جزوه: ۲۰ تا ۲۵ برابر).

- برای عبور امواج، روی پوست بیمار «ژل» مالیده می‌شود؛ ژل هوا را از مرز پروب-پوست حذف می‌کند و همان نقش لایه جفت‌کننده را در بیرون پروب ایفا می‌نماید.

- بدون ژل، به دلیل بازتاب در لایه هوا، تنها مقدار ناچیزی از امواج فراصوت به بافت منتقل می‌شود و تصویر به دست نمی‌آید.

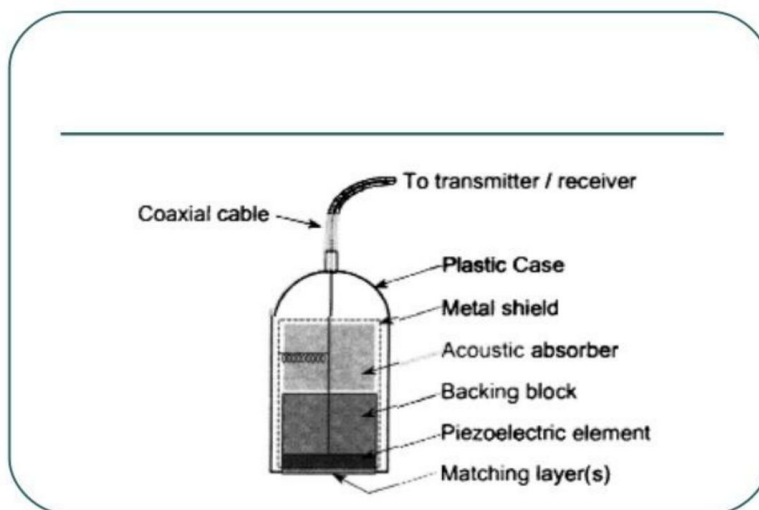
منبع: منبع: ویدیو – دکتر حق‌پرست، سونوگرافی (فایل ۱۰) – ۰۶:۲۹ تا ۰۹:۳۲

- لایه میراکننده (Backing) – در متن‌های مختلف «لایه پشتی»، «بلوک پشتی» یا «لایه پشتیبان» هم نامیده می‌شود؛ همه یک لایه‌اند): در سونوگرافی تشخیصی، هدف کسب تصویر باکیفیت است؛ بنابراین از ماده میراکننده با امپدانس نزدیک به بلور (بیشترین جذب و خفه‌کردن لرزش) استفاده می‌شود تا لرزش‌ها سریعاً خفه شوند.

- درمانی (مانند سنگ‌شکن کلیه): هدف تصویربرداری نیست، بلکه درمان با شدت بالای امواج است؛ در این دستگاه‌ها گاهی از هوا به عنوان لایه میراکننده (پشتی) استفاده می‌کنند، زیرا اختلاف امپدانس زیاد بین بلور و هوا موجب می‌شود امواج پشتی دوباره به سمت بیمار بازتاب شوند و با شدت بیشتری برای تخریب سنگ‌های کلیوی عمل کنند.

- مثال‌های عمومی ترانس‌دیوسر: لامپ (تبدیل انرژی الکتریکی به نور و گرما)، تلویزیون (تبدیل امواج به صدا و تصویر)، بلندگو و میکروفون (تبدیل انرژی الکتریکی به صوتی و برعکس).

منبع: جزوه فیزیک سونوگرافی – دکتر حق‌پرست ص ۱۰ و ص ۱۲



شکل – برش ترانس‌دیوسر: کابل کواکسیال، محفظه پلاستیکی، حفاظ فلزی، لایه میراکننده (Backing)، بلور پیزوالکتریک و لایه تطبیق (Matching layer).

اسلایدهای M.Ph.D – ص ۸۵

- در سنگ‌شکن کلیه، ترانس‌دیوسرها با پشت‌بندی هوا ساخته می‌شوند تا امواج برگشتی دوباره به سمت بیمار بازتاب پیدا کنند و شدت تخریب سنگ بیشتر شود – همان استثنایی که در جزوه توضیح داده شده است.

منبع: منبع: ویدیو – دکتر حق‌پرست، سونوگرافی (فایل ۱۰) – ۱۱:۱۳

۵. برهم‌کنش اولتراسوند با بافت بدن

ترانس‌دیوسر یک دسته پرتو فراصوت تولید و به بدن بیمار هدایت می‌کند؛ با عبور از بافت‌های مختلف، شدت این دسته پرتو کاهش می‌یابد. مکانیسم‌های مسئول این تضعیف عبارت‌اند از: جذب (تبدیل به گرما)، شکست، پراکندگی (Scatter)، تداخل و بازتابش (انعکاس).

نکته کلیدی: تفاوت بنیادی با رادیوگرافی: در تصویربرداری با اشعه ایکس، تصویر بر پایه نفوذپذیری و میزان جذب پرتو ساخته می‌شود؛ اما اساس تشکیل تصویر در سونوگرافی بر پایه بازتابش (Reflection) است. میزان یا درصد پرتوهای بازتابی تابع دو عامل است: امپدانس صوتی بافت و زاویه پرتو تابشی.

عامل اول: امپدانس صوتی

$$Z = \rho \times C$$

امپدانس صوتی (Acoustic Impedance)

Z: امپدانس صوتی (چگالی بافت × سرعت صوت در بافت)

ρ : چگالی بافت

C: سرعت صوت در بافت

واحد: Rayls = $(g/cm^2 \cdot s) \times 10^5$

نکته کلیدی: عدد بازتاب در ویدیو: استاد برای مرز عضله/هوا عدد 99.5% را ذکر می‌کند (تقریباً کل انرژی برمی‌گردد)؛ به همین دلیل سونوگرافی ریه کاربرد تشخیصی ندارد. در جدول بالای همین بخش عدد جزوه (99.9%) آمده است؛ هر دو یک معنا دارند: بازتاب در مرز بافت-هوا تقریباً کامل است. همین موضوع دلیل شنیده‌نشدن صدای قلب بدون گوشی پزشکی است.

مرز بافتی	امپدانس‌ها	درصد بازتاب
عضله / هوای ریه	1.7 در برابر 0.0004	$\approx 99.9\%$ (تقریباً کامل)
چربی / کلیه	1.38 در برابر 1.62	$\approx 1.4\%$ (حدود 98.6% عبور)

اگر اختلاف امپدانس صوتی در مرز مشترک دو بافت صفر باشد، کل دسته پرتو عبور می‌کند و بازتابشی وجود نخواهد داشت؛ هرچه اختلاف امپدانس در مرز دو بافت بیشتر باشد، بازتابش قوی‌تر خواهد بود. درصد این بازتابش را می‌توان محاسبه کرد:

$$R\% = \left(\frac{Z_2 - Z_1}{Z_2 + Z_1} \right)^2 \times 100$$

درصد بازتاب (Reflection)

Z_1 و Z_2 : امپدانس صوتی دو بافت در دو طرف مرز

R%: درصد انرژی بازتاب‌شده (بازتابش)

$$T = 1 - R$$

درصد عبور (Transmission)

T: درصد عبور (انتقال) انرژی از مرز

R: درصد بازتاب؛ درصد عبور مکمل درصد بازتاب است ($T = 1 - R$)

منبع: جزوه فیزیک سونوگرافی – دکتر حق‌پرست ص ۱۳ و ص ۱۴

- از رابطه بالا، درصد عبور (Transmission) نیز به سادگی از رابطه مکمل $T = 1 - R$ به دست می‌آید؛ یعنی هرچه بازتابش بیشتر باشد، عبور کمتر است و برعکس.
- نمونه عددی همین مکمل بودن: در مرز عضله/هوا بازتابش $\approx 99.9\%$ و عبور $\approx 0.1\%$ (تقریباً هیچ موجی عبور نمی‌کند)؛ در مرز چربی/کلیه بازتابش $\approx 1.4\%$ و عبور $\approx 98.6\%$ (تقریباً کل موج عبور می‌کند).
- درصد عبور همان کمیتی است که در رادیوگرافی مبناست (پرتو عبوری تصویر می‌سازد)؛ در سونوگرافی برعکس، کمیت تعیین‌کننده درصد بازتاب است.

منبع: جزوه فیزیک سونوگرافی – دکتر حق‌پرست ص ۱۳ و ص ۱۴

- محدودیت سونوگرافی ریه: به دلیل اختلاف بسیار زیاد امپدانس صوتی بین بافت و هوا، تقریباً تمام موج در همان مرز بازتاب می‌شود و هیچ موجی برای نفوذ به لایه‌های عمقی‌تر باقی نمی‌ماند.
- شنیده‌نشدن صدای قلب بدون گوشی پزشکی: در مرز بین عضله و هوای بیرون، به دلیل همین اختلاف زیاد امپدانس، بازتاب تقریباً 100% رخ می‌دهد؛ گوشی پزشکی با حذف واسطه هوا این مشکل را برطرف می‌کند.
- همین ماهیت مبتنی بر بازتاب، دلیل اصلی آن است که کیفیت تصویر سونوگرافی نسبت به MRI یا CT رزولوشن فضایی و کنتراست کمتری دارد.

منبع: جزوه فیزیک سونوگرافی – دکتر حق‌پرست ص ۱۴ و ص ۱۵

عامل دوم: زاویه تابش

- پروب سونوگرافی باید کاملاً عمود بر سطح بافت قرار گیرد. طبق قانون اسنل، اگر پروب با زاویه (غیرعمود) قرار گیرد، امواج بازتابی به سمت پروب برنمی‌گردند و دستگاه سیگنالی برای تشکیل تصویر ندارد.

منبع: جزوه فیزیک سونوگرافی – دکتر حق‌پرست ص ۱۵

نکته امتحانی: دو عامل تعیین‌کننده بازتابش را همیشه با هم به یاد بیاورید: (۱) اختلاف امپدانس صوتی دو بافت، (۲) عمود بودن زاویه تابش پروب – نبود هرکدام باعث از دست رفتن سیگنال می‌شود.

۶. تکنیک‌های تصویربرداری سونوگرافی

حالت	مبنا	کاربرد
A-mode (Amplitude Mode)	دامنه امواج بازگشتی از بافت‌ها به صورت یک مقیاس (پیک) ثبت می‌شود	بررسی ضخامت بافت‌ها، جسم خارجی، تشخیص تومورهای مغزی از روی جابه‌جایی خط میانی مغز؛ اکو-افتالموگراف در چشم‌پزشکی (فرکانس حدود 15 تا 20 مگاهرتز)
B-mode (Brightness Mode)	تصاویر دوبعدی؛ بازتاب‌ها به صورت نقاط روشن و تاریک نمایش داده می‌شوند	مراقبت‌های بارداری (جفت سرراهی، سن جنین از روی قطر استخوان لگن، رشد یا سوءتغذیه جنین، تعیین جنسیت)، بررسی سینه، کلیه، کبد و مثانه
M-mode (Motion Mode)	معادل اکوکاردیوگرافی	بررسی حرکت دریچه‌های قلب (مانند دریچه میترال)؛ فرکانس معمول 3.5 تا 4.5 مگاهرتز
Doppler D-mode (Effect)	اثر داپلر: تغییر فرکانس بازگشتی با حرکت منبع/بازتابنده	بررسی جریان خون، تشخیص تنگی عروق، ثبت صدای قلب جنین، داپلکس

منبع: جزوه فیزیک سونوگرافی – دکتر حق‌پرست ص ۱۷ تا ص ۲۰



شکل – نمونه تصویر B-mode: سونوگرافی جنین؛ بازتاب‌ها به صورت نقاط روشن روی زمینه تیره نمایش داده می‌شوند.

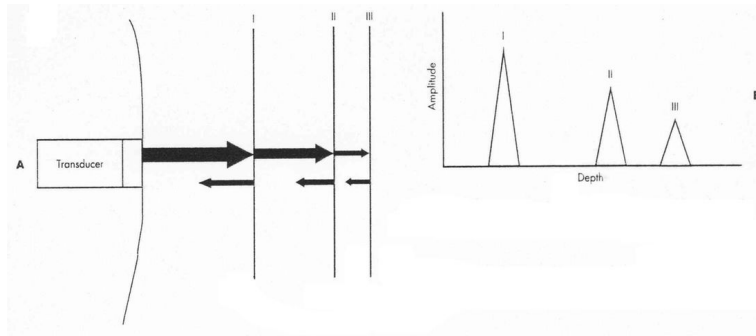
اسلایدهای M.Ph.P.D – ص ۹۴

$$\text{عمق} = \frac{\text{سرعت صوت} \times \text{زمان رفت و برگشت پالس}}{2}$$

محاسبه عمق در A-mode

مثال منبع: اگر زمان رفت و برگشت یک پالس ۲۶۰ میکروثانیه و سرعت صوت 1540 m/s باشد، عمق از همین رابطه محاسبه می‌شود

منبع: جزوه فیزیک سونوگرافی – دکتر حق‌پرست ص ۱۸

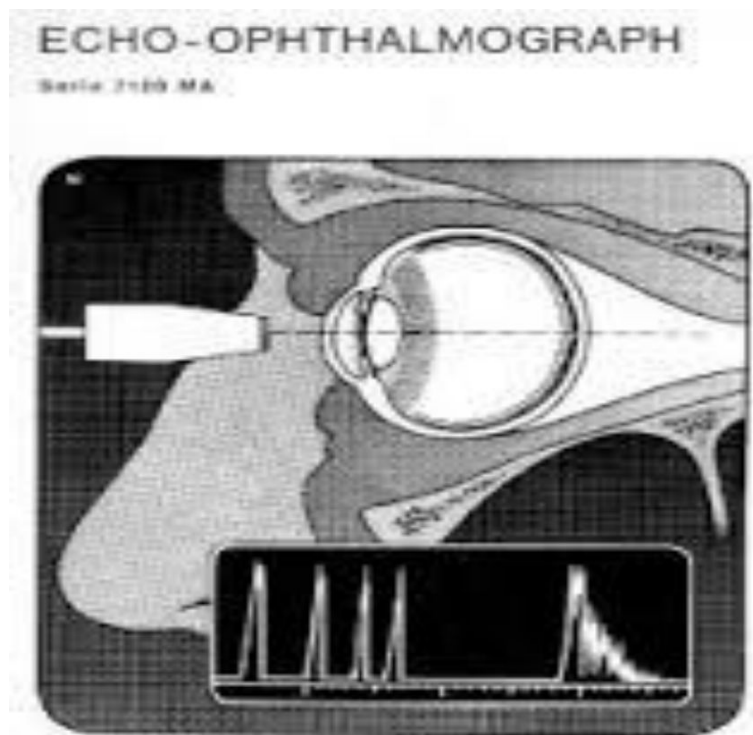


شکل – A-mode با سه مرز: هر مرز بازتاب یک پیک (اسپایک) روی نمایشگر می‌سازد؛ فاصله زمانی پیک‌ها نشان‌دهنده عمق مرزها است.

اسلایدهای M.Ph.D – ص ۹۰

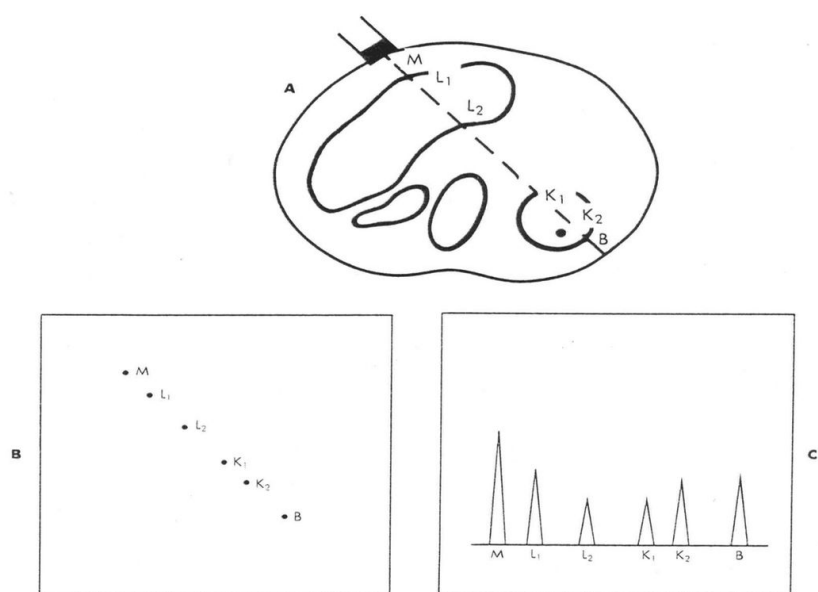
- کاربرد بالینی A-mode در چشم‌پزشکی: برای بررسی آب‌مروارید (cataract) ضخامت عدسی اندازه‌گیری می‌شود؛ زمان رفت و برگشت موج فرستاده‌شده به سطح قدامی و سطح خلفی عدسی، فاصله (ضخامت) عدسی را می‌دهد.
- چون بافت چشم سطحی است، فرکانس ارسالی در این کاربرد از حدود 15 تا 20 مگاهرتز انتخاب می‌شود (فرکانس بالاتر → نفوذ کمتر ولی دقت بالاتر).
- کاربرد دیگر A-mode در مغز: تومورهای مغزی فشار می‌آورند و خط میانی (midline) را جابه‌جا می‌کنند؛ این جابه‌جایی با A-mode دیده می‌شود.

منبع: منبع: ویدیو – دکتر حق‌پرست، سونوگرافی (فایل ۰۷) – ۱۵:۰۱ تا ۲۵:۰۳



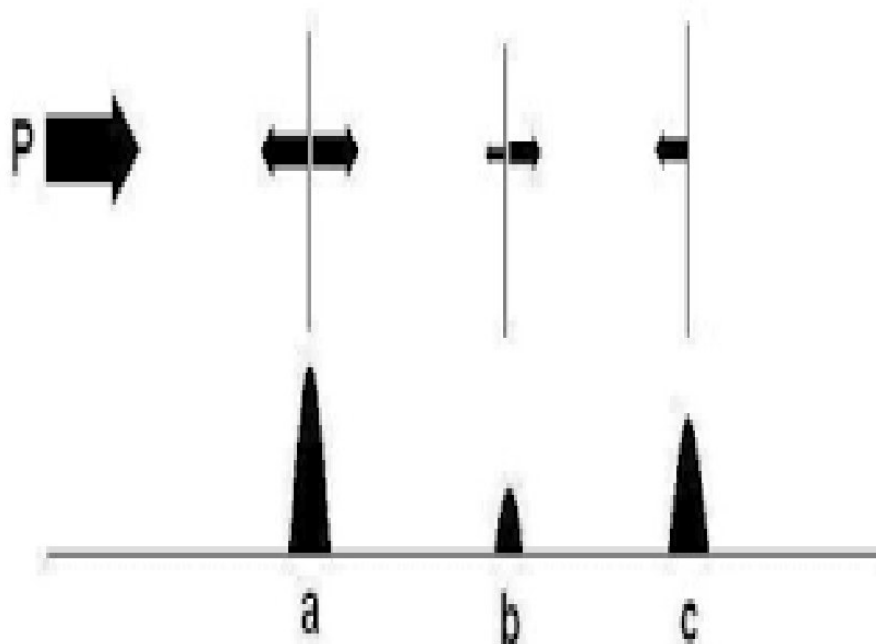
شکل - تصویربرداری A-mode از چشم (Echo-Ophthalmograph): پروب روی چشم قرار می‌گیرد و پیک‌های بازتابی، فاصله‌های داخلی چشم (از جمله ضخامت عدسی) را نشان می‌دهند.

اسلایدهای M.Ph.D - ص ۹۱



شکل - مقایسه نمایش A-mode (تنها دامنه پیک‌ها) و B-mode (روشنایی نقاط روی تصویر دوبعدی).

اسلایدهای M.Ph.D - ص ۹۳



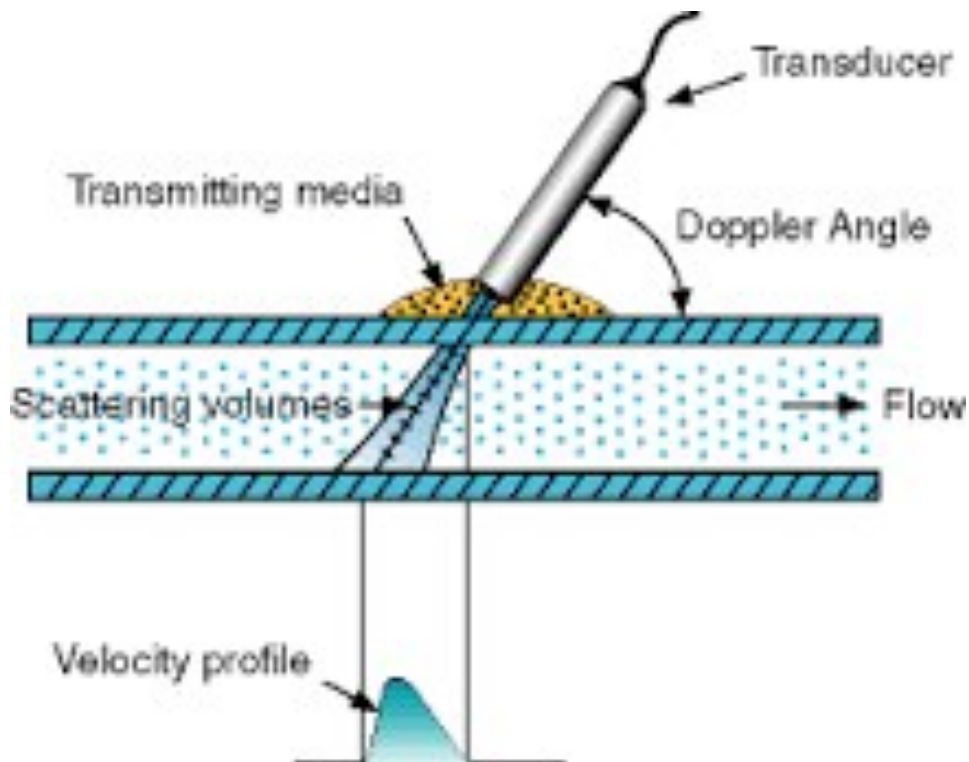
شکل – نمایش A-mode برای سه مرز بازتابی مختلف: هر مرز یک پیک با دامنه متفاوت روی نمایشگر می‌سازد.

اسلایدهای M.Ph.D – دکتر حق‌پرست – ص ۹۱

۷. اثر داپلر و حالت D

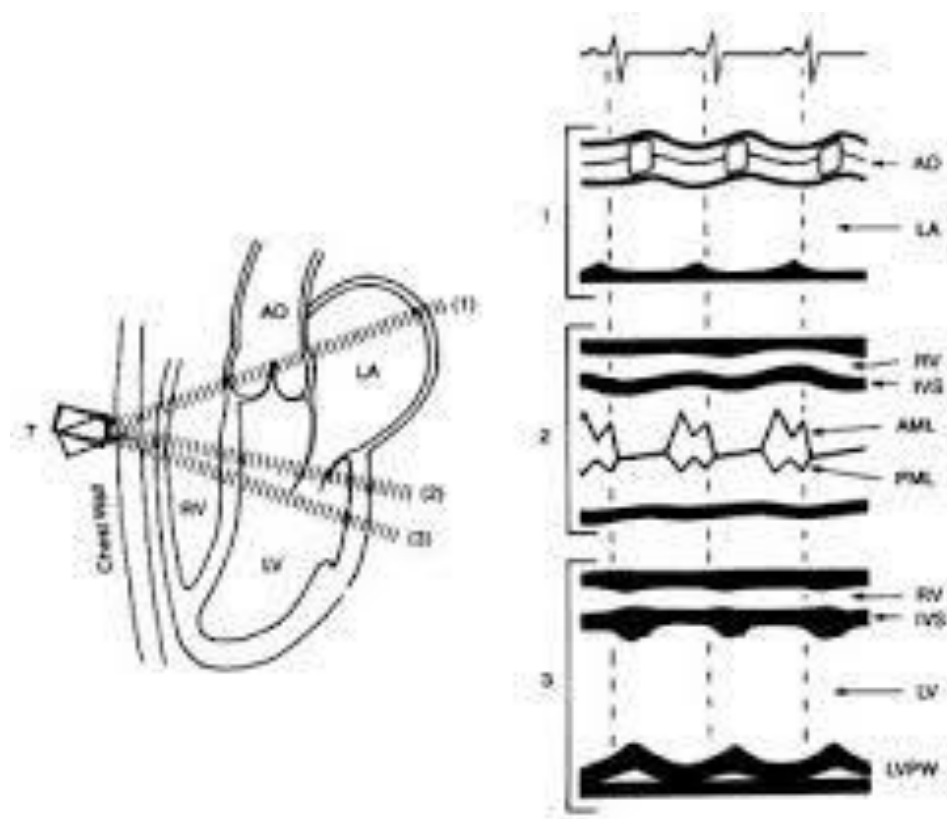
- اثر داپلر: با حرکت منبع صوتی، فرکانس دریافتی تغییر می‌کند و افزایش/کاهش فرکانس دریافتی مشاهده می‌شود.
- در حرکت دورشونده، فرکانس دریافتی از ارسالی کمتر می‌شود؛ در حرکت نزدیک‌شونده، فرکانس دریافتی از ارسالی بیشتر می‌شود.

منبع: جزوه فیزیک سونوگرافی – دکتر حق‌پرست ص ۲۱



شکل - هندسه داپلر: ترانس دیوسر، محیط جفت کننده (Transmitting Media)، حجم نمونه گیری (Sampling Volume)، زاویه داپلر (Doppler Angle) و پروفایل سرعت جریان.

اسلایدهای M.Ph.D - ص ۹۵ و ۱۰۲ (ص ۱۰۲)



شکل - تعریف دیواره رگ با داپلر رنگی توانی (Power Doppler): در نزدیکی دیواره رگ، سرعت جریان کم می شود و سیگنال ضعیف تر می شود؛ همین پدیده برای تشخیص سطح داخلی رگ به کار می رود.

اسلایدهای M.Ph.D - ص ۹۵ و ۱۰۲ (ص ۹۵)

$$F_d = F_v - F_t; F_d = \frac{2 F_t v \cos \theta}{c}$$

فرکانس داپلر (شیفت فرکانسی)

F_d : فرکانس داپلر (شیفت فرکانسی)

F_t : فرکانس موج ارسالی (اصلی)

F_v : فرکانس موج بازگشتی (دریافتی)

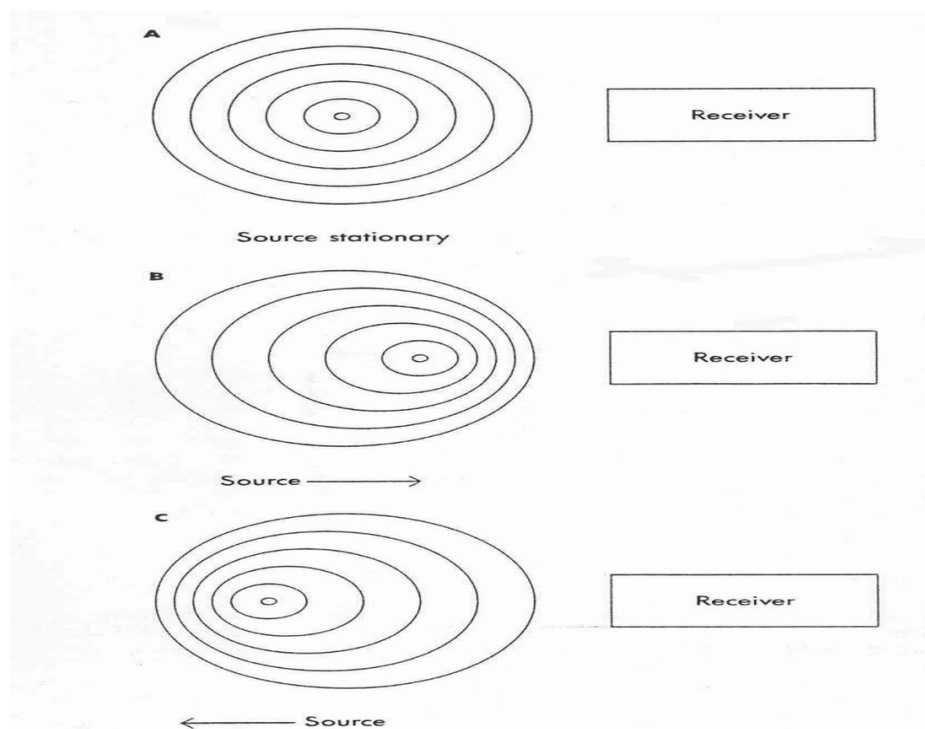
v : سرعت سیال (خون)

c : سرعت صوت در بافت

θ : زاویه پروب نسبت به مسیر جریان

اگر $F_v < F_t$ حرکت دورشونده و اگر $F_v > F_t$ حرکت نزدیک‌شونده است

منبع: جزوه فیزیک سونوگرافی - دکتر حق‌پرست ص ۲۱



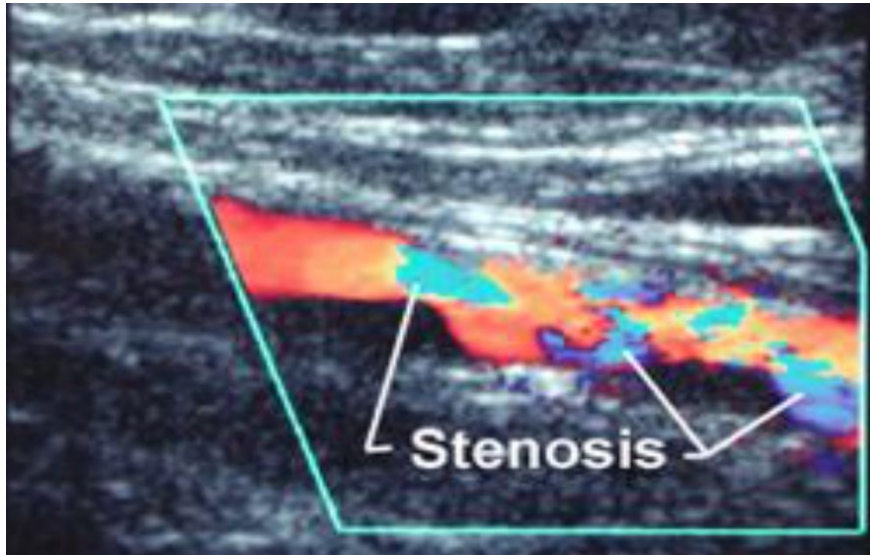
شکل - اثر داپلر: در حالت ساکن (الف) فرکانس دریافتی با ارسالی برابر است؛ در حالت متحرک (ب) امواج در جلو فشرده و در عقب باز می‌شوند و فرکانس دریافتی تغییر می‌کند.

اسلایدهای M.Ph.D - ص ۹۶

- در حالت عادی، فرکانس موج دریافتی با ارسالی برابر است؛ در بافت‌های ساکن (غیرمتحرک) هیچ شیفت فرکانسی نداریم.
- هر جا بازتابنده (خون یا دیواره قلب جنین) حرکت کند، فرکانس دریافتی F_v با ارسالی F_t تفاوت پیدا می‌کند و همین اختلاف، «شیفت داپلر» F_d را می‌سازد.
- آنچه برای صدای قلب جنین ثبت می‌شود، اختلاف فرکانس‌ها و در واقع تغییرات آهنگ حرکت قلب است، نه صدای واقعی ضربان. همین اصل برای تشخیص «وجود یا نبود جریان خون در یک رگ» به‌کار می‌رود.

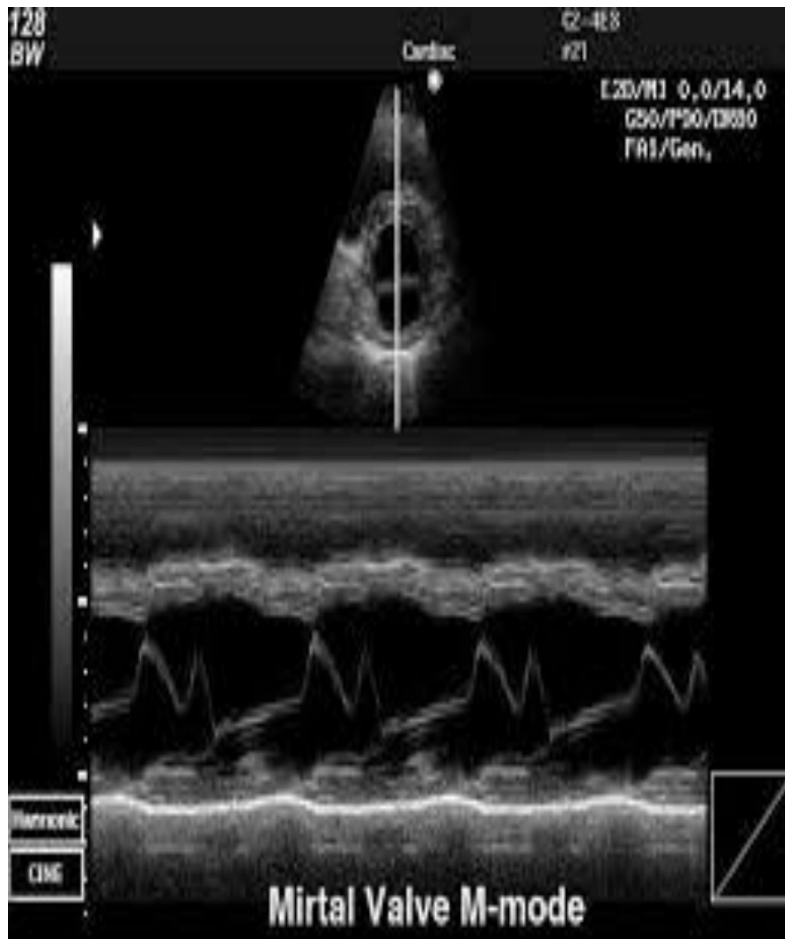
- کاربردهای بالینی داپلر: بررسی وجود یا عدم جریان خون در یک رگ و تعیین سرعت جریان خون، از جمله تشخیص تنگی یا استنوز عروقی.
- ثبت صدای قلب جنین: یک دسته موج با فرکانس مشخص Ft به سمت جنین ارسال و بازتاب آن با فرکانس تغییر یافته Fv دریافت می‌شود؛ اختلاف این دو فرکانس، صدای قلب جنین را ثبت می‌کند.
- داپلکس (Duplex): ترکیبی هم‌زمان از تصویر (مثلاً B-mode) و اطلاعات داپلر.

منبع: جزوه فیزیک سونوگرافی - دکتر حق‌پرست ص ۲۲



شکل - تشخیص تنگی (استنوز) با داپلر رنگی: ناحیه تنگ، جریان خون پرسرعت و تغییرات فرکانسی را نشان می‌دهد.

اسلایدهای M.Ph.D - ص ۱۰۲



شکل – اکوکاردیوگرافی M-mode دریچه میترال: حرکت دریچه در طول زمان (نمایش M-mode) ثبت می‌شود.

اسلایدهای M.Ph.D – ص ۹۵

نکته امتحانی: در فرمول داپلر، اگر فرکانس دریافتی از فرکانس ارسالی کمتر باشد یعنی جسم در حال دور شدن است؛ اگر بیشتر باشد یعنی در حال نزدیک شدن است – این نکته مبنای بسیاری از سوالات تشخیصی داپلر است.

نکته کلیدی: قرارداد این جزوه برای فرمول داپلر (بر پایه اسلاید فارسی درس): v سرعت حرکت سیال (خون) و C سرعت صوت در بافت است. در یکی از اسلایدهای انگلیسی همین مبحث این دو حرف جابه‌جا تایپ شده‌اند؛ برای پرهیز از خطا، همیشه از قرارداد همین جزوه استفاده کنید: $F_d = 2 \cdot F_t \cdot v \cdot \cos\theta / C$.

- صوت موج مکانیکی است و در خلاء منتشر نمی‌شود؛ اولتراسوند فراتر از 20 kHz و در تصویربرداری پزشکی در محدوده مگاهرتز است.
- رابطه فرکانس و نفوذ در اولتراسوند برعکس ایکس است (فرکانس بالاتر → نفوذ کمتر).
- پنج کمیت پایه: طول موج، فرکانس، دوره تناوب، سرعت انتشار و شدت؛ فرکانس و دوره تناوب ذاتی موج‌اند.
- سرعت صوت: جامدات < مایعات < گازها؛ بافت نرم 1540 m/s؛ تراکم‌پذیری و چگالی رابطه عکس و الاستیسیته رابطه مستقیم با سرعت دارند.
- روش اصلی تولید: پیزوالکتریک (بلور PZT، کوارتز، سولفات لیتیوم، تیتانات باریم)؛ مگنتواستترکسیون برای فیزیوتراپی و سوتک گالتون صرفاً نمایشی است.
- اجزای پروب: جعبه، بلور، الکترودها، لایه جفت‌کننده (تطبیق امپدانس بلور و بافت؛ رزین اپوکسی + پودر تنگستن)، لایه میراکننده.
- امپدانس صوتی: $Z = \rho C$ با واحد Rayls؛ بازتاب عضله/هوا $\approx 99.9\%$ و چربی/کلیه $\approx 1.4\%$.
- اساس تصویر سونوگرافی بازتابش است، نه عبور؛ میزان آن به اختلاف امپدانس و عمود بودن زاویه تابش بستگی دارد.
- حالت‌ها: A (دامنه، چشم)، B (روشنایی، دو بعدی)، M (حرکت درِیچه قلب، 3.5 تا 4.5 MHz) و D (داپلر).
- داپلر: $F_v < F_t$ ؛ $F_d = F_v - F_t$ ؛ $F_v > F_t$ نزدیک‌شونده؛ کاربرد در تشخیص استنوز و صدای قلب جنین.



فصل ۸

رادیوبیولوژی و اثرات زیستی پرتوها

دکتر لیلی درویش

صفحه‌های ۹۳ تا ۱۱۲

۱۲

جدول

۱۰

شکل

۹۵

بخش

۱. رادیوبیولوژی و هدف آن

رادیوبیولوژی شاخه‌ای از دانش است که هدف آن «توصیف ماهیت فعل‌وانفعالات و عواقب آن، زمانی که ماکرومولکول‌ها، سلول‌ها، بافت‌ها و کل بدن در معرض تشعشعات یونیزان قرار می‌گیرند» است.

منبع: اسلایدهای رادیوبیولوژی دکتر درویش ص ۴

- موضوع مطالعه رادیوبیولوژی: اثر پرتوهای یونیزان بر ماکرومولکول‌ها، سلول‌ها، بافت‌ها و کل بدن.
- هدف کاربردی: شناخت مکانیسم آسیب برای پیش‌گیری از اثرات قطعی و کاهش اثرات تصادفی (همین دو هدف، مبنای «حفاظت در برابر تشعشع» است).

منبع: اسلایدهای رادیوبیولوژی دکتر درویش ص ۴ و ص ۱۳

۲. انواع پرتو (یادآوری از دیدگاه بیولوژیکی)

- پرتوهای الکترومغناطیس: گاما و ایکس (یونیزان)؛ فرابنفش، نور مرئی، مادون قرمز، میکروویو، رادیو و برق شهری (AC Power) (غیریونیزان).
- پرتوهای ذره‌ای (یونیزان): آلفا، بتا، الکترون، نوترون، پروتون، مزون، پیون و یون‌های سنگین.

منبع: اسلایدهای رادیوبیولوژی دکتر درویش ص ۳

در امتحان می‌آید

۳. اثرات احتمالی (تصادفی) و اثرات غیراحتمالی (قطعی)

اثرات پرتو بر بدن به دو دسته کلی تقسیم می‌شود. تفاوت این دو دسته در «چگونگی رابطه شدت آسیب با دوز» و «وجود یا نبود دوز آستانه» است.

منبع: اسلایدهای رادیوبیولوژی دکتر درویش ص ۵ و ص ۶

- **اثرات احتمالی (تصادفی) – Stochastic (Random) Effects:** به صورت اتفاقی رخ می‌دهند؛ هم در سلول‌های در معرض مستقیم پرتو و هم در سلول‌های مواجه‌نشده با پرتو دیده می‌شوند؛ احتمال وقوع با افزایش دوز افزایش می‌یابد، اما شدت اثر مستقل از دوز است.

- **اثرات غیراحتمالی یا قطعی – Non-stochastic (Deterministic) Effects:** قبل از وقوع باید از حداقل دوز معینی (دوز آستانه) تجاوز کند؛ با افزایش دوز، شدت اثر (آسیب) افزایش می‌یابد؛ رابطه مستقیم و واضحی بین مواجهه و وقوع آسیب وجود دارد.

منبع: اسلایدهای رادیوبیولوژی دکتر درویش ص ۵ و ص ۶

Stochastic (Random) Effects

اثرات احتمالی (تصادفی)

شکل - هم در سلول های در معرض مستقیم پرتو و هم در سلول های مواجه نشده

اسلایدهای رادیوبیولوژی - دکتر درویش - ص ۵

دسته بندی زودرس و دیررس (از ویدیو)

- اثرات احتمالی مانند انواع سرطان ها، آب مروارید چشم و اثرات ژنتیکی، بیشتر اثرات دیررس هستند.
- اثرات خطی یا غیراحتمالی (قطعی) اکثراً زودرس اند: اریتم پوستی، سوختگی و سندروم حاد پرتوی.
- استثنا: آب مروارید اثری قطعی است که به صورت دیررس اتفاق می افتد.

منبع: ویدیو - دکتر درویش، رادیوبیولوژی ۲ (فایل ۰۶) - ۰۰:۰۰ تا ۰۰:۳۱

نکته امتحانی: نکته پرتکرار: جدول «زودرس/دیررس» را با استثنای آب مروارید (اثر قطعی دیررس) به خاطر بسپارید - اثرات تصادفی دیررس و اثرات قطعی زودرس اند.

ویژگی	اثرات تصادفی (احتمالی)	اثرات قطعی (غیراحتمالی)
دوز آستانه	ندارد	دارد (باید از آن تجاوز شود)
رابطه دوز و احتمال	احتمال وقوع با دوز افزایش می یابد	رابطه مستقیم بین مواجهه و وقوع
رابطه دوز و شدت	شدت مستقل از دوز است	شدت با افزایش دوز افزایش می یابد
نمونه ها	لوسمی، تومورهای بدخیم، عقب ماندگی ذهنی، اثرات ژنتیکی	آب مروارید (کاتاراکت)، اریتم پوستی، اختلال باروری، اثرات حاد
هدف حفاظت پرتوی	کاهش دادن	پیش گیری کردن

منبع: اسلایدهای رادیوبیولوژی دکتر درویش ص ۸ تا ص ۱۳

۴. پاسخ خطی بدون آستانه و پاسخ آستانه ای غیرخطی

- **پاسخ خطی بدون آستانه (Linear No Threshold – LNT):** برای اثرات احتمالی (تصادفی) کاربرد دارد؛ فرض می کند هر مقدار تشعشع اثر مضر دارد (بنابراین با محور دوز رابطه خطی از مبدأ آغاز می شود).
- **پاسخ آستانه ای غیرخطی (Nonlinear Threshold Response):** برای اثرات غیراحتمالی یا قطعی (غیرتصادفی) اعمال می شود؛ تا رسیدن به «دوز آستانه» احتمال اثر صفر است.

دسته اثر	نمونه‌ها
اثرات احتمالی (تصادفی)	سرطان (لوسمی/سرطان خون، سرطان استخوان، سرطان ریه)، عقب‌ماندگی ذهنی، اثرات ژنتیکی
اثرات غیراحتمالی (قطعی)	آب مروارید، اریتم پوستی، اختلال در باروری، اثرات حاد (سندروم‌های پرتوی)

منبع: اسلایدهای رادیوبیولوژی دکتر درویش ص ۱۰ و ۱۱

۵. سندروم‌های حاد پرتوی (اثرات قطعی حاد)

سندروم	بازه دوز	یافته‌ها و پیامد
پرودرومال (مقدماتی) – Prodromal Syndrome	0-2.5 Gy	تهوع، استفراغ و سردرد
خون‌ساز – Hematopoietic Syndrome	2.5-5 Gy	کاهش گلبول‌های خونی، التهاب و خونریزی؛ مرگ طی دو ماه تا چند هفته
گوارشی – GI Syndrome	5-12 Gy	از بین رفتن پرزهای روده، کاهش جذب و اسهال خونی؛ مرگ طی چند روز
سیستم عصبی مرکزی – CNS Syndrome	بیش از ۱۰۰ Gy	افزایش فشار مغزی و مرگ طی 24 تا 48 ساعت

منبع: اسلایدهای رادیوبیولوژی دکتر درویش ص ۱۱

نکته کلیدی: دوزهای سندروم‌های حاد پرتوی در منبع صریحاً ذکر شده است: پرودرومال 0-2.5 Gy، خون‌ساز 2.5-5 Gy، گوارشی 5-12 Gy و سیستم عصبی مرکزی بیش از 100 Gy.

- نمونه واقعی و تاریخی اثرات قطعی (غیرتصادفی): حادثه چرنوبیل؛ در گزارش‌های آن دیده می‌شود که هرچه دوز کارکنان بیشتر بوده، عوارض شدیدتری (سوختگی و سندروم حاد پرتوی) بروز کرده است – یعنی شدت آسیب با دوز تغییر می‌کند.
- زمان شروع علائم: در دوز حدود ۱ تا ۲ Gy علائم مقدماتی به صورت تهوع و استفراغ بروز می‌کند و همین علائم، مبنای جدول‌بندی سندروم‌های حاد پرتوی در بخش بعد است.
- برخلاف آن، اثرات تصادفی (سرطان‌ها و اثرات ژنتیکی) در دوزهای کم هم ممکن است رخ دهند و شدت آن‌ها به دوز وابسته نیست؛ تنها احتمال وقوع با افزایش دوز بالا می‌رود.

منبع: منبع: ویدیو – دکتر درویش، رادیوبیولوژی ۱ (فایل ۰۴) – ۰۴:۵۷ تا ۰۶:۲۷

۶. انتقال انرژی خطی (LET)

LET یا «انتقال انرژی خطی» مقدار انرژی واگذارشده در واحد طول مسیر است؛ واحد آن keV/micron است. هرچه LET بالاتر باشد، پرتو آسیب‌رسان‌تر است.

منبع: اسلایدهای رادیوبیولوژی دکتر درویش ص ۱۴ و ۱۷

$$LET = \frac{\Delta E}{\Delta x}$$

تعریف انتقال انرژی خطی

ΔE : انرژی واگذارشده به محیط (keV)

Δx : طول مسیر (micron)

واحد LET: keV/micron

منبع: اسلایدهای رادیوبیولوژی دکتر درویش ص ۱۷

پرتو	LET در آب (keV/micron)
اشعه ایکس و گاما	کمتر از 3.5
الکترون ها (بتا)	کمتر از 3.5
آلفا	حدود 175
نوترون گرمایی	حدود 5
نوترون 0.01 MeV	بیش از 53
نوترون 0.1 MeV	بیش از 175

منبع: اسلایدهای رادیوبیولوژی دکتر درویش ص ۱۸

- پرتوهای ایکس و گاما پرتوهایی با LET کم هستند.
- آلفا و نوترون های سریع پرتوهایی با LET بالا هستند.
- LET به طور مستقیم با یونیزاسیون و در نتیجه با آسیب بیولوژیکی مرتبط است.

منبع: اسلایدهای رادیوبیولوژی دکتر درویش ص ۱۹

۷. اثر بیولوژیکی نسبی (RBE)

RBE یعنی «اثر بیولوژیکی نسبی»؛ LET بالا به RBE بالا می انجامد. تعریف دقیق آن در منبع چنین است: دوز پرتو ایکس 250 keV برای ایجاد یک اثر بیولوژیکی مشابه، تقسیم بر دوز تابش آزمایش شده (تابش دیگر) برای ایجاد همان اثر.

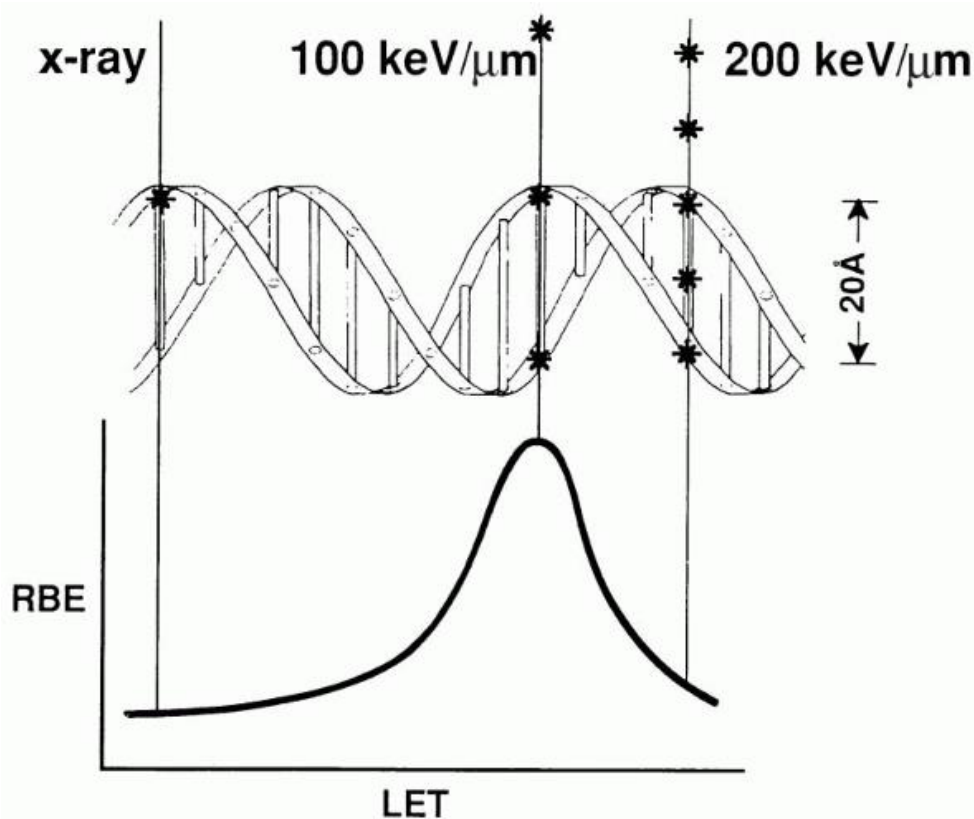
منبع: اسلایدهای رادیوبیولوژی دکتر درویش ص ۲۲

$$RBE = \frac{D_{250 \text{ keV x-ray}}}{D_{\text{test radiation}}}$$

تعریف RBE

صورت: دوز پرتو ایکس 250 keV که اثر بیولوژیکی مشخصی ایجاد می‌کند
مخرج: دوز تابش آزمایشی که همان اثر را ایجاد می‌کند
نکته منبع: اثر بیولوژیکی (نقطه پایانی) ثابت است، دوزها ثابت نیستند

منبع: اسلایدهای رادیوبیولوژی دکتر درویش ص ۲۲



شکل منبع ۲ - منحنی RBE برحسب LET در کنار ساختار مسیر (track structure) پرتو نسبت به مارپیچ DNA: با افزایش LET تا یک قله، RBE بالا می‌رود و سپس کاهش می‌یابد.

اسلایدهای رادیوبیولوژی دکتر درویش ص ۵۱

در امتحان می‌آید

۸. برهم‌کنش مستقیم پرتو

در برهم‌کنش (اقدام) مستقیم، تابش مستقیماً با یک مولکول از طریق تحریک یا یونیزاسیون تعامل دارد؛ مولکول تجزیه می‌شود و تأثیر آن بستگی به این دارد که کدام مولکول تحت تأثیر قرار گرفته است. مثال کلاسیک آن، تعامل مستقیم با DNA است.

منبع: اسلایدهای رادیوبیولوژی دکتر درویش ص ۱۵ و ص ۱۶

• انرژی تشعشع مستقیماً در هدف حیاتی رسوب می‌کند و منجر به تحریک یا یونیزاسیون می‌شود.

- یک واکنش زنجیره‌ای آغاز می‌شود که ممکن است برای سلول کشنده باشد یا نباشد (مثلاً ممکن است ترمیم شود).
- به احتمال زیاد با تشعشعات LET بالا مانند ذرات باردار یا نوترون‌ها رخ می‌دهد.

منبع: اسلایدهای رادیوبیولوژی دکتر درویش ص ۲۲ و ص ۲۴

۹. برهم‌کنش غیرمستقیم و هیدرولیز آب

در امتحان می‌آید

بدن عمدتاً از آب تشکیل شده است و بیشترین تأثیر مستقیم روی آب خواهد بود؛ این منجر به هیدرولیز آب می‌شود. برهم‌کنش غیرمستقیم شامل «تجزیه پرتوی آب» است و شایع‌ترین اثر است، زیرا سلول در درجه اول آب است. برای نمونه، در منبع آمده است که برای هر مولکول DNA حدود 1.2×10^7 مولکول آب وجود دارد.

منبع: اسلایدهای رادیوبیولوژی دکتر درویش ص ۱۶ تا ص ۱۸

- تابش یک مولکول آب را یونیزه می‌کند.
- یون با یک مولکول آب دیگر واکنش می‌دهد تا رادیکال هیدروکسیل بسیار واکنش‌پذیر ($\text{OH}^\bullet$) تشکیل شود.
- مایعات طبیعی بدن حاوی یون‌های H^+ و OH^- هستند؛ اما رادیکال‌های آزاد $\text{H}^\bullet$ و $\text{OH}^\bullet$ نگران‌کننده‌اند.
- در پایان، رادیکال‌های آزاد ($\text{H}^\bullet$ ، $\text{OH}^\bullet$) و H_2O_2 برای سلول سمی هستند.
- در صورت وجود اکسیژن حل‌شده (O_2)، مسیر واکنش‌ها می‌تواند به تشکیل $\text{H}_2\text{O}_2^\bullet$ و در ادامه H_2O_2 و O_2 بیانجامد.

منبع: اسلایدهای رادیوبیولوژی دکتر درویش ص ۱۹ تا ص ۲۲

نسبت برهم‌کنش مستقیم به غیرمستقیم بر حسب LET (از ویدیو)

نوع پرتو	سهم برهم‌کنش غیرمستقیم	سهم برهم‌کنش مستقیم
پرتوهای کم LET (اشعه ایکس و گاما)	دوسوم	یک‌سوم
پرتوهای پر LET	یک‌سوم	دوسوم
نوترون	دوسوم (مانند پرتوهای کم LET)	یک‌سوم

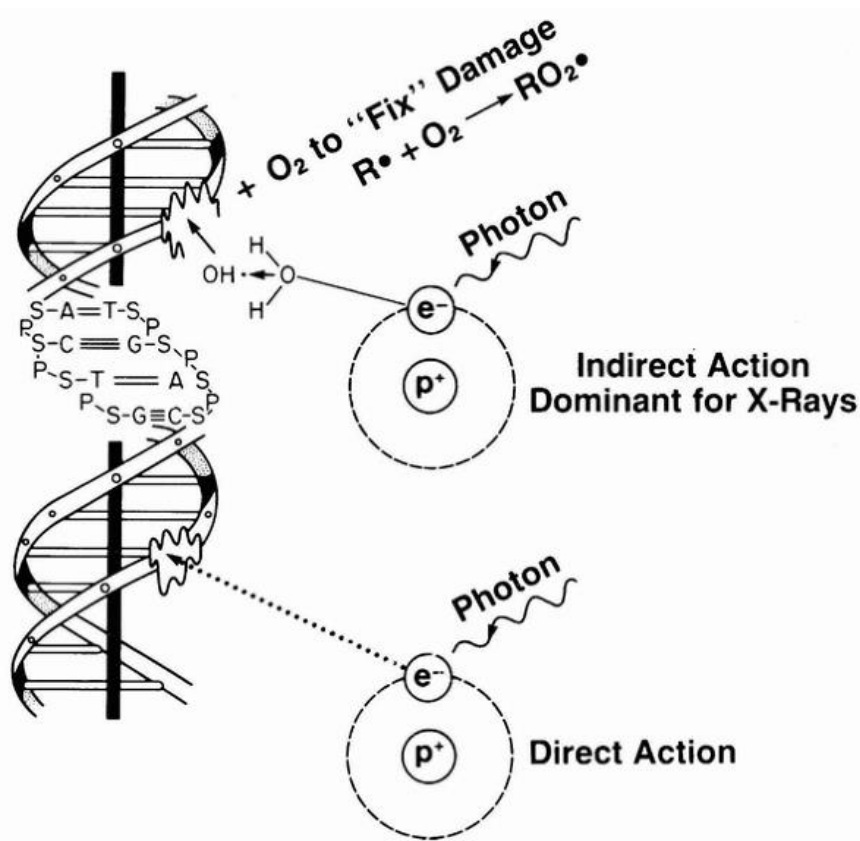
منبع: منبع: ویدیو - دکتر درویش، رادیوبیولوژی ۲ (فایل ۰۶) - ۰۰:۴۳ تا ۰۱:۲۹

- برای پرتوهای کم LET (ایکس و گاما) حدود دوسوم آسیب از مسیر غیرمستقیم و یک‌سوم از مسیر مستقیم رخ می‌دهد.
- برای پرتوهای پر LET این نسبت برعکس است: دوسوم مستقیم و یک‌سوم غیرمستقیم.
- نوترون خودش ذره (پر LET) است، اما اثر آسایش مانند پرتوهای کم LET است: دوسوم غیرمستقیم و یک‌سوم مستقیم.

منبع: منبع: ویدیو - دکتر درویش، رادیوبیولوژی ۲ (فایل ۰۶) - ۰۰:۴۳ تا ۰۱:۳۸

مرحله زنجیره رویدادها (برهم‌کنش غیرمستقیم)	عمر (زمان مشخصه)
فوتون ایکس فرودی	—
الکترون سریع، e^-	10^{-15} s
یون رادیکال	10^{-10} s
رادیکال آزاد	10^{-5} s
تغییرات شیمیایی منجر به شکستن پیوندها	—
اثرات بیولوژیکی و پیامدهای سلولی	—

منبع: اسلایدهای رادیوبیولوژی دکتر درویش ص ۲۳



شکل منبع ۳ - برهم‌کنش مستقیم و غیرمستقیم: در مسیر غیرمستقیم، فوتون با آب برهم‌کنش می‌کند و رادیکال هیدروکسیل به DNA آسیب می‌زند؛ در مسیر مستقیم، فوتون مستقیماً به DNA آسیب می‌زند. برهم‌کنش غیرمستقیم برای پرتوهای ایکس غالب است.

اسلایدهای رادیوبیولوژی دکتر درویش ص ۲۳

نکته کلیدی: خلاصه تفاوت دو مسیر: در برهم‌کنش مستقیم، هدف حیاتی خود مولکول (مثلاً DNA) است؛ در برهم‌کنش غیرمستقیم، ابتدا آب یونیزه می‌شود و رادیکال‌های آزاد به وجود آمده به مولکول حیاتی حمله می‌کنند. سهم مسیر غیرمستقیم در پرتوهای کم LET (ایکس و گاما) غالب است.

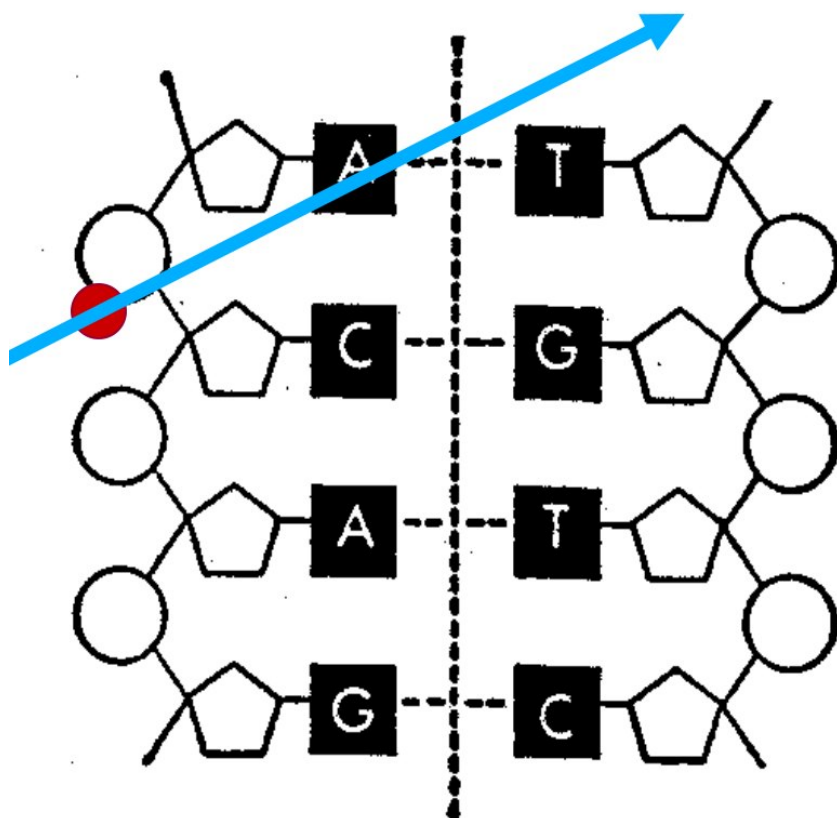
۱۰. آسیب DNA و اهداف سلولی

آسیب به یک مولکول حیاتی، تأثیر قابل توجهی بر سلول می‌گذارد. مهم‌ترین محل در سلول، احتمالاً DNA در هسته است و هسته از همه اندامک‌ها مهم‌تر است.

منبع: اسلایدهای رادیوبیولوژی دکتر درویش ص ۲۵ و ص ۳۲

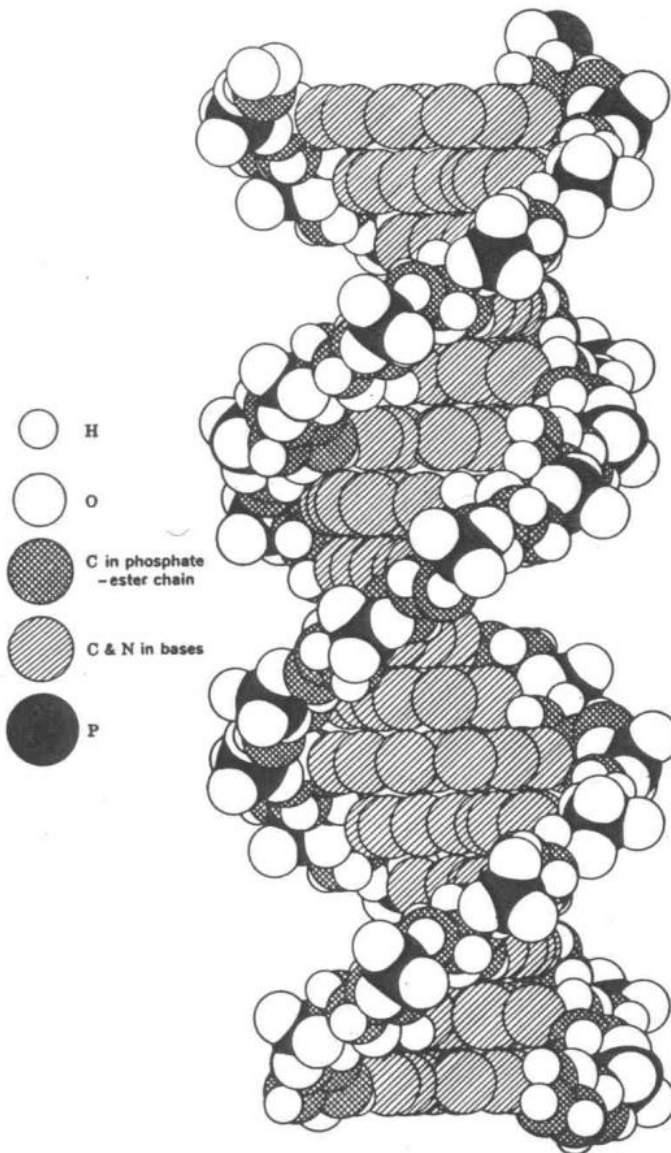
- بسیاری از آسیب‌های DNA ممکن است قابل ترمیم باشند.
- انواع آسیب: آسیب باز (base damage)، شکستگی تک‌رشته‌ای (single-strand break)، شکستگی دورشته‌ای (double-strand break) و اتصال عرضی (crosslinking).
- ساختار دولایه مارپیچ DNA حامل کد ژنتیکی سلول است؛ شکستن رشته توسط تشعشع به علاوه خطا در اتصال مجدد آن، ممکن است باعث تکثیر سلول در حالت اشتباه (سرطان) یا مرگ آن شود.

منبع: اسلایدهای رادیوبیولوژی دکتر درویش ص ۲۶ و ص ۳۳



شکل - پرتوهای یونیزه ممکن است مستقیماً

اسلایدهای رادیوبیولوژی - دکتر درویش - ص ۴۰



شکل - ساختار دورشته‌ای DNA به‌عنوان هدف اصلی آسیب پرتوی در سلول: حامل کد ژنتیکی و هدف حفاظت در برابر تشعشع.

اسلایدهای رادیوبیولوژی دکتر درویش ص ۳۷

دوره نهفته و انواع آسیب DNA (از ویدیو)

- اثرات تابش یک «دوره نهفته» (Latent period) نشان می‌دهند که در طی آن هیچ نشانه‌ای از آسیب دیده نمی‌شود.
- طول دوره نهفته از چند دقیقه تا چند سال متغیر است و به دوز و نوع سلول بستگی دارد.
- آزمایش‌های کلاسیک: با دادن دوز کم به سلول، هسته سلول سریعاً آسیب می‌بیند اما سیتوپلاسم مشکلی پیدا نمی‌کند → نتیجه: هسته سلول حساس‌ترین بخش است.
- چون کروموزوم از DNA ساخته شده است، DNA و کروموزوم (و بنابراین هسته) به پرتو حساس‌اند.
- انواع آسیب DNA: آسیب باز (base damage)، شکستگی تک‌رشته‌ای، شکستگی دورشته‌ای و اتصال عرضی (cross-link).

منبع: ویدیو - دکتر درویش، رادیوبیولوژی ۲ (فایل ۰۶) - ۱۲:۰۳ تا ۳۰:۰۴

سرنوشت سلول پس از پرتودهی (از ویدیو)

- ترمیم آسیب و بازگشت سلول به عملکرد طبیعی.

- مرگ سلولی.
- مهار تقسیم سلولی.
- غیرفعال سازی آنزیم‌ها.
- تغییر نفوذپذیری (غشا).
- بروز انحرافات کروموزومی.

منبع: منبع: ویدئو – دکتر درویش، رادیوبیولوژی ۲ (فایل ۰۶) – ۱۰:۳۸ تا ۲۰:۰۰

نوع آسیب (به ازای 1 Gy پرتو ایکس در یک سلول)	تعداد در سلول
آسیب باز (base damage)	1000 - 2000
اتصال‌های عرضی (crosslinks)	200 - 400
شکستگی تک‌ رشته‌ای (single-strand breaks)	حدود 1000
شکستگی دورشته‌ای (double-strand breaks)	حدود 40

منبع: اسلایدهای رادیوبیولوژی دکتر درویش ص ۴۶ (اسلاید «DNA damage produced in one cell by 1 Gy X-rays»)

- پرتوهای ایکس و گاما: شکستگی تک‌ رشته‌ای و شکستگی دورشته‌ای ساده ایجاد می‌کنند.
- ذرات آلفا: می‌توانند شکستگی دورشته‌ای پیچیده (complex dsb) تولید کنند.
- شکستگی‌های دورشته‌ای پیچیده سخت‌تر ترمیم می‌شوند.

منبع: اسلایدهای رادیوبیولوژی دکتر درویش ص ۴۷ تا ص ۵۰

در امتحان می‌آید

۱۱. آسیب کروموزومی

کروموزوم‌های آسیب‌دیده در میکروسکوپ نوری قابل مشاهده‌اند و «تشکیل حلقه» و «دی‌سانتریک» شاخص‌های مشخصه آسیب‌اند. در آسیب کروموزومی، قطعات شکسته ممکن است به‌درستی دوباره به هم بپیوندند، یا قطعه‌ای «از دست برود» (قطعه بدون سانترومر) و یا بازآرایی انتهای شکسته، حلقه‌ها و دی‌سانتریک‌ها را ایجاد کند.

منبع: اسلایدهای رادیوبیولوژی دکتر درویش ص ۲۷ تا ص ۳۰

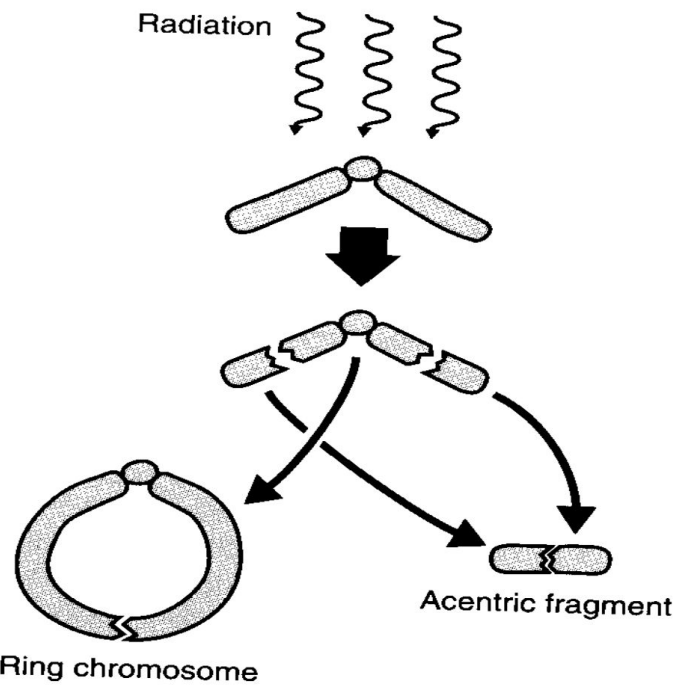
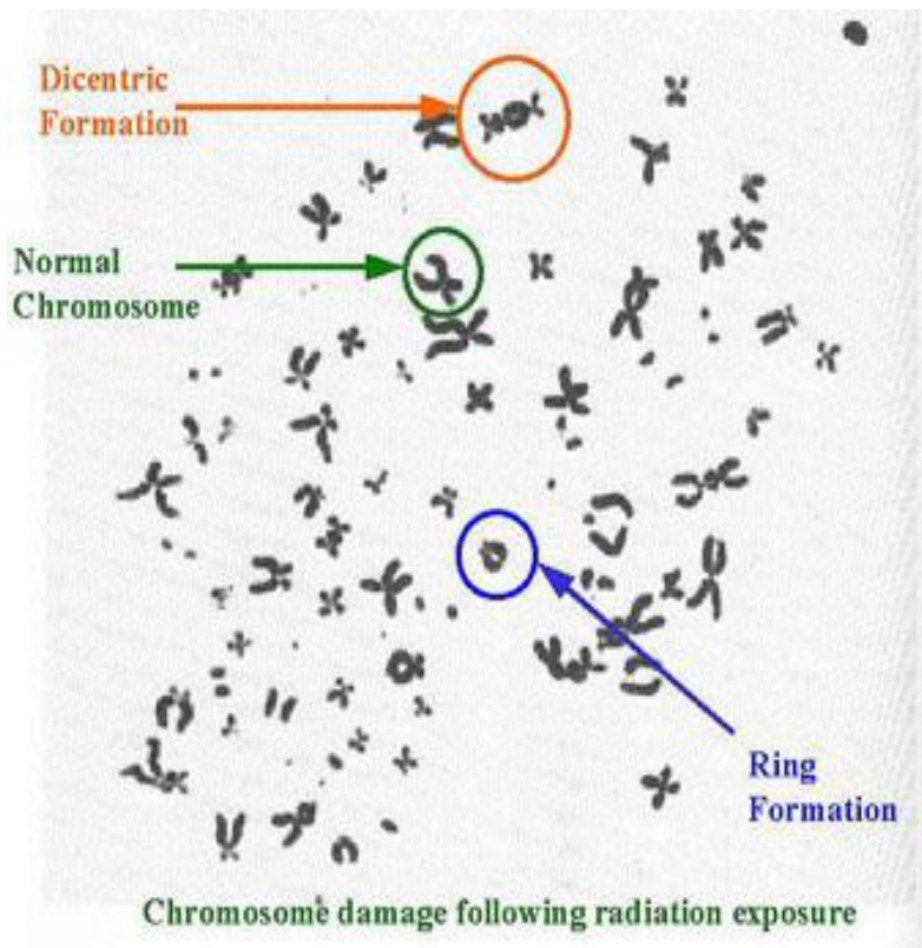


Figure 6–13 Formation of a ring chromosome.

شکل – تشکیل حلقه کروموزومی (Ring chromosome): شکست در دو انتهای کروموزوم و اتصال انتهاها که در میکروسکوپ نوری دیده می‌شود.

اسلایدهای رادیوبیولوژی دکتر درویش ص ۳۴



شکل - کروموزوم های آسیب دیده در میکروسکوپ نوری

اسلایدهای رادیوبیولوژی - دکتر درویش - ص ۳۸

- بازآرایی‌ها ممکن است قابل مشاهده نباشند، اما مواد ژنتیکی تحت تأثیر قرار گرفته و منجر به جهش (mutation) شده است.
- در نتیجه پرتوگیری، سلول می‌تواند مسیرهای متفاوتی را طی کند: ترمیم صحیح (سلول زنده)، ترمیم نادرست (جهش)، عدم ترمیم (مرگ سلولی) و در نهایت سرطان.

منبع: اسلایدهای رادیوبیولوژی دکتر درویش ص ۲۷ و ص ۴۴

دسته	نمونه‌ها	سرنوشت سلول
ناهنجاری‌های کشنده (Lethal)	دی‌سنتریک کروموزوم، کروموزوم حلقه‌ای، قطعه‌ی بی‌سانتروم (Acentric Fragment)، پل آنافازی / دی‌سنتریک کروماتید	سلول از بین می‌رود و پس از مدت معین از بدن حذف می‌شود (بر پایه‌ی عمر همان نوع سلول؛ مثال: لنفوسیت T حدود 1500 روز)
ناهنجاری‌های غیرکشنده (Non-lethal)	ترانسلوکاسیون، حذف (Deletion) و جابه‌جایی قطعات	سلول زنده می‌ماند؛ اگر ترمیم نادرست باشد به نسل بعد منتقل می‌شود و می‌تواند اثرات ژنتیکی و سرطان ایجاد کند

منبع: منبع: ویدیو - دکتر درویش، رادیوبیولوژی ۳ (فایل ۰۵) - ۱۱:۴۰ تا ۱۳:۲۰

۱۲. ناهنجاری‌های کروموزومی و کروماتیدی (زمان پرتوگیری در چرخه سلولی)

- ناهنجاری کروموزومی: پرتوگیری سلول در مراحل اولیه اینترفاز (G1) و قبل از دوپلیکاسیون کروموزوم رخ می‌دهد و شکست در کروموزوم تک‌رشته‌ای ایجاد می‌شود؛ در مرحله S دوپلیکیت می‌شود و این ناهنجاری در میتوز بعدی دیده می‌شود (مانند کروموزوم حلقه‌ای و کروموزوم دی‌سانتتیک).
- ناهنجاری کروماتیدی: اگر پرتوگیری در مراحل آخر اینترفاز (G2) و پس از دوپلیکاسیون کروموزوم باشد، کروموزوم دورشته‌ای حاوی دو رشته کروماتید بوده و شکست در رشته‌های کروماتیدها اتفاق می‌افتد؛ در این حالت سلول‌های حاصل در میتوز بعدی دارای ناهنجاری کروماتیدی خواهند بود (مانند پل آنافازی یا دی‌سانتتیک کروماتید).

منبع: اسلایدهای رادیوبیولوژی دکتر درویش ص ۷۴

تفصیل ناهنجاری‌های کروموزومی و کروماتیدی (از ویدیو)

- ناهنجاری کروموزومی: پرتوگیری سلول در مراحل اولیه اینترفاز (G1) و پیش از همانندسازی (پیش از S) رخ می‌دهد؛ در این حالت کروموزوم تک‌رشته‌ای است و شکست در کروموزوم تک‌رشته‌ای اتفاق می‌افتد.
- نمونه‌های ناهنجاری کروموزومی: کروموزوم حلقه‌ای و کروموزوم دی‌سانتتیک.
- ناهنجاری کروماتیدی: پرتوگیری در مراحل آخر اینترفاز و پس از همانندسازی (پس از S) رخ می‌دهد؛ کروموزوم دورشته‌ای (دو کروماتیدی) است و کروماتید می‌شکند.
- نمونه ناهنجاری کروماتیدی: پل آنافازی یا دی‌سانتتیک کروماتیدی.
- هر سه (کروموزوم حلقه‌ای، دی‌سانتتیک و دی‌سانتتیک کروماتیدی/پل آنافازی) جزو ناهنجاری‌های «کشنده» محسوب می‌شوند و بر اساس نوع و عمر سلول از بدن پاک می‌شوند.

منبع: منبع: ویدیو - دکتر درویش، رادیوبیولوژی ۳ (فایل ۵) - ۰۵:۰۰ تا ۰۱:۱۲

- اینترفاز شامل سه مرحله G1، S و G2 است: در G1 کروموزوم تک‌رشته‌ای، در S دورشته‌ای (همانندسازی) و در G2 دورشته‌ای با سانترومر.
- حساسیت چرخه سلولی: سلول در G2 و در میتوز (به‌ویژه متافاز) به اشعه حساس است؛ در میتوز، متافاز از آنافاز حساس‌تر است.
- مرحله S مرحله‌ای است که سلول در برابر پرتو مقاوم‌تر است.
- چک‌پوینت‌های ملکولی (ژن‌های بازرسی) مانند چراغ‌راهنما عمل می‌کنند: سلول را متوقف می‌کنند و کمپلکس‌های ترمیم‌کننده را فرا می‌خوانند؛ اگر کروموزوم ترمیم شد، اجازه عبور به مرحله بعد (میتوز) داده می‌شود. یکی از مهم‌ترین این چک‌پوینت‌ها در انتهای G2 قرار دارد؛ چک‌پوینت انتهای G1 و چک‌پوینت میتوز هم وجود دارند.

منبع: منبع: ویدیو - دکتر درویش، رادیوبیولوژی ۳ (فایل ۵) - ۰۱:۱۷ تا ۰۳:۲۳

- ژن‌های بازرسی (چک‌پوینت) مولکولی مانند یک «چراغ راهنما» عمل می‌کنند: اگر سلول نقص DNA داشته باشد، چرخه را متوقف می‌کنند.
- سپس جمع‌های ترمیم‌کننده را فرا می‌خوانند تا کروموزوم آسیب‌دیده ترمیم شود و تنها پس از ترمیم، اجازه عبور به مرحله بعد (میتوز) داده می‌شود.
- مهم‌ترین چک‌پوینت‌های منبع: انتهای G1/ابتدای S (کنترل پیش از همانندسازی)، M/G2 (کنترل پیش از میتوز) و چک‌پوینت میتوز (کنترل جدا شدن کروموزوم‌ها در آنافاز).

- حساسیت مراحل چرخه سلولی به پرتو (از ویدیو): سلول در G2 و در میتوز حساس است؛ در میتوز، مرحله متافاز از آنافاز حساس‌تر است.
- مقاوم‌ترین مرحله، مرحله S (هماندسازی DNA) است – سلول در این مرحله بیشترین مقاومت را در برابر پرتو دارد.
- دلیل تفاوت حساسیت: سلول‌هایی که در مراحل مختلف چرخه سلولی‌اند، «فاز» یکسانی ندارند؛ بنابراین هم‌زمان‌بودن در میتوز و G2، حساسیت را بالا می‌برد.

منبع: منبع: ویدیو – دکتر درویش، رادیوبیولوژی ۳ (فایل ۵) – ۰۱:۵۱ تا ۰۲:۳۰

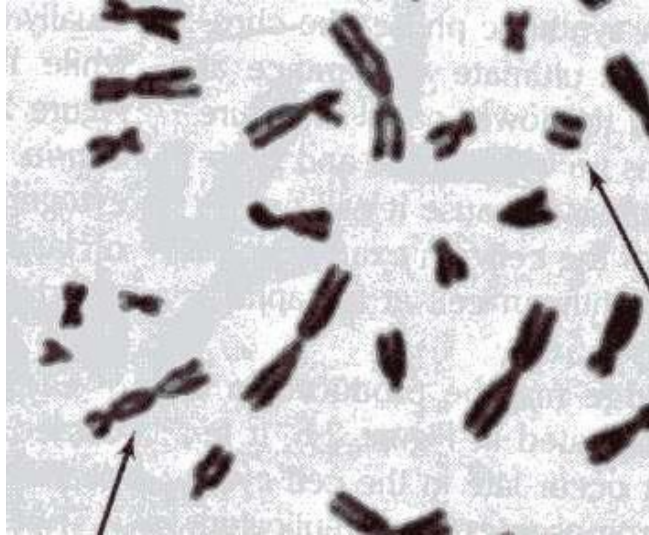
- سازوکار دی‌سنتریک: در G1 (پیش از S) دو کروموزوم تک‌رشته‌ای متفاوت وجود دارند؛ اشعه ایکس به آن‌ها می‌خورد و انتهای هر دو کروموزوم می‌شکند.
- انتهای شکسته چسبیده‌اند، به هم متصل می‌شوند و پس از همانندسازی (پس از مرحله S) نتیجه یک کروموزوم دی‌سنتریک و دو قطعه بدون سانترومر (Acentric fragment) است.

منبع: منبع: ویدیو – دکتر درویش، رادیوبیولوژی ۳ (فایل ۵) – ۰۳:۲۳ تا ۰۴:۴۴

نکته امتحانی: استاد در ویدیو صریحاً می‌گوید: «حتماً این را داشته باشید که من سؤال امتحان‌تان از این‌ها است» – یعنی تمایز ناهنجاری کروموزومی (پرتودهی در G1، پیش از S، کروموزوم تک‌رشته‌ای، حلقه‌ای/دی‌سنتریک) با ناهنجاری کروماتیدی (پس از S، شکست کروماتید، پل آنافازی) و کشنده‌بودن هر سه، از مباحث امتحانی است.

نوع شکست	نمونه‌ها	ویژگی
شکست کشنده کروموزومی	حلقه (Ring) و دی‌سنتریک (Dicentric) همراه با قطعات بدون سانترومر	کشنده برای سلول
شکست کشنده کروماتیدی	پل آنافازی (Anaphase bridge) همراه قطعات بدون سانترومر	کشنده برای سلول
شکست غیرکشنده	جاب‌جایی (Translocation) و حذف (Deletion)	زنده‌مانی سلول با جهش

منبع: اسلایدهای رادیوبیولوژی دکتر درویش ص ۷۵ تا ص ۷۸



شکل منبع ۵ - شکست کشنده کروموزومی: کروموزوم دی سانتریک به همراه قطعات بدون سانترومر (شاخص مشخصه آسیب پرتوی).

اسلایدهای رادیوبیولوژی دکتر درویش ص ۷۴

۱۳. اثر پرتو بر سایر اندامک‌ها، جهش‌زایی و سرطان‌زایی

- هسته مهم‌ترین اندامک هدف است؛ ولی نفوذپذیری غشای سلولی تغییر می‌کند و هر اندامک متصل به غشا مستعد تغییرات ناشی از تشعشع است (نشتی غشا).
- سرطان از ورود اطلاعات نادرست به DNA ناشی می‌شود؛ سرطان احتمال از بین رفتن کنترل داخلی یک سلول است و سلول‌ها بدون کنترل طبیعی تکثیر می‌شوند و عملکردشان تغییر می‌کند.
- اثرات تابش یک دوره نهفته (latent period) نشان می‌دهد که در طی آن هیچ شواهدی از آسیب وجود ندارد؛ این دوره ممکن است از چند دقیقه تا چند دهه طول بکشد (طول دوره به دوز و نوع سلول‌های درگیر بستگی دارد).

منبع: اسلایدهای رادیوبیولوژی دکتر درویش ص ۳۲ و ص ۴۱ و ص ۳۵

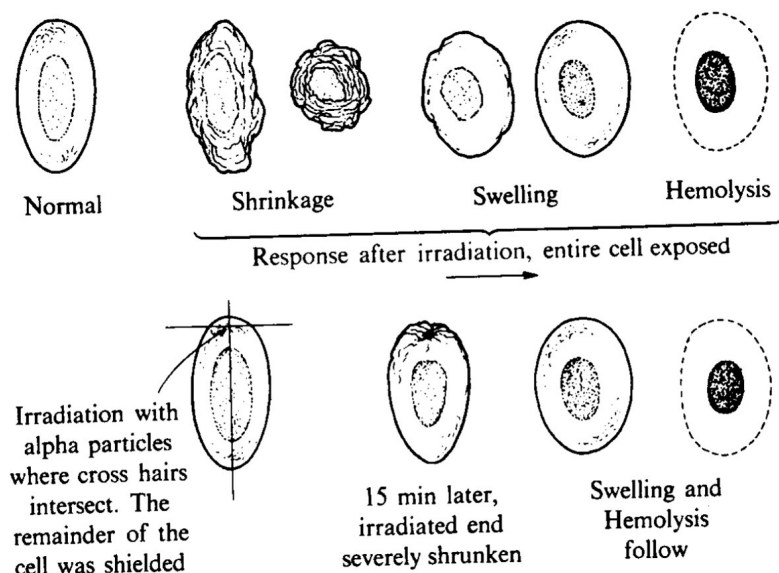


Figure 3.3. Total and partial cell irradiation of the large erythrocytes of *Amphiuma*. (After Buchsbaum and Zirkle, 1949.)

شکل - پاسخ سلول به پرتوتابی کامل و جزئی (اریتروسیت‌های بزرگ آمفیپوم): تورم، انقباض و در نهایت همولیز؛ اگر بخشی از سلول با حفاظ پوشیده شود، آسیب کمتر می‌شود.

اسلایدهای رادیوبیولوژی - دکتر درویش - ص ۳۶

۱۴. چرا پرتوهای یونیزان آسیب می‌زنند؟ (جمع‌بندی مفهوم آسیب)

- این «مقدار انرژی» نیست که پرتوهای یونیزان را مضر می‌کند.
- پرتوهای یونیزان مضر هستند زیرا کوانتوم‌های منفرد انرژی برای شکستن پیوندهای شیمیایی از طریق یونیزاسیون کافی‌اند.
- بسیاری از عوامل دیگر (مانند فرابنفش) هم به بیومولکول‌ها آسیب می‌زنند و پیوندها را می‌شکنند، ولی چون عمدتاً ترمیم می‌شوند آسیب ماندگار ندارند.

منبع: اسلایدهای رادیوبیولوژی دکتر درویش ص ۴۲ و ص ۴۳

$$LD_{50/30} = 4 \text{ Gy}$$

دوز کشنده ۵۰٪ (LD50/30)

LD50/30: دوزی که ۵۰٪ سلول‌ها را در ۳۰ روز از بین می‌برد؛ برابر 4 Gy

معادل: 280 J انرژی به یک شخص 70 kg

معادل: افزایش 1 milli-Celsius دمای بدن

معادل: نوشیدن 3 ml قهوه

نتیجه: مکانیسم آسیب پرتوی ناشی از گرما نیست، بلکه ناشی از یونیزاسیون است

منبع: اسلایدهای رادیوبیولوژی دکتر درویش ص ۶۴

نکته کلیدی: نکته مفهومی منبع: با $LD_{50/30} = 4 \text{ Gy}$ انرژی رسیده به بدن معادل تغییر دمای ناچیز است؛ بنابراین آسیب پرتوی از جنس گرمایی نیست و از راه یونیزاسیون رخ می‌دهد.

۱۵. قانون برگونیه و تریبوندو و حساسیت پرتوی سلول‌ها

بر پایه قانون برگونیه و تریبوندو (1906)، سلول‌ها در صورتی که دارای سه ویژگی باشند به پرتو حساس می‌شوند: نرخ تقسیم بالا، آینده تقسیم طولانی و تمایزنیافتگی.

منبع: اسلایدهای رادیوبیولوژی دکتر درویش ص ۶۵

- سلول‌ها سرعت تقسیم بالایی دارند.
- سلول‌ها طول تقسیم طولانی دارند.
- سلول‌ها از نوع تمایزنیافته‌اند.

منبع: اسلایدهای رادیوبیولوژی دکتر درویش ص ۶۵

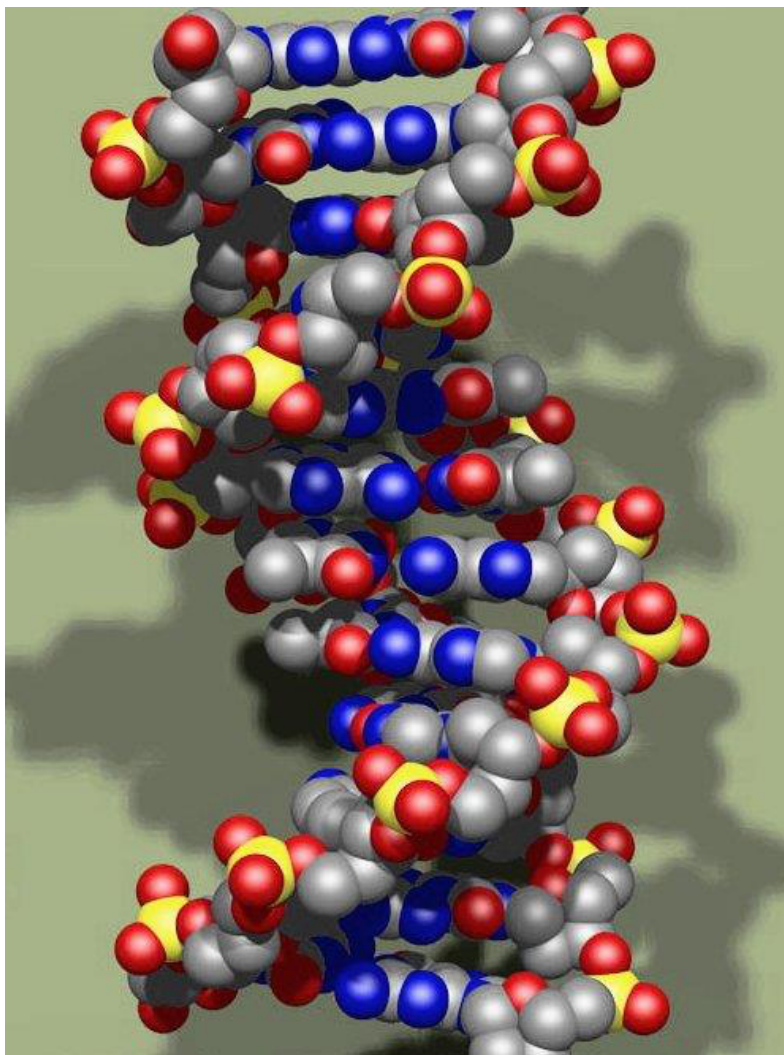
حساسیت پرتوی نسبی	نمونه سلول‌ها
کم	سلول‌های خونی بالغ، سلول‌های ماهیچه‌ای، سلول‌های گانگلیونی، بافت‌های همبند بالغ
بالا	مخاط معده، غشاهای مخاطی، اپیتلیوم مری، اپیتلیوم مثانه
بسیار زیاد	سلول‌های خونی اولیه، اپیتلیوم روده، اسپرماتوگونی، سلول‌های فولیکولی تخمدان، لنفوسیت‌ها

منبع: اسلایدهای رادیوبیولوژی دکتر درویش ص ۶۶

۱۶. اندازه‌گیری آسیب پرتوی و منحنی بقای سلول

برای اندازه‌گیری آسیب، سلول‌های کشت‌شده را در معرض افزایش دوز تابش قرار می‌دهند و تعداد «سلول‌های زنده‌مانده» را اندازه‌گیری می‌کنند (کسر بقا). مشاهدات منبع: اشعه ایکس نسبتاً مؤثر است و اثر آن با دوز «خطی-منحنی» (خمیده) است؛ ذرات آلفا بسیار مؤثرند و اثر خطی با دوز دارند.

منبع: اسلایدهای رادیوبیولوژی دکتر درویش ص ۴۶ و ص ۵۲



شکل منبع ۶ – مقایسه منحنی بقای سلولی برای پرتوهای ایکس (اثر خمیده با دوز) و ذرات آلفا (اثر خطی با دوز).

اسلایدهای رادیوبیولوژی دکتر درویش ص ۵۲

۱۷. سیستم و اصول حفاظت در برابر تشعشع

حفاظت در برابر تشعشع (RP) ابزاری برای مدیریت اقدامات حفاظت از سلامت در برابر خطرات ناشی از استفاده از پرتوهای یونیزان (برای افراد و محیط زیست) است. همیشه باید مزایا در مقابل خطرات در نظر گرفته شود.

منبع: اسلایدهای رادیوبیولوژی دکتر درویش ص ۱۲

- اثرات غیراحتمالی (قطعی): هدف حفاظت پرتوی، پیش‌گیری از آن‌هاست.
- اثرات احتمالی (تصادفی): هدف حفاظت پرتوی، کاهش آن‌هاست.
- ICRP: توصیه‌ها و پیشنهادهایی را ارائه می‌کند.
- IAEA: استانداردهای ایمنی را ایجاد می‌کند و اجرای استانداردها را فراهم می‌کند.
- UNSCEAR: اثرات تشعشعات اتمی را مطالعه می‌کند.

منبع: اسلایدهای رادیوبیولوژی دکتر درویش ص ۱۳ و ص ۷۷

اصل سیستم حفاظت	معنا در منبع
توجیه‌پذیری اقدام (Justification)	هرگونه قرار گرفتن در معرض پرتو باید فواید و سود کافی برای جبران آسیب پرتوی داشته باشد؛ اگر مواجهه هیچ منفعتی نداشته باشد، موجه نیست.
بهینه‌سازی حفاظت (Optimization)	دوزها باید «تا حد امکان کم باشد» (ALARA)؛ عوامل اقتصادی و اجتماعی در نظر گرفته می‌شوند؛ تا حدی دوز را کم می‌کنیم که منطقی و در دسترس باشد (کیفیت تصویر تخریب نشود).
محدودیت دوز (Limitation of doses)	حد دوز برای پرتوکار 50 mSv در سال؛ حد دوز برای افراد دیگر (حد دوز عمومی) 1 mSv در سال؛ حد دوز نباید برای مواجهه‌های پزشکی (بیماران) ناشی از اقدامات مجاز اعمال شود.

منبع: اسلایدهای رادیوبیولوژی دکتر درویش ص ۷۸ تا ص ۸۲

- کاهش زمان در معرض قرارگیری پرتو.
- افزایش فاصله از منبع پرتوزا.
- استفاده از حفاظ پرتوی مانند سرب، بتون، آلومینیوم و ...

منبع: اسلایدهای رادیوبیولوژی دکتر درویش ص ۸۱

نکته کلیدی: سه اصل سیستم حفاظت پرتوی: توجیه‌پذیری اقدام، بهینه‌سازی حفاظت (ALARA) و محدودیت دوز. این اصول مکمل سه راهکار عملی «زمان، فاصله و حفاظ» هستند.

نکته امتحانی: دکتر درویش در فهرست مباحث امتحانی، «اثرات تصادفی و غیرتصادفی» و «برهم‌کنش مستقیم و غیرمستقیم و آسیب بیولوژیک در کروموزوم» را مشخص کرده‌اند؛ این سه بخش (۸ تا ۱۲ همین فصل) مهم‌ترین بخش‌های این فصل برای امتحان‌اند.

۱۸. رابطه با درس فیزیک تشعشع: تعریف دوز و یکاها

برای فهم کمی اثرات بیولوژیکی، باید کمیت‌های دوزیمتری را شناخت. در منبع تشعشع (دکتر حق‌پرست) این کمیت‌ها و روابط آن‌ها به تفصیل آمده است؛ خلاصه آن‌ها در فصل ۵ همین جزوه و به‌طور فشرده در جدول زیر آمده است.

منبع: جزوه فیزیک تشعشع و پزشکی هسته‌ای – فصل ۱۱

کمیت	واحد	توضیح کوتاه
اکتیویته (Activity)	Becquerel (Bq)	تعداد واپاشی در ثانیه؛ $1 \text{ Bq} = 1 \text{ dps}$
دوز جذبی (Absorbed Dose)	Gray (Gy)	انرژی جذب‌شده در واحد جرم؛ $1 \text{ Gy} = 1 \text{ J/kg}$
دوز معادل (Equivalent Dose)	Sievert (Sv)	دوز جذبی ضرب در ضریب وزن‌دهی پرتو (WR)
اکسپوزر (Exposure)	Roentgen (R)	توان یونیزاسیون هوا

منبع: جزوه فیزیک تشعشع و پزشکی هسته‌ای – فصل ۱۱؛ اسلایدهای حق‌پرست

نکته امتحانی: جمع‌بندی تأکیدی استاد در ویدیو: آنچه برای حفاظت مهم است، «شکستگی‌های غیرکشنده» است؛ چون این‌ها از بدن حذف نمی‌شوند و در صورت ترمیم نادرست، به نسل بعد منتقل شده و می‌توانند سرطان‌زا و جهش‌زا باشند.

مرور سریع

- اثرات تصادفی: بدون آستانه، احتمال با دوز بالا می‌رود، شدت مستقل از دوز (لوسمی، تومور بدخیم)؛ اثرات قطعی: با آستانه، شدت با دوز بالا می‌رود (کاتاراکت، اریتم، اختلال باروری).
- LNT برای اثرات تصادفی و «آستانه‌ای غیرخطی» برای اثرات قطعی.
- $LET =$ انرژی واگذارشده در واحد طول مسیر (keV/micron)؛ آلفا و نوترون سریع: LET بالا؛ ایکس و گاما: LET کم.
- $RBE =$ دوز ایکس 250 keV ÷ دوز پرتو آزمایشی برای همان اثر؛ LET بالا $\rightarrow$ RBE بالا.
- برهم‌کنش مستقیم: یونیزاسیون خود مولکول هدف (مثلاً DNA)؛ غالب در LET بالا. برهم‌کنش غیرمستقیم: هیدرولیز آب و رادیکال‌های آزاد؛ غالب در ایکس و گاما.
- زنجیره زمانی: الکترون سریع 10^{-15} s $\rightarrow$ یون رادیکال 10^{-10} s $\rightarrow$ رادیکال آزاد 10^{-5} s.
- آسیب DNA در 1 Gy: ایکس: آسیب باز 1000-2000، اتصال عرضی 200-400، شکستگی تکرشته‌ای حدود 1000، دورشته‌ای حدود 40.
- شاخص‌های آسیب کروموزومی: حلقه، دی‌سانتریک و قطعات بدون سانترومر؛ ناهنجاری کروموزومی (پرتوگیری در G1) در برابر ناهنجاری کروماتیدی (پرتوگیری در G2، پل آنافازی).
- $LD50/30 = 4$ Gy؛ مکانیسم آسیب، یونیزاسیون است نه گرما.
- قانون برگونیه و تریبونو: تقسیم سریع، آینده تقسیم طولانی، تمایزنیافتگی.
- حفاظت: توجیه‌پذیری، بهینه‌سازی (ALARA)، محدودیت دوز (پرتوکار 50 mSv، عمومی 1 mSv).

فصل ۹ از ۹



فصل ۹

تصویربرداری تشدید مغناطیسی (MRI)

دکتر لیلی درویش

صفحه‌های ۱۱۴ تا ۱۳۰

۸

جدول

۱۵

شکل

۷۷

بخش

۱. انرژی‌های به‌کاررفته در MRI

• میدان مغناطیسی (Magnetic Field)

• امواج رادیویی (Radio Waves)

منبع: اسلایدهای MRI دکتر درویش اسلاید ۳

در MRI چون انرژی امواج رادیویی که به سمت بیمار فرستاده می‌شود بسیار کم و غیر یونیزان است، نمی‌تواند یونیزه کند؛ همچنین میدان مغناطیسی تأثیر بدی روی بدن بیمار ندارد. پس قاعداً MRI ضرر ندارد و ایمن‌تر از CT است.

منبع: اسلایدهای MRI دکتر درویش اسلاید ۲۶

نکته کلیدی: MRI بر دو پایه استوار است: میدان مغناطیسی قوی و امواج رادیویی (RF). هیچ‌کدام یونیزان نیستند؛ همین نکته مزیت اصلی ایمنی MRI نسبت به CT است.

۲. خواص هسته‌ای لازم برای تصویربرداری (اسپین هسته)

- اگر عدد جرمی (A) و عدد اتمی (Z) هسته، فرد باشد (یعنی پروتون جفت‌نشده داشته باشد)، اسپین هسته (I) مضربی از $1/2$ خواهد بود: $1/2, 3/2, 5/2, \dots$ ؛ نمونه‌ها: $H-1$ ، $Na-23$ ، $Al-27$.
- اگر عدد جرمی و عدد اتمی هسته هر دو زوج باشند (همه پروتون‌ها جفت‌شده‌اند)، اسپین هسته صفر است ($I = 0$)؛ این هسته‌ها خاصیت مغناطیسی خالص نداشته و در تصویربرداری تشدید مغناطیسی کاربرد ندارند.
- در هسته‌هایی که عدد اتمی فرد و عدد جرمی زوج دارند (پروتون جفت‌نشده)، اسپین هسته عدد صحیحی است (۱، ۲، ۳، ۴ و ...): $H-2$ ، $N-14$.

منبع: اسلایدهای MRI دکتر درویش اسلاید ۳ و ۴

۳. پروتون‌ها در میدان مغناطیسی

- اگر پروتون در میدان مغناطیسی قرار گیرد، می‌چرخد و هم‌جهت میدان قرار می‌گیرد، اما همه پروتون‌ها هم‌جهت نمی‌شوند.
- پروتون‌ها دو حالت می‌گیرند: در جهت میدان Spin up (انرژی کم) و در خلاف جهت میدان Spin down (انرژی زیاد).
- اکثر هسته‌ها در جهت میدان (سطح انرژی پایین) قرار می‌گیرند.
- هسته مانند یک آهنربای کوچک عمل می‌کند؛ چون خودش I و MDM (ممان دوقطبی مغناطیسی) دارد، در جهت میدان قرار می‌گیرد ولی نمی‌تواند کاملاً هم‌جهت شود، پس در دو سطح قرار می‌گیرد که اختلاف سطح انرژی ΔE است.

منبع: اسلایدهای MRI دکتر درویش اسلاید ۷ تا ۱۰

• پروتون ها که می چرخند همه در جهت میدان قرار نمی گیرند بعضی از پروتون ها خلاف

شکل – حرکت تقدیمی (Precession) پروتون در میدان مغناطیسی: هسته مثل آهنربای کوچکی می چرخد و ممان مغناطیسی پیدا می کند.

اسلایدهای MRI دکتر درویش ص ۵

- جمعیت پروتون ها در میدان مغناطیسی نامساوی است: تعداد پروتون های Spin Up (هم جهت میدان، سطح انرژی پایین تر) کمی بیشتر از Spin Down است.
- مثال منبع برای نشان دادن این اختلاف بسیار کوچک: اگر «یک میلیون» پروتون اسپین داون داشته باشیم، حدود «یک میلیون و یک» پروتون اسپین آپ داریم.
- هر جفت اسپین آپ/اسپین داون، بردارشان یکدیگر را خنثی می کند؛ تنها پروتون های اضافی (همان اختلاف کوچک) بردار مغناطش خالص (Net Magnetization Vector) را می سازند و در تولید سیگنال نقش دارند.

منبع: ویدیو – دکتر درویش، MRI ۱ (فایل ۰۱) – ۵:۳۵ تا ۶:۱۵

- برای حرکت مداری لازم است: داشتن Angular Momentum (AM) – کمیتی فیزیکی که حرکت چرخشی پروتون ها را بیان می کند و شامل حرکت اسپینی و حرکت مداری یا Precession است.
- داشتن تقارن انرژی (تقارن انرژی علت شکاف بین دو سطح انرژی است).
- وجود نیروی گشتاور عمود بر AM.
- اگر همان میزان انرژی با امواج RF داده شود، Spin up ها همگی Spin down خواهند شد و اگر انرژی قطع شود، Spin ها مجدداً به حالت اولیه خود برمی گردند (RF OFF).

منبع: اسلایدهای MRI دکتر درویش اسلاید ۱۰ تا ۱۲

۴. حرکت تقدیمی (Precession) و فرکانس لارمور

وقتی آهنربای کوچک (هسته) در میدان به راستایی می رسد که قانون کوانتومی را می داند، میدان مغناطیسی تلاش می کند آن را کاملاً به راستا درآورد. نتیجه این عمل، وجود گشتاوری است که سبب می شود هسته حول محور میدان مغناطیسی اصلی حرکت انتقالی یا چرخش فرامحوری/مداری (precession) یابد. فرکانس این حرکت چرخشی، «فرکانس لارمور» (Larmor frequency) نامیده می شود.

منبع: اسلایدهای MRI دکتر درویش اسلاید ۱۳

$$\omega_L = \gamma B_0$$

فرکانس لارمور

ω_L : فرکانس لارمور (فرکانس حرکت تقدیمی هسته)

γ : ضریب ژیرومغناطیسی (MHz/T)

B_0 : شدت میدان مغناطیسی خارجی (Tesla)

منبع: اسلایدهای MRI دکتر درویش اسلاید ۱۳

$$\gamma \text{ (MHz/T)} = \frac{\text{MDM}}{lhbar}$$

ضریب ژیرومغناطیسی

MDM: ممان دوقطبی مغناطیسی

l: اسپین هسته

$\hbar$: ثابت پلانک تقسیم بر 2π

ضریب ژیرومغناطیسی با اینکه نسبت است ولی واحد دارد: Hz/T

منبع: اسلایدهای MRI دکتر درویش اسلاید ۱۳ و ۱۴

نسبت ژیرومغناطیسی برای هر هسته مشخص، مقدار معینی دارد؛ حتی برای ایزوتوپ‌های یک عنصر نیز متفاوت است. بر این اساس هر هسته خاص در میدان مغناطیسی معین، فرکانس لارمور یا حرکت پیشگامی با فرکانس معین خاص خود را خواهد داشت.

منبع: اسلایدهای MRI دکتر درویش اسلاید ۱۴

• پروتون‌ها در حالت عادی که در میدان مغناطیسی نیستند حرکت اسپینی دارند اگر در میدان

شکل — حالت‌های موازی و غیرموازی (Parallel / Anti-parallel) اسپین‌ها نسبت به میدان B_0 و اختلاف انرژی ΔE میان دو حالت.

اسلایدهای MRI دکتر درویش ص ۶

هسته	ضریب ژیرومغناطیسی γ (MHz/T)
H-1	42.6
Na-23	11.3
O-17	5.8

مقادیر نمونه ضریب ژیرومغناطیسی برای سه هسته

منبع: اسلایدهای MRI دکتر درویش اسلاید ۱۴

نکته امتحانی: محاسبه فرکانس لارمور پروتون‌های بدن بیمار در میدان‌های 0.3 T، 1 T و 1.5 T در منبع به‌عنوان تمرین مطرح شده است؛ برای پاسخ کافی است $\omega_L = \gamma B_0$ با $\gamma = 42.6 \text{ MHz/T}$ برای هیدروژن استفاده شود.

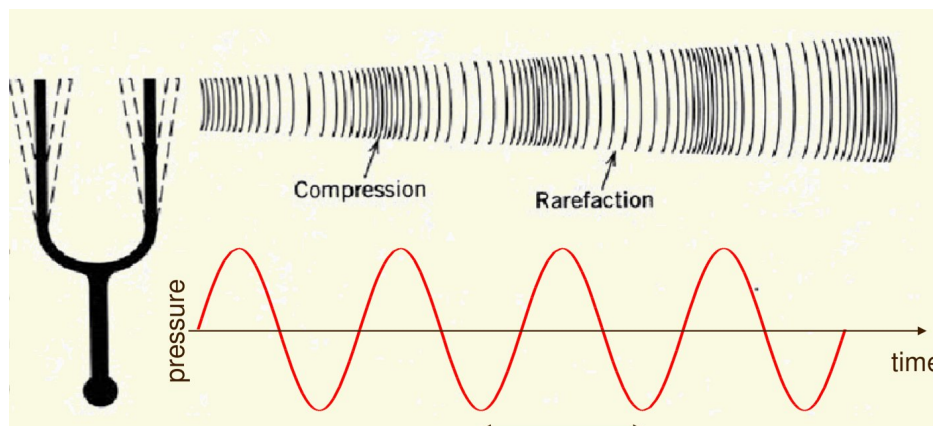
۵. تشدید به‌وسیله امواج رادیویی

• امواج رادیویی که فرستاده می‌شود باعث تشدید می‌شود، چون فرکانس موج رادیویی برابر با فرکانس چرخش هسته است؛ در این حالت تمام Spin up ها Spin down می‌شوند.

• بعد از قطع امواج رادیویی، پروتون‌ها — که در اثر تحریک به سطح انرژی بالا رفته‌اند — تمایل دارند دوباره به سطح انرژی پایین برگردند.

- صرف بودن بیمار در میدان مغناطیسی هیچ سیگنالی تولید نمی‌کند؛ باید از بیرون به بدن بیمار انرژی (امواج رادیویی) داده شود تا پس از تحریک و تشدید، سیگنال دریافت شود.

منبع: اسلایدهای MRI دکتر درویش اسلاید ۱۵ و ۱۶



شکل – تشدید: نیروی محرک سینوسی، ذرات را وادار به نوسان می‌کند؛ در MRI، پالس RF با فرکانس لارمور همین نقش را برای اسپین‌ها دارد.

اسلایدهای M.Ph.D – دکتر حق‌پرست – ص ۶۴

۶. اندازه‌گیری مغناطش بافت (Measuring Tissue Magnetization)

- وقتی M_0 با میدان مغناطیسی B_0 هم‌راستا است، اندازه‌گیری آن بسیار دشوار است، چون خود B_0 میلیون‌ها برابر M_0 قوی‌تر است.
- راه‌حل: M_0 را با یک «تیپ» (tipping) عمود بر B_0 قرار می‌دهند.
- M_0 توسط انفجاری از تابش الکترومغناطیس که معمولاً «پالس RF» نامیده می‌شود، به صفحه عرضی (transverse plane) تیپ می‌شود.
- برای انتقال انرژی، پالس RF باید همان فرکانس M_0 تقدیمی باشد؛ یعنی «فرکانس تشدید» – مشابه آزمایش چنگال تنظیم (tuning fork).

منبع: اسلایدهای MRI دکتر درویش اسلاید ۱۷ تا ۲۰

۷. علت استفاده از هسته هیدروژن در MRI

- فراوان‌ترین هسته در بدن است.
- ضریب ژیرومغناطیسی آن بالاست.
- دارای ممان زاویه‌ای اسپین هسته است ($I = 1/2$).

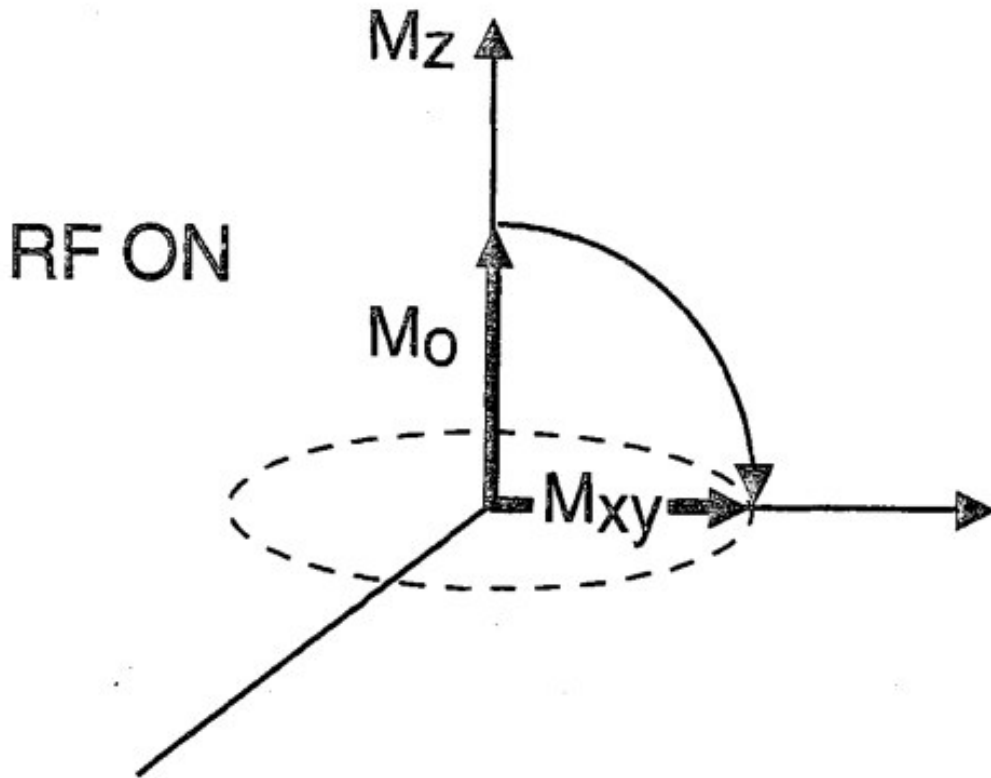
منبع: اسلایدهای MRI دکتر درویش اسلاید ۲۵

۸. ارسال پالس RF و ایجاد مغناطش عرضی

- با ارسال پالس RF دو چیز اتفاق می‌افتد: (۱) دیگر مغناطیس طولی وجود ندارد، چون بردار Net در صفحه x-y منحرف شده است؛ (۲) پروتون‌هایی که قبلاً ناهم‌فاز بودند، حالا هم‌فاز می‌شوند.
- اگرچه پروتون‌ها در جهت میدان قرار گرفته و بردار Net تشکیل شده و از لحاظ فرکانس یکی هستند، زمان شروع حرکت همه پروتون‌ها یکی نیست؛ به همین دلیل ناهم‌فازند.

- به محض قطع کردن پالس RF، دوباره پروتون‌ها ناهم‌فاز می‌شوند.
- وقتی بردار Net منحرف می‌شود، دیگر خود بردار را نداریم، ولی مؤلفه‌های طولی و عرضی داریم.
- پالسی که بردار Net را به میزان 90° درجه منحرف می‌کند، پالس RF 90° نامیده می‌شود.

منبع: اسلایدهای MRI دکتر درویش اسلاید ۲۷ تا ۳۰



شکل - با روشن‌شدن امواج رادیویی (RF ON): بردار مغناطش طولی (M_z) کاهش و مغناطش عرضی (M_{xy}) ایجاد می‌شود.

اسلایدهای MRI دکتر درویش - ص ۱۲، ۳۷، ۴۰، ۴۱، ۴۲، ۴۳، ۵۰ (ص ۱۲)

- پالسی که بردار مغناطش خالص (Net) را 90° درجه منحرف کند «پالس RF 90° » و پالسی که آن را 180° درجه منحرف کند «پالس RF 180° » نامیده می‌شود.
- پس از آن که بردار Net به محور Z بازگردد، همان کوئل فرستنده RF نقش گیرنده سیگنال را بازی می‌کند؛ به همین دلیل در MRI یک کوئل هم فرستنده و هم گیرنده است.
- پیش از ارسال پالس، پروتون‌ها همه روی محور Z (حالت تعادل) هستند؛ با ارسال RF به سطح انرژی بالاتر می‌روند و با قطع پالس به سطح انرژی پایین‌تر برمی‌گردند و انرژی را به محیط می‌دهند.

منبع: منبع: ویدیو - دکتر درویش، ۲ MRI (فایل ۰۲) - ۵:۴۰ تا ۶:۱۸

- هدف در MRI این است که بردار Net منحرف‌شده طوری باشد که مغناطش عرضی عمود بر جهت میدان اصلی قرار گیرد؛ چون در این حالت کوئل فرستنده RF به‌عنوان گیرنده عمل کرده و بیشینه مقدار سیگنال دریافت می‌شود.
- زمانی که NMV روی محور Z است: مغناطش طولی.
- زمانی که NMV روی محور Y است: مغناطش عرضی.

منبع: اسلایدهای MRI دکتر درویش اسلاید ۳۰ و ۳۱

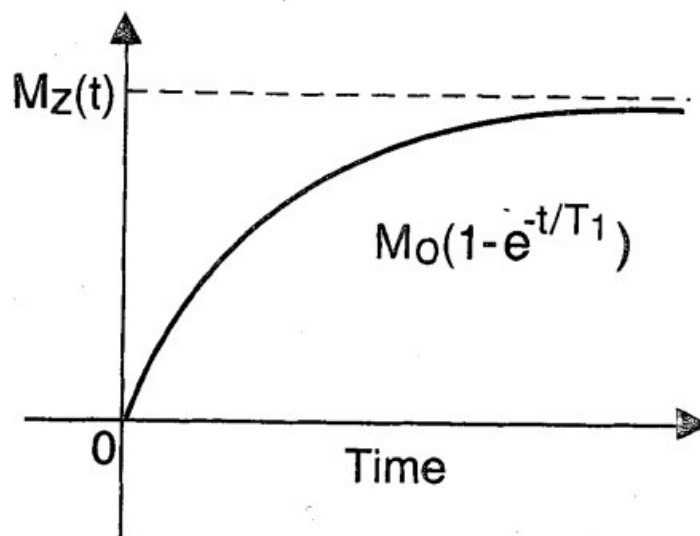
۹. زمان‌های آسایش T1 و T2 و چگالی پروتون (PD)

پس از خاموش شدن پالس RF، اسپین‌ها ناهم‌فاز می‌شوند و به پایین‌ترین سطح انرژی برمی‌گردند. این دو مورد هم‌زمان اما به صورت مستقل اتفاق می‌افتد: جزء Mxy بردار مغناطش عرضی به سرعت کاهش می‌یابد و جزء Mz به آهستگی در امتداد محور Z بازیافت می‌شود.

منبع: اسلایدهای MRI دکتر درویش اسلاید ۳۲ و ۳۳

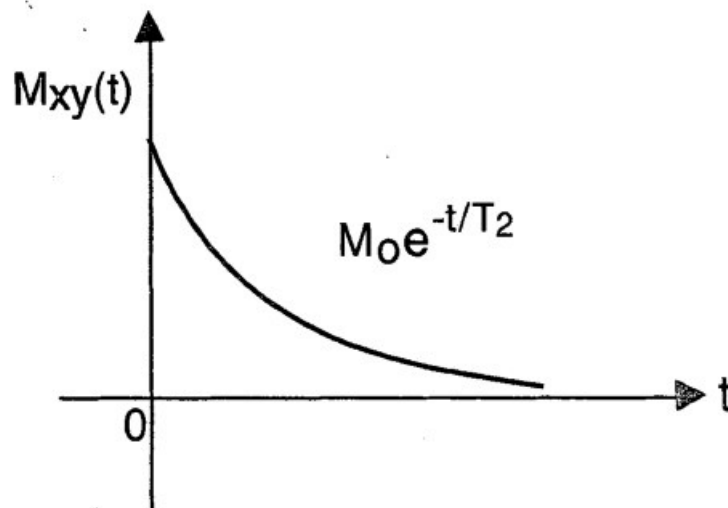
- زمان آسایش T1: مدت زمانی است که طول می‌کشد تا 63% بردار مغناطش طولی احیا شود.
- زمان آسایش T2: مدت زمانی است که در آن تنها 37% بردار مغناطش عرضی هم‌فاز باقی مانده‌اند.
- T1: زمان آسایش طولی = زمان آسایش اسپین-اسپین (longitudinal relaxation time = spin-lattice relaxation time).
- T2: زمان آسایش عرضی = زمان آسایش اسپین-اسپین (spin-spin relaxation time).
- ثابت زمانی که سرعت بازیافت جزء Mz به M0 را بیان می‌کند، زمان آسایش T1 است.
- ثابت زمانی که سرعت کاهش جزء Mxy را نشان می‌دهد، زمان آسایش T2 است.
- فروپاشی T2 حدود ۵ تا ۱۰ برابر سریع‌تر از بازیافت T1 اتفاق می‌افتد.
- بازیافت مغناطش در امتداد محور Z و فروپاشی مغناطش در صفحه x-y دو فرایند هم‌زمان و مستقل‌اند و مقدار متفاوتی دارند.

منبع: اسلایدهای MRI دکتر درویش اسلاید ۳۳ تا ۴۰



شکل - بازیابی مغناطش طولی در T1: منحنی نمایی $M_z(t) = M_0 (1 - e^{-t/T_1})$ با گذشت زمان (Time).

اسلایدهای MRI دکتر درویش ص ۳۷



شکل - افت مغناطش عرضی در T_2 : منحنی نمایی $M_{xy}(t) = M_0 e^{-t/T_2}$ با گذشت زمان.

اسلایدهای MRI دکتر درویش ص ۴۰

سازوکار کنتراست: چرا بافت‌ها در T_1 و T_2 روشن یا تیره می‌شوند (از ویدیو)

- برای ساختن تصویر T_1 از «چگونگی از دست دادن انرژی» استفاده می‌شود؛ برای T_2 از «هم‌فازی/ناهم‌فازی» پروتون‌ها استفاده می‌شود.
- اگر هم‌فازی زیاد باشد (پروتون‌ها هم‌فاز باشند) سیگنال و تصویر روشن/سفید، و اگر ناهم‌فازی زیاد باشد تصویر تیره می‌شود.
- انتقال انرژی اسپین به محیط اطراف (شبکه/lattice) کلید T_1 است: هرچه این انتقال مؤثرتر باشد، T_1 کوتاه‌تر و بافت در تصویر T_1 روشن‌تر می‌شود.

منبع: منبع: ویدیو - دکتر درویش، ۳ MRI (فایل ۰۳) - ۰۰:۱۴ تا ۰۳:۳۶

بافت (مثال منبع)	فرکانس مولکولی نسبت به فرکانس لارمور ω_L	انتقال انرژی	T_1 و ظاهر در تصویر T_1
آب و مایعات (مایع مغزی-نخاعی)	بسیار بیشتر از ω_L	ناکارآمد (inefficient)	T_1 بسیار بلند → تیره
بافت جامد/متراکم مانند کلسیم و استخوان	کمتر از ω_L	ناکافی	T_1 بلند → تیره
چربی و مواد پروتئینی	تقریباً برابر با ω_L	مؤثر	T_1 کوتاه → روشن/سفید

منبع: منبع: ویدیو - دکتر درویش، ۳ MRI (فایل ۰۳) - ۰۱:۱۳ تا ۰۳:۰۹

$$M_z(t) = M_0 (1 - e^{-t/T_1})$$

بازیافت مغناطش طولی

Mz: مؤلفه بردار Net روی محور z بعد از قطع RF

t: زمان بعد از قطع پالس RF

M0: مقدار اولیه بردار Net

T1: زمان آسایش که در آن هسته انرژی خود را به محیط داده است

منبع: اسلایدهای MRI دکتر درویش اسلاید ۳۶ و ۳۷

در امتحان می‌آید

۱۰. کنتراست بافت‌های مختلف در تصاویر MRI

T1 هر بافتی فرق می‌کند و T1 بافت‌های مختلف متفاوت است؛ پس کنتراست بافت‌های متفاوت با هم فرق می‌کند و همین تفاوت T1 بافت‌های مختلف است که تصویر را می‌سازد. زمان‌های آسایش T1 و T2 خصوصیات ذاتی بافت‌ها هستند و در یک میدان مغناطیسی معین برای یک بافت خاص ثابت‌اند.

منبع: اسلایدهای MRI دکتر درویش اسلاید ۳۴ و ۳۵

- در T1، 63% پروتون‌ها بعد از گذشت یک T1 به حالت انرژی اولیه برگشته‌اند و انرژی به محیط داده‌اند؛ مقدار این انرژی کم است و باعث گرم شدن بدن بیمار نمی‌شود (به خاطر امواج RF ممکن است بدن بیمار گرم شود).
- T1 هر بافت فرق می‌کند؛ پس با تفاوت T1 بافت‌های مختلف، تصویر و کنتراست ایجاد می‌شود.
- وزن‌دهی تصویر (T1-weighted، T2-weighted و Proton Density) بر همین تفاوت زمان‌های آسایش و چگالی پروتون استوار است.

منبع: اسلایدهای MRI دکتر درویش اسلاید ۳۵ و ۴۵ تا ۴۸

- روش تشخیص وزن تصویر در عمل: اول رنگ مایع (CSF) را در تصویر ببینید. اگر CSF تیره بود، تصویر T1 است؛ اگر روشن بود، تصویر T2 است.
- معمولاً T1 تصویر آناتومی را نشان می‌دهد و T2 تصویر پاتولوژی را — چون بیشتر پاتولوژی‌ها بر محتوای آب بافت اثر می‌گذارند (ادم، تجمع مایع): در T1 تیره و در T2 روشن دیده می‌شوند.
- نمونه بالینی منبع: در برشی که سینوس فرونتال را قطع می‌کند، هوا در T1 تیره است؛ اگر در سینوس تجمع مایع (سینوزیت) رخ داده باشد، در T1 تیره و در T2 روشن دیده می‌شود؛ با مقایسه‌ی کنار هم دو تصویر، سینوزیت تشخیص داده می‌شود.
- پروتون‌دستی بیشتر برای بافت‌هایی به کار می‌رود که همه‌شان در طیف خاکستری دیده می‌شوند؛ کاربرد منبع: تصویربرداری مفاصل و اندام‌های فوقانی و تحتانی.

منبع: منبع: ویدیو — دکتر درویش، ۳ MRI (فایل ۰۳) — ۰۵:۰۸ تا ۰۹:۳۵

نکته کلیدی: چرا 63% استاد در ویدیو توضیح می‌دهد که بازگشت ۶۳ درصدی مغناطش طولی، همان زمانی است که بهترین و قابل‌اعتمادترین سیگنال T1 به دست می‌آید؛ عدد 37% باقی‌مانده مغناطش عرضی (T2) هم به همین منطق انتخاب شده است — این دو عدد را با هم جابه‌جا نکنید.

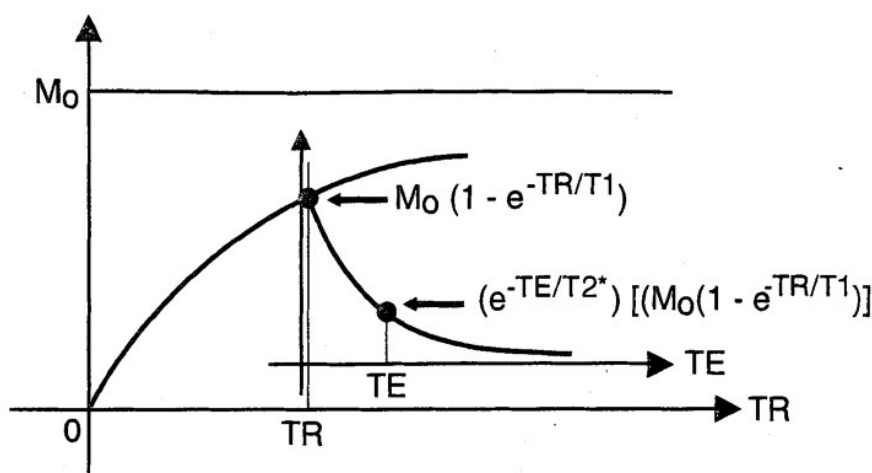
کمیت	معنا در منبع
TR (Time of Repetition)	فاصله زمانی بین ارسال دو پالس RF: ارسال پالس RF → گرفتن سیگنال → دوباره ارسال RF
TE (Time of Echo)	فاصله زمانی پالس تا وسط اکو

منبع: اسلایدهای MRI دکتر درویش اسلاید ۴۳ و ۴۴

دستور گرفتن تصاویر وزن دار: کوتاه/بلند کردن TR و TE (از ویدیو)

تنظیم تکنیک	نوع تصویر	توضیح
TR کوتاه + TE کوتاه	تصویر وزن دار T1 (T1-weighted)	مؤلفه T1 قوی و مؤلفه T2 ضعیف می شود
TR بلند + TE بلند	تصویر وزن دار T2 (T2-weighted)	T1 ضعیف و T2 قوی می شود
TR بلند + TE کوتاه	تصویر چگالی پروتون (Proton Density)	هر دو مؤلفه T1 و T2 ضعیف می شوند

منبع: منبع: ویدیو - دکتر درویش، ۳ MRI (فایل ۰۳) - ۰۰:۰۰ تا ۰۱:۱۰

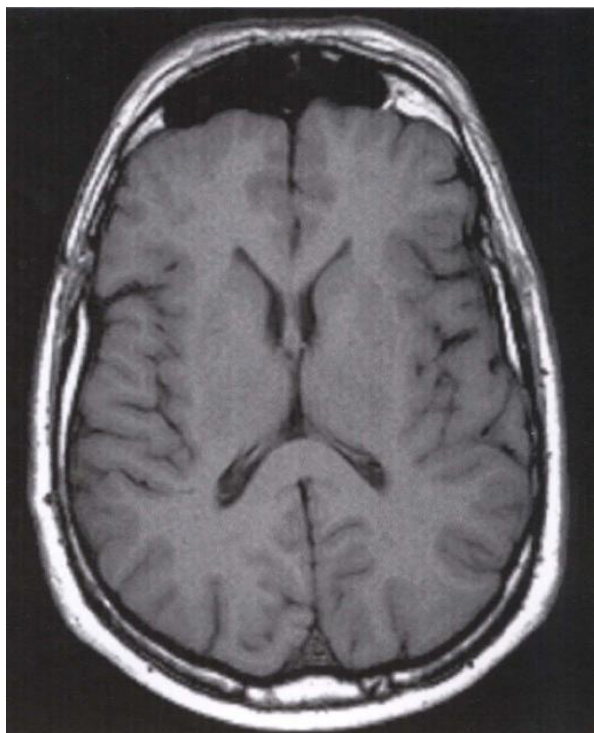


شکل - تعریف زمان های TR و TE روی توالی پالس ها و تعیین وزن دهی تصویر (T1، T2 یا PD).

اسلایدهای MRI دکتر درویش - ص ۱۲، ۳۷، ۴۰، ۴۱، ۴۲، ۴۳، ۵۰ (ص ۴۲)

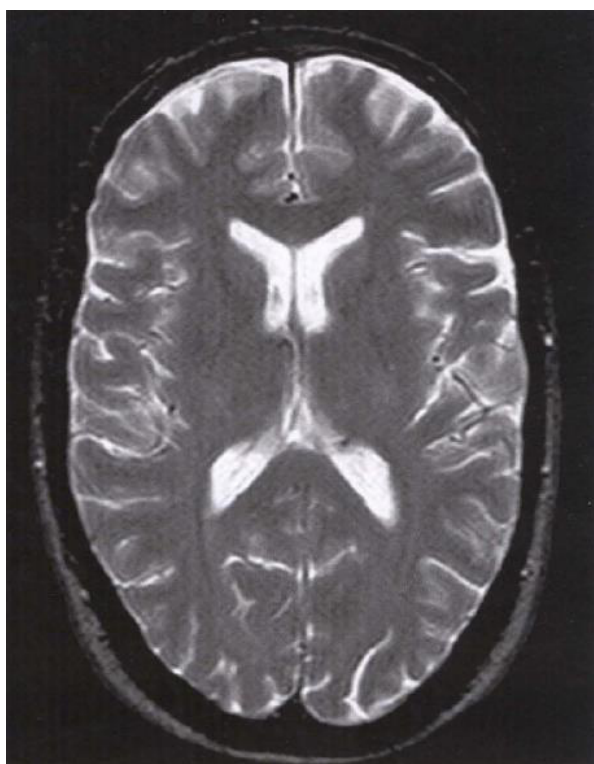
- کاربرد بالینی Proton Density: در تصویر PD اکثر بافت ها خاکستری دیده می شوند؛ بیشتر برای مفاصل و اندام های تحتانی و فوقانی استفاده می شود.
- مثال بالینی تشخیصی: برشی که از سینوس فرونتال رد شده است - هوا در T1 تیره می افتد؛ اگر تجمع مایع یا چرک (سینوزیت) وجود داشته باشد، در T1 همچنان تیره ولی در T2 سفید می شود؛ کنار هم گذاشتن تصویر T1 و T2 به تشخیص پاتولوژی می انجامد.

منبع: منبع: ویدیو - دکتر درویش، ۳ MRI (فایل ۰۳) - ۰۷:۵۶ تا ۰۹:۳۲



شکل منبع ۷ - تصویر مغز با وزن دهی T1.

اسلایدهای MRI دکتر درویش اسلاید ۴۶



شکل منبع ۸ - تصویر مغز با وزن دهی T2.

اسلایدهای MRI دکتر درویش اسلاید ۴۷

This is an axial T1-weighted MRI scan of the brain. The image shows a cross-section of the brain at the level of the lateral ventricles. The brain parenchyma appears normal with no significant abnormalities. The lateral ventricles are visible in the center, and the surrounding brain tissue shows normal signal intensity for T1-weighted imaging.

اسلایدهای MRI دکتر درویش اسلاید ۴۸

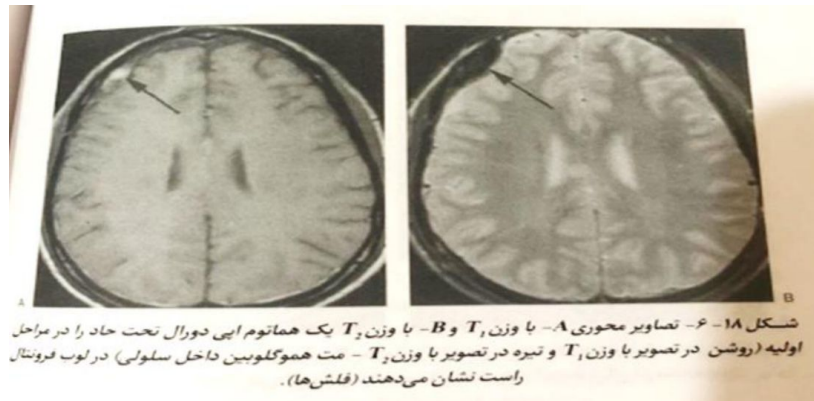
Sharp T1 (high SI)	Sharp T1 (high SI)	Sharp T1 (high SI)
Water T2 CSF	Water T2 CSF	Water T2 CSF
Yellow	Yellow	Yellow
Pathology	Pathology	Pathology
Edema	Edema	Edema
Muscle	Muscle	Muscle
Intermediate	Intermediate	Intermediate
GM	GM	GM
a (oxyHgb)	a (oxyHgb)	a (oxyHgb)
WM	WM	WM
Fat	Fat	Fat
Sharp T2 (low SI)	Sharp T2 (low SI)	Sharp T2 (low SI)
Proteinaceous solution	Proteinaceous solution	Proteinaceous solution
Cortical bone	Cortical bone	Cortical bone
c (TC, mcl Hgb)	c (TC, mcl Hgb)	c (TC, mcl Hgb)
Heavy Ca	Heavy Ca	Heavy Ca
Paramagnetic materials	Paramagnetic materials	Paramagnetic materials
h (deoxyHgb)	h (deoxyHgb)	h (deoxyHgb)
(Gd, etc.)	(Gd, etc.)	(Gd, etc.)
e (hemosiderin)	e (hemosiderin)	e (hemosiderin)
Fibrosis	Fibrosis	Fibrosis

اسلایدهای MRI دکتر درویش - ص ۱۲، ۳۷، ۴۰، ۴۱، ۴۲، ۴۳، ۵۰ (ص ۵۰)

۱۱. کنتراست خونریزی در MRI

خون وقتی از رگ خارج می‌شود، بسته به روزهایی که از خونریزی می‌گذرد، به رنگ‌های مختلف دیده می‌شود. حالات مختلف خون پس از خارج شدن از رگ (A تا E) با تغییر شکل هموگلوبین و ترکیب آن با اکسیژن توضیح داده می‌شود؛ این تغییر بر الکترون آزاد و ترکیب شدن آن به O2 بستگی دارد.

منبع: اسلایدهای MRI دکتر درویش اسلاید ۵۰ و ۵۱



شکل - کنتراست خونریزی در MRI: سیگنال در T_1 و T_2 برحسب روزهای گذشته از خونریزی و نوع هموگلوبین (دکسی‌هموگلوبین، متهموگلوبین داخل/خارج سلولی و هموسیدرین) تغییر می‌کند.

اسلایدهای MRI دکتر درویش ص ۵۱

جدول زمانی خونریزی با رنگ هر مرحله (از ویدیو)

زمان پس از خونریزی	نوع هموگلوبین	وضعیت RBC	T1	T2
کمتر از ۱ روز	اکسی‌هموگلوبین	سالم	خاکستری	خاکستری
۱ تا ۲ روز	دی‌اکسی‌هموگلوبین	سالم	تیره	تیره
۲ تا ۱۴ روز	متهموگلوبین داخل سلولی	تخریب شده	سفید	تیره
۱۴ تا ۲۱ روز	متهموگلوبین خارج سلولی	تخریب شده	سفید	سفید
بیشتر از ۲۱ روز	هموسیدرین	تخریب شده	تیره	تیره

منبع: منبع: ویدیو - دکتر درویش، ۳ MRI (فایل ۰۳) - ۰۹:۳۵ تا ۱۰:۴۴

مرحله	نوع هموگلوبین	وضعیت RBC	ظاهر در T1 و T2
خون‌ریزی کمتر از یک روز	oxy Hb	سالم است	در T1 و T2 خاکستری
خون‌ریزی تا روز دوم	deoxy Hb	سالم است	در T1 و T2 تیره
از روز دوم تا چهاردهمین روز	Intracellular met Hb	—	در T1 سفید، T2 تیره
از روز 14 تا 21	Extracellular met Hb	—	در T1 و T2 سفید
بیشتر از 21 روز	Hemosiderin	—	در T1 و T2 تیره (long T1, Short T2)

منبع: اسلایدهای MRI دکتر درویش اسلاید ۵۱

۱۲. محدودیت‌ها و اثرات جانبی احتمالی میدان و گرادیان‌ها

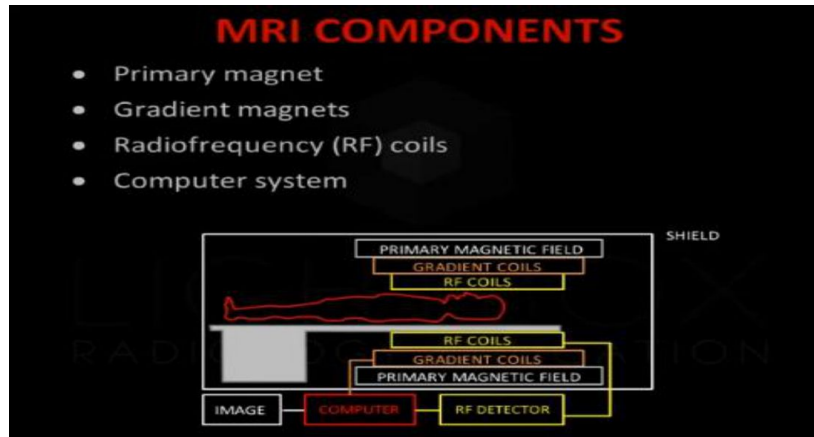
- شیب میدان مغناطیسی می‌تواند در اعصاب تأثیر بگذارد و باعث Action Potential شود و آن را تحت تأثیر قرار دهد.
- میدان مغناطیسی که خیلی قوی باشد ممکن است باعث اثرات بدی روی قلب شود.
- تغییر میدان مغناطیسی (شیب میدان) و پالس‌های RF می‌توانند بدن بیمار را گرم کنند.

منبع: اسلایدهای MRI دکتر درویش اسلاید ۲۶ و ۳۵

۱۳. دستگاه MRI و اجزای آن (از ویدیو)

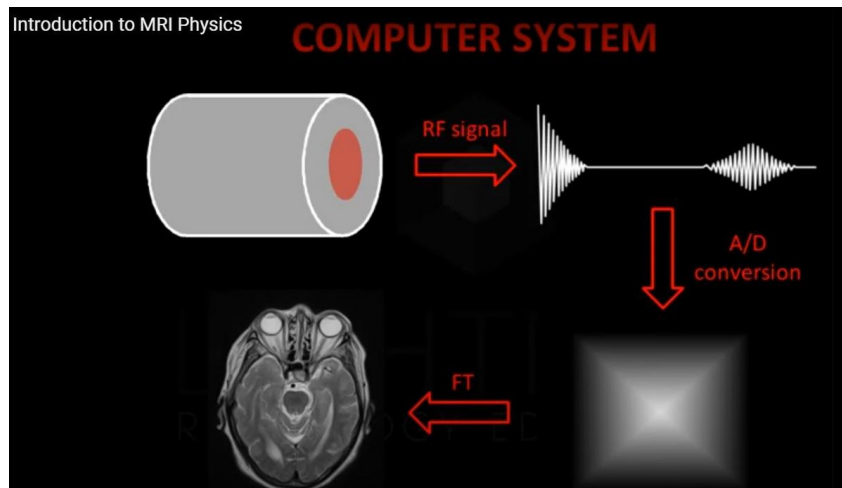
- پایه‌ی دستگاه MRI، «مگنت اصلی» (Primary Magnet) است؛ همان میدان مغناطیسی اصلی و اولیه که بیمار در آن قرار می‌گیرد.
- «کوئل گرادیان» (Gradient Coil): سیم‌پیچ‌هایی که میدان مغناطیسی را در جهت خاص تغییر می‌دهند؛ در اصطلاح به میدان «شیب» می‌دهند. همین شیب میدان است که تشخیص موقعیت مکانی (فضایی) سیگنال‌ها را ممکن می‌کند.
- «کوئل RF» (Radiofrequency Coil): سیم‌پیچ فرستنده/گیرنده‌ی امواج رادیویی؛ انرژی فرکانس رادیویی را به بیمار می‌فرستد و سیگنال برگشتی را دریافت می‌کند.
- سیستم کامپیوتری: سیگنال دریافتی را پردازش و به تصویر تبدیل می‌کند.

منبع: منبع: ویدیو — دکتر درویش، MRI ۱ (فایل ۰۱) — ۰۰:۱۰ تا ۰۰:۴۴



شکل – اجزای دستگاه MRI: آهنربای اصلی (Primary magnet)، کوئل‌های گرادیان، کوئل‌های فرکانس رادیویی (RF)، سیستم کامپیوتری و تخت بیمار.

اسلایدهای MRI دکتر درویش ص ۲



شکل – سیستم کامپیوتری MRI: ارسال سیگنال RF، دریافت سیگنال و تبدیل آن به تصویر.

اسلایدهای MRI دکتر درویش – ص ۱۲، ۳۷، ۴۰، ۴۱، ۴۲، ۴۳، ۵۰ (ص ۴۳)

- کوئل‌گرادیان میدان مغناطیسی را «شیب» می‌دهد؛ همین شیب است که تعیین موقعیت مکانی را ممکن می‌کند: محور Z در طول قد بیمار، محور Y جلو و عقب و محور X چپ و راست.
- هشدار ایمنی: میدان مغناطیسی بسیار قوی و شیب‌های میدان می‌توانند روی قلب و اعصاب اثر بگذارند؛ به همین دلیل در MRI محدودیت‌های ایمنی (از جمله پایش بیماران قلبی) رعایت می‌شود.
- در حالت تعادل، فرکانس تقدیمی همه پروتون‌ها یکسان است اما هم‌فاز نیستند؛ با ارسال پالس RF هم‌فاز می‌شوند و با قطع پالس بلافاصله ناهم‌فاز می‌شوند – همین ناهم‌فازی، سیگنال T2 را می‌سازد.

منبع: منبع: ویدیو – دکتر درویش، ۲ MRI (فایل ۰۲) – ۰۲:۱۳ تا ۰۴:۵۱

۱۴. قواعد اسپین هسته و کدام هسته‌ها سیگنال می‌دهند؟ (از ویدیو)

وضعیت عدد جرمی (A) و عدد اتمی (Z)	اسپین هسته (I)	نتیجه
هم فرد هم فرد (A فرد، Z فرد)	$I = \frac{1}{2}$ یا مضربی از $\frac{1}{2}$	سیگنال می‌دهد - مثال: Al-27, Na-23, H-1
Z فرد و A زوج	I عدد صحیح	سیگنال می‌دهد - مثال: N-14, H-2
هم A زوج هم Z زوج (همه پروتون‌ها جفت شده)	$I = 0$	خاصیت مغناطیسی ندارد و در MRI کاربرد ندارد - مثال: C-12, O-16

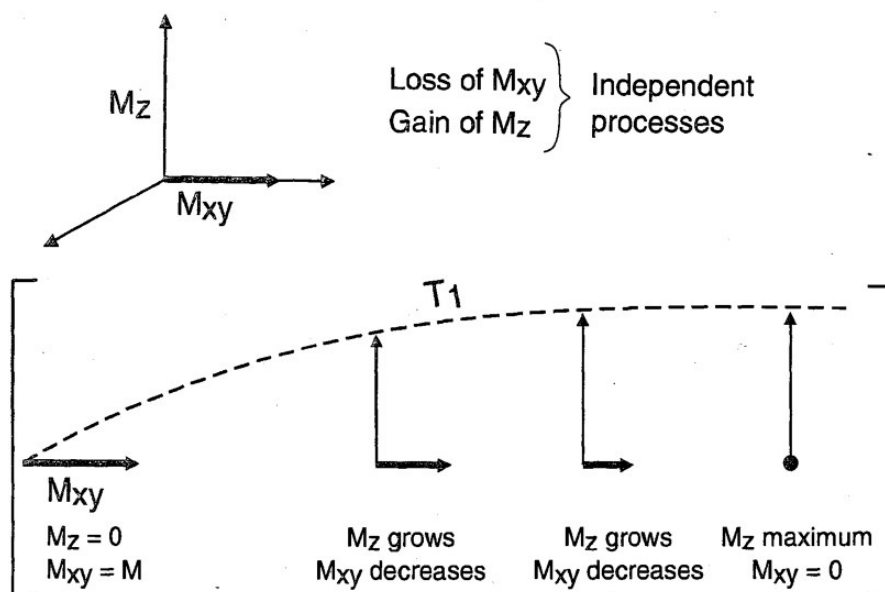
منبع: منبع: ویدیو - دکتر درویش، MRI ۱ (فایل ۰۱) - ۵۸:۰۰ تا ۲۷:۰۲

نکته کلیدی: همه‌ی پروتون‌ها سیگنال نمی‌دهند؛ فقط پروتونی سیگنال می‌دهد که «تشدید» برایش رخ داده باشد - یعنی فرکانس موج رادیویی فرستاده شده دقیقاً با فرکانس لارمور آن پروتون برابر باشد. در مثال منبع، از میان پروتون‌های A تا E تنها پروتون B (که فرکانس لارمورش با فرکانس RF یکی بود) سیگنال داد.

۱۵. سازوکار مولکولی کنتراست T1 و T2 (از ویدیو)

- T1 از «چگونگی از دست دادن انرژی» ساخته می‌شود؛ سرعت این انتقال انرژی به محیط (Lattice)، زمان آسایش T1 را تعیین می‌کند.
- T2 از «هم‌فازی و ناهم‌فازی» پروتون‌ها ساخته می‌شود: هم‌فازی زیاد → سیگنال سفید، ناهم‌فازی زیاد → سیگنال تیره.

منبع: منبع: ویدیو - دکتر درویش، MRI ۳ (فایل ۰۳) - ۱۳:۰۱ تا ۳۷:۰۳



شکل - دو فرایند مستقل و مکمل در زمان آسایش: افت مغناطش عرضی (Loss of M_{xy}) که زمان T2 را می‌سازد و رشد (بازگشت) مغناطش طولی (Gain of M_z) که زمان T1 را می‌سازد؛ T1 از انتقال انرژی به محیط (Lattice) و T2 از هم‌فازی/ناهم‌فازی پروتون‌ها می‌آید.

اسلایدهای MRI دکتر درویش - ص ۱۲، ۳۷، ۴۰، ۴۱، ۴۲، ۴۳، ۵۰ (ص ۴۱)

رنگ در تصویر	T2	T1	وضعیت فرکانس مولکول نسبت به فرکانس لارمور	بافت
T1 تیره / T2 سفید	بلند (ناهم‌فازی کم)	بسیار بلند	فرکانس حرکت مولکول بسیار بیشتر از فرکانس لارمور → انتقال انرژی به محیط بسیار کم	آب و مایعات (CSF)
T1 سفید / T2 خاکستری	متوسط	کوتاه	فرکانس مولکول تقریباً برابر فرکانس لارمور → انتقال انرژی مؤثر	چربی و مواد پروتئینی
در هر دو تیره	کوتاه (ناهم‌فازی زیاد)	بلند	فرکانس مولکول کمتر از فرکانس لارمور → انتقال انرژی ناکافی	جامدات (کلسیم، استخوان متراکم)

منبع: منبع: ویدیو - دکتر درویش، ۳ MRI (فایل ۰۳) - ۱۳:۰۱ تا ۲۹:۰۴

نکته کلیدی: در تصادف و ترومای حاد، نخستین انتخاب CT-اسکن است، نه MRI: در CT خونریزی در هفته‌ی اول سفید و واضح دیده می‌شود، ولی در MRI روزهای اول خونریزی خاکستری/تیره است. (توالی رنگ CT خونریزی: هفته اول سفید، ۷ تا ۱۴ روز تقریباً «ایزودنس» و همرنگ مغز، بیشتر از ۱۴ روز تیره.) انتخاب تصویربرداری برای خانم باردار هم بر پایه‌ی اصل توجیه‌پذیری انجام می‌شود.

مرور سریع

- انرژی‌های MRI: میدان مغناطیسی و امواج رادیویی (هر دو غیریونیزان).
- اسپین هسته: A و Z فرد → I مضرب 1/2 (H-1، Na-23، Al-27): زوج-زوج → I = 0 (بدون کاربرد در MRI)؛ Z فرد و A زوج → I عدد صحیح (H-2، N-14).
- دو سطح انرژی: Spin up (انرژی کم) و Spin down (انرژی زیاد) با اختلاف ΔE .
- $\omega_L = \gamma B_0$ ؛ γ برای H-1 برابر 42.6 MHz/T، برای Na-23 برابر 11.3 MHz/T و برای O-17 برابر 5.8 MHz/T.
- رزونانس: فرکانس پالس RF = فرکانس تقدیمی؛ Spin up ها به Spin down می‌روند.
- پالس RF 90 بردار Net را ۹۰ درجه منحرف می‌کند؛ پس از قطع پالس: ناهم‌فازی اسپین‌ها + بازگشت به سطح انرژی پایین.
- T1: بازگشت 63% مغناطش طولی (spin-lattice)؛ T2: باقی‌ماندن 37% مغناطش عرضی هم‌فاز (spin-spin)؛ فروپاشی T2 حدود ۵ تا ۱۰ برابر سریع‌تر از بازیافت T1.
- TR: فاصله بین دو پالس RF؛ TE: فاصله پالس تا وسط اکو.
- تصاویر وزن‌دار T1، T2 و PD از تفاوت زمان‌های آسایش و چگالی پروتون بافت‌ها ساخته می‌شوند.
- خون‌ریزی: oxy Hb خاکستری، deoxy Hb تیره، intracellular met Hb (T1 سفید و T2 تیره)، extracellular met Hb سفید، hemosiderin تیره (long T1, short T2).

HumsYar

H U M S Y A R

پایان جزوه فیزیک پزشکی

این جزوه از تلفیق جزوه‌های درسی، پاورپوینت‌های اسلاید و ویدیوهای تدریس سه استاد (دکتر
افضلی‌پور، دکتر لیلی درویش و دکتر حق‌پرست) تهیه شده است.
۱۳۰ صفحه ۵۵۱۰ بخش ۸۸۰ شکل ۴۵۰ جدول ۱۹۰ ویدیو (۷ ساعت تدریس)

همه مطالب با ذکر منبع (جزوه/اسلاید/ویدیو) آورده شده‌اند؛ هیچ مطلبی خارج از منابع درس افزوده نشده است.
برای مرور نهایی: جعبه‌های «نکته کلیدی»، بخش‌های «مرور سریع» و صفحه راهنمای دکتر درویش را ببینید.